

Pla d'atenció a les persones afectades de malaltia de Parkinson i parkinsonismes atípics de Catalunya

Agost de 2026



**Generalitat
de Catalunya**

Aquest projecte ha estat finançat a càrrec dels fons per a les estratègies 2024 del Ministeri de Sanitat, que van ser aprovats al CISNS en data 14/06/2024, com a suport a la implementació de l'estratègia enfront de les malalties neurodegeneratives.

Pla d'atenció a les persones afectades de malaltia de Parkinson i parkinsonismes atípics de Catalunya

Coordinació:

Cristina Lasmarías Martínez. Equip de Transformació de l'Atenció Intermèdia. Departament de Salut.

Belén Enfedaque Montes. Subdirectora general de la Cartera de Serveis i Anàlisi de la Informació. Direcció General de Planificació en Salut. Departament de Salut.

Cristina Isern Arabia. Programa de malalties neurodegeneratives. Pla director sociosanitari. Direcció General de Planificació en Salut. Departament de Salut.

Oriol Garcia Codina. Responsable d'Informació i Metodologia per a la Planificació i l'Avaluació. Direcció General de Planificació en Salut. Departament de Salut.

Irene Lana Lander. Programa temporal per a la millora de la qualitat de vida de persones amb esclerosi lateral amiotròfica (ELA) i altres malalties o processos d'alta complexitat i curs irreversible. Direcció General de Planificació en Salut. Departament de Salut.

David Garcia Sánchez. Programa de malalties neurodegeneratives. Pla director sociosanitari. Direcció General de Planificació en Salut. Departament de Salut.

Gemma Giráldez Navas. Direcció General de Planificació en Salut.

Autoria:

Aquest document ha estat elaborat pel grup motor de professionals experts format per:

Ana Cámara. Hospital Clínic de Barcelona

Antonia Campolongo. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Yaroslau Compta. Hospital Clínic de Barcelona

Marta Isabel de la Ossa. Hospital Clínic de Barcelona

Ma José Durà Mata. Hospital Germans Trias i Pujol

Sonia Escalante. Institut Català de la Salut

Almudena Garnica. Hospital Universitari Sant Joan de Reus

Jorge Herrero Hernando. Hospital Clínic de Barcelona

Elena León. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Emma Ludeña. Hospital Clínic de Barcelona

Inés Martín. Hospital Clínic de Barcelona

Saül Martínez Horta. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Montserrat Masó. Direcció General de Planificació en Salut, Departament de Salut

Maria Victoria Mir. Institut Català de la Salut

Laura Morer Benages. Associació Catalana per al Parkinson

Pla d'atenció a les persones afectades de malaltia de Parkinson i parkinsonismes atípics de Catalunya

Raquel Nieto Marina. Institut Català de la Salut

Pablo Peret. Hospital Clínic de Barcelona

Rocio Puig. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Íngrid Quiñoa. Hospital Clínic de Barcelona

Juan Deniel Rosanas. Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària

Jesús Miguel Ruiz. Hospital Mare de Déu de la Mercè

Berta Solano. Institut Català de la Salut (ICS) Girona

Susana Villote. Hospital Clínic de Barcelona

Revisors i col·laboradors del Departament de Salut:

Àrea Assistencial d'Atenció Intermèdia del Servei Català de la Salut.

Direcció Estratègica d'Atenció Primària i Comunitària. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya

Equip d'Atenció Integrada Social i Sanitària. Direcció General de Planificació en Salut. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya

Equip per la transformació de l'Atenció Intermèdia. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya

Gerència de Processos Integrats de Salut. Servei Català de la Salut. Departament Salut. Generalitat de Catalunya

Pla director de salut mental i addiccions. Direcció General de Planificació en Salut. Departament Salut. Generalitat de Catalunya

Secretaria d'Atenció Sanitària i Participació. Departament Salut. Generalitat de Catalunya

Subdirecció General de Planificació Sanitària. Direcció General de Planificació en Salut. Departament Salut. Generalitat de Catalunya

Han participat com a revisors externs:

Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya (AIFiCC)

Comitè de Bioètica de Catalunya

Consell Assessor de l'Atenció Intermèdia

Consell Consultiu de Pacients

Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya

Consorci de Salut i Social de Catalunya

Col·legi de Farmacèutics de Barcelona

Pla d'atenció a les persones afectades de malaltia de Parkinson i parkinsonismes atípics de Catalunya

Col·legi de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya (COTOC)

Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya

Societat Catalana de Geriatria i Gerontologia

Societat Catalana de Medicina d'Urgències i Emergències (SOCMUE)

Societat Catalana de Neurologia

Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental

Societat Catalano-Balear de Cures Pal·liatives (SCBCP)

Unió Catalana d'Hospitals

Han participat les associacions de familiars següents relacionades amb aquest àmbit:

Associació Catalana per al Parkinson (ACAP)

Associació Gironina de Parkinson

Associació Parkinson de les Terres de Lleida

Associació Parkinson Maresme

Associació Parkinson Sant Cugat

Associació Parkinson Terres de l'Ebre

Fundació Catalunya La Pedrera

Assessorament metodològic:

José Antonio Hernández Martín, Daniel Martínez Gamote, Rita López Ramos, Sira Gardela May, Inés Allés Martín, Ariadna Solé Rodríguez

Pla d'atenció a les persones afectades de malaltia de Parkinson i parkinsonismes atípics de Catalunya

Alguns drets reservats

© 2026, Generalitat de Catalunya. Departament de Salut



Els continguts d'aquesta obra estan subjectes a una llicència de Reconeixement-NoComercial-SenseObresDerivades 4.0 Internacional.

La llicència es pot consultar a la pàgina [web de Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Unitat promotora:

Direcció General de Planificació en Salut. Departament de Salut

1a edició:

Barcelona, agost de 2026

Assessorament editorial:

Gabinet del Conseller. Serveis editorials

Assessorament lingüístic:

Servei de Planificació Lingüística del Departament de Salut

Pla editorial 2026:

Núm. de registre: 16776

DOI: 10.62727/DSalut/15004

Sumari

1.	Resum executiu	10
2.	Introducció	11
3.	Objectius	12
4.	Anàlisi de situació	13
4.1	Malaltia de Parkinson	13
4.2	Els parkinsonismes atípics a Catalunya	19
5.	Principis que defineixen el model d'atenció	26
6.	El procés d'atenció de les persones afectades per la MP i els PA	27
6.1	Diagnòstic de la MP i dels PA	27
6.1.1	Identificació precoç dels signes i símptomes de la MP i els PA	28
	Taula 1. Signes i símptomes de la MP i PA	28
6.1.2	Consideracions en el procediment diagnòstic	29
	Taula 2. Signes i símptomes característics de la MP i els PA i especialitats i/o serveis	31
6.2	Confirmació diagnòstica en els serveis especialitzats en neurologia	31
6.2.1	Confirmació del diagnòstic	32
	Taula 3. Proves d'imatge i signes específics dels PA	33
6.2.2	Visita d'informació del diagnòstic	34
6.3	Atenció inicial a les persones amb la MP o les PA	34
	Taula 4. Eines de valoració de persones amb MP o PA	35
6.4	Tractament integral de la MP i dels PA	36
6.4.1	Activitats de promoció de la salut i de prevenció bàsiques	36
6.4.2	Tractament farmacològic	37
6.4.3	Tractament no farmacològic	38
6.5	Seguiment de les persones amb MP o PA	39
6.5.1	Abordatge de les complicacions de la MP i dels PA	39
a)	Complicacions motores en la MP	39

Pla d'atenció a les persones afectades de malaltia de Parkinson i parkinsonismes atípics de Catalunya

b)	Complicacions no motores en la MP	39
c)	Complicacions motores i no motores dels PA.....	40
6.5.2	Malaltia avançada i final de vida	40
6.6	Suport a l'entorn familiar i de cura	41
7.	Recursos i integració assistencial	42
7.1	Equips d'atenció primària i comunitària	42
7.2	Serveis hospitalaris de neurologia	43
7.3	Centres, serveis i unitats de referència (CSUR) en l'àmbit de la MP i PA.....	44
7.4.	Recursos d'atenció intermèdia.....	45
7.5	Altres recursos que poden intervenir.....	46
7.6	Integració assistencial	47
8.	Registre de la informació i seguiment de la MP i dels PA de Catalunya	48
9.	Formació i promoció del coneixement de la MP i dels PA	49
10.	Recerca bàsica i aplicada.....	50
11.	Línies estratègiques del Pla	51
Figura 1. Estructura del Pla d'atenció sanitària a les persones afectades de MP i PA de Catalunya		51
Figura 2. Línies estratègiques del Pla d'atenció sanitària a les persones afectades de MP i PA de Catalunya		
Línia estratègica 1. Diagnòstic precoç de la MP i dels PA.....		51
Línia estratègica 2. Tractament integral de la MP i dels PA		52
Línia estratègica 3. Atenció continuada centrada en la persona amb MP o PA.....		53
Línia estratègica 4. Atenció en la fase avançada de la malaltia o en situació de final de vida		55
Línia estratègica 5. Suport a l'entorn familiar o de cura.....		55
Línia estratègica 6. Formació i promoció del coneixement de la MP i PA.....		56
Línia estratègica 7. Àmbits assistencials		57
Línia estratègica 8. Registre de la MP i dels PA de Catalunya.....		59
Línia estratègica 9. Foment de la recerca bàsica i aplicada		59
12.	Avaluació del Pla	59

13.	Escenaris de futur.....	63
14.	Bibliografia	64
15.	Annexos	68
	Annex 1. Criteris de diagnòstic clínic de la MDS per a la MP	68
	Annex 2. Criteris de diagnòstic clínic de la MDS per a l'AMS	71
	Annex 3. Criteris de diagnòstic clínic de la MDS per a la PSP	71
	Annex 4. Criteris de diagnòstic clínic de la MDS per a la DCB.....	72
	Annex 5. Procés diagnòstic de la MP i dels PA en l'atenció especialitzada	73
	Annex 6. Eines de valoració de persones amb MP o PA	75
	Annex 7. Pla de cures estàndard dirigit a la persona afectada de MP a l'APiC	76
	Annex 8. Criteris del qüestionari CEPA per al diagnòstic de la MP avançada	82
	Annex 9. Fluctuacions i discinèsies.....	84
	Annex 10. Tractaments farmacològics dels símptomes motors de la MP	85
	Annex 11. Tractaments farmacològics dels símptomes motors dels PA.....	86
	Annex 12. Algoritme terapèutic de la malaltia de Parkinson.....	88
	Annex 13. Algoritme per al tractament de la MP en fase moderada: teràpies de segona línia o complexes	89
	Annex 14. Recomanació de tractament segons la presència de complicacions motores en MP ...	89
	Annex 15. Tractaments farmacològics dels símptomes no motors	90
	Annex 16. Les intervencions de rehabilitació en MP i PA.....	91
	Annex 17. Abordatge de la disfàgia	95
	Annex 18. Escala de sobrecàrrega del cuidador	96
	Annex 19. Glossari de sigles i acrònims	98

1. Resum executiu

La malaltia de Parkinson és una de les malalties neurodegeneratives amb més prevalença en el nostre entorn. El Pla d'atenció sanitària a persones amb malaltia de Parkinson (MP) i parkinsonismes atípics (PA) —atròfia multisistèmica (AMS), paràlisi supranuclear progressiva (PSP) i degeneració corticobasal (DCB)— és el marc d'actuació per atendre de manera integral les persones afectades al llarg de la seva vida. Aquestes malalties neurodegeneratives tenen un alt impacte social i sanitari i requereixen una resposta coordinada, multidisciplinària i centrada en la persona.

El Pla d'atenció inclou un conjunt de mesures que comprenen l'organització de l'atenció, el model d'atenció integral (biopsicosocial i funcional), la continuïtat assistencial i l'equitat territorial.

El Pla, que s'emmarca en l'Estratègia nacional de malalties neurodegeneratives, té l'objectiu de garantir una atenció de qualitat, equitativa, eficaç, continuada i de proximitat.

El Pla preveu nou línies estratègiques:

1. Diagnòstic precoç de la MP i els PA.
2. Tractament integral de la MP i els PA.
3. Atenció continuada i centrada en la persona.
4. Atenció a les fases avançades i persones en situació de final de vida.
5. Suport a l'entorn de cura i als convivents amb persones amb MP o PA.
6. Formació i promoció del coneixement de la MP i dels PA.
7. Definició, composició i funcions dels àmbits assistencials principals.
8. Registre de la MP i dels PA de Catalunya.
9. Foment de la recerca bàsica i aplicada.

Aquestes línies es concreten en 23 projectes operatius i 77 actuacions específiques, amb indicadors clau per a l'avaluació del Pla. El model promou l'ordenació dels recursos per donar resposta a les necessitats de la persona i el seu entorn, la planificació de decisions anticipades (PDA), el respecte de l'autonomia del pacient, la continuïtat laboral quan sigui possible i l'atenció continuada fins a les fases més avançades de la malaltia.

2. Introducció

El Pla d'atenció a les persones afectades de malaltia de Parkinson (MP) i parkinsonismes atípics (PA) de Catalunya s'emmarca dins l'Estratègia nacional de malalties neurodegeneratives del Sistema Nacional de Salut. Els PA inclosos en el pla són l'atròfia multisistèmica (AMS), la paràlisi supranuclear progressiva (PSP) i la degeneració corticobasal (DCB).

La MP és un dels trastorns neurodegeneratius més prevalents a Catalunya. Els símptomes principals són tremolor de repòs (a les mans, els braços, les cames, la mandíbula i/o el cap), rigidesa (engarrotament de les extremitats i el tronc), lentitud en els moviments i inestabilitat postural (deteriorament de l'equilibri). Els símptomes no motors, com ara apatia, depressió o trastorns del son, poden estar presents des de l'inici de la malaltia. A mesura que la malaltia avança, les persones afectades també poden tenir dificultats per caminar, parlar o fer tasques senzilles.

Els PA presenten semblances amb la MP, sobretot a l'inici de la malaltia, com la rigidesa i les dificultats en la marxa i l'equilibri, si bé hi ha factors clínics i neuropatogènics que els diferencien de la MP. Un bon diagnòstic és clau per donar resposta adequada a les necessitats que comporta cadascuna de les malalties.

Fins al moment, la MP i els PA no tenen curació; tanmateix, hi ha tractaments que n'alenteixen la progressió, controlen i alleugen els símptomes i milloren la qualitat de vida.

La MP és una malaltia amb una evolució força llarga. La supervivència de MP nou anys després del diagnòstic és del 100 % en persones de menys de 45 anys i disminueix amb l'edat; en persones de 75 anys i més, és del 25 %. En canvi, els PA presenten una evolució més ràpida i agressiva, per la qual cosa la seva supervivència és notablement inferior.

Aquest document defineix el pla d'atenció a les persones afectades per MP i PA i al seu entorn de cura. El Pla ofereix un marc d'actuació compartit per tal de garantir l'equitat i la qualitat de l'atenció que reben les persones i el seu entorn de cura en totes les fases de la malaltia, des de la detecció precoç fins a l'atenció al final de la vida. En el procés d'elaboració del Pla han participat pacients, famílies, professionals i entitats de pacients. El Pla ha estat elaborat per un grup interdisciplinari amb professionals i representants d'associacions, als quals agraïm la participació.

3. Objectius

Objectiu general:

Garantir que les persones amb Parkinson i parkinsonismes atípics i el seu entorn de cura reben una atenció de qualitat, equitativa, eficaç, continuada i de proximitat.

Objectius específics:

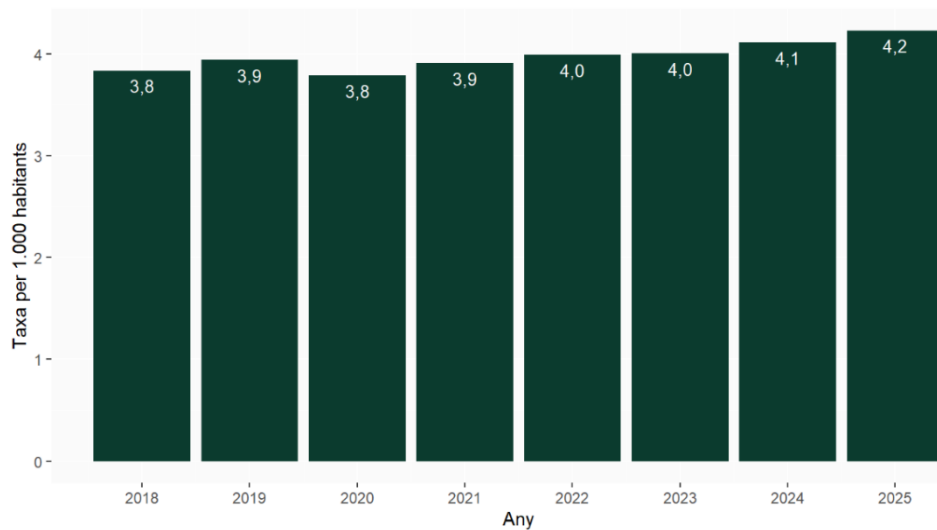
- Garantir un diagnòstic precoç i una atenció especialitzada a les persones afectades per MP i PA, mitjançant equips de referència multidisciplinaris que treballen de manera coordinada i integrada amb els recursos sanitaris i socials de proximitat del territori.
- Promoure una atenció integrada i coordinada entre els serveis sanitaris i socials per assegurar la continuïtat assistencial i la personalització dels serveis, tant en l'àmbit hospitalari com en el domiciliari.
- Impulsar la formació i capacitat dels professionals sanitaris i socials i de la ciutadania per tal de garantir una atenció basada en l'evidència i l'empatia en tot el procés, i la promoció i el respecte de l'autonomia de les persones.
- Facilitar la participació activa de les persones afectades, les seves famílies i les entitats del tercer sector en el disseny, la implementació i l'avaluació del Pla, per assegurar que les polítiques públiques responen a les seves necessitats reals.
- Fomentar la investigació biomèdica, clínica, social i de serveis, per avançar en el coneixement de la MP i els PA i en el desenvolupament de nous models d'atenció i de suport.
- Garantir suport emocional, social i espiritual a les persones afectades i a les seves famílies i entorn de cura, especialment en el moment del diagnòstic i durant l'evolució de la malaltia i en el final de vida.

4. Anàlisi de situació

4.1 Malaltia de Parkinson

La taxa de prevalença de la MP s'ha mantingut força constant a Catalunya els últims anys. L'any 2025 és de 4,2 casos per cada 1.000 habitants (4,1 per cada 1.000 dones i 4,4 per cada 1.000 homes).

Gràfic 1. Evolució de la taxa de prevalença de MP per cada 1.000 habitants. Catalunya, 2018-2025



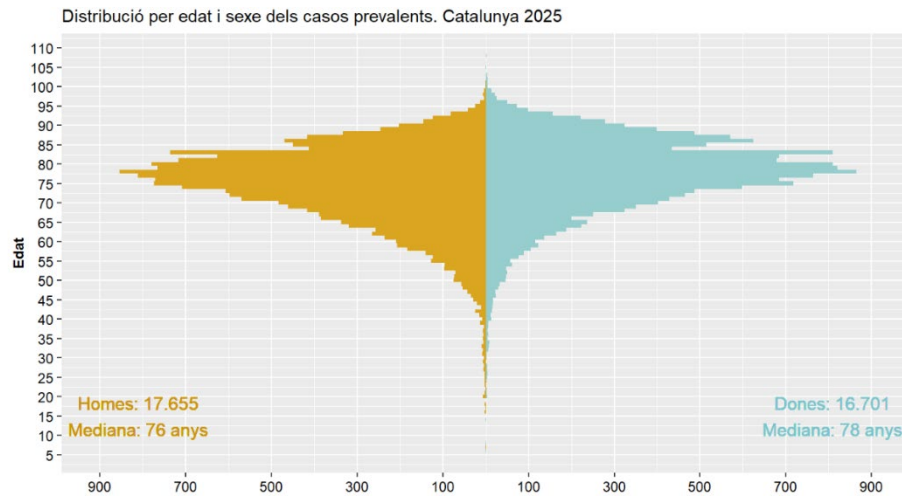
Font: Registre de morbiditat i utilització de serveis sanitaris de Catalunya (MUSSCAT) (2025)

Això representa que l'any 2025 hi ha un total de 34.356 persones (16.701 dones i 17.655 homes) amb MP a Catalunya. L'edat mediana dels homes amb MP és de 76 anys i de 78 anys en les dones. Tant en els homes com en les dones, el grup poblacional amb més taxa de prevalença és el de 85 a 89 anys.

La prevalença de la MP segueix un gradient segons el nivell socioeconòmic: les persones amb un nivell socioeconòmic més baix presenten taxes de prevalença superiors.

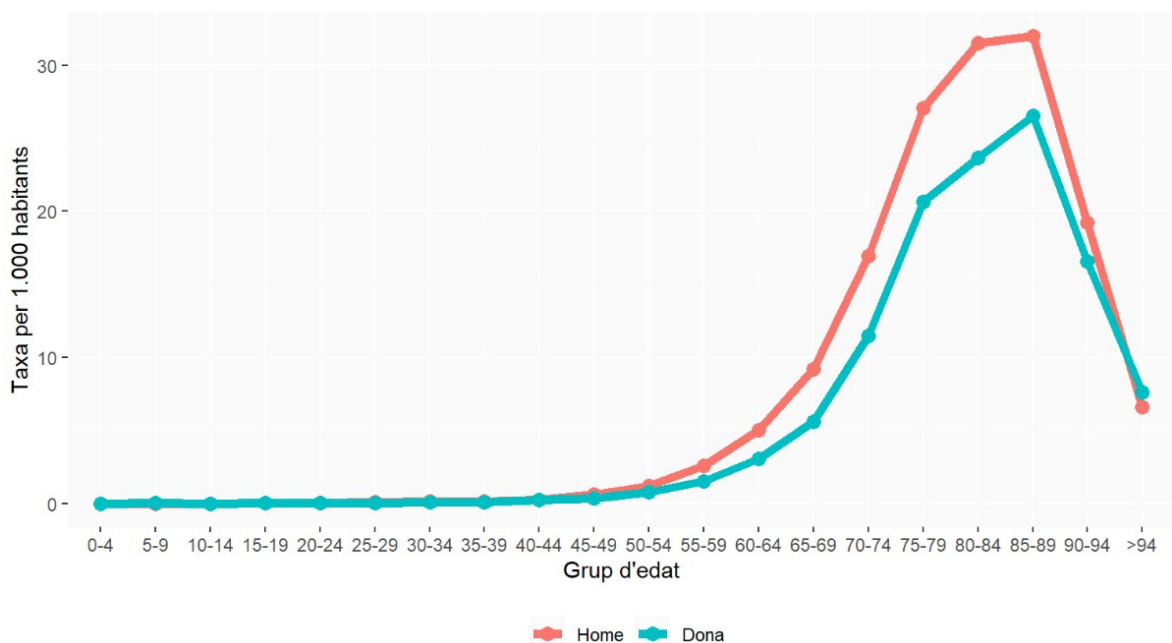
Pla d'atenció a les persones afectades de malaltia de Parkinson i parkinsonismes atípics de Catalunya

Gràfic 2. Distribució per edat i sexe dels casos prevalents de persones amb Parkinson a Catalunya (2025)



Font: Registre de morbiditat i utilització de serveis sanitaris de Catalunya (MUSSCAT) (2025)

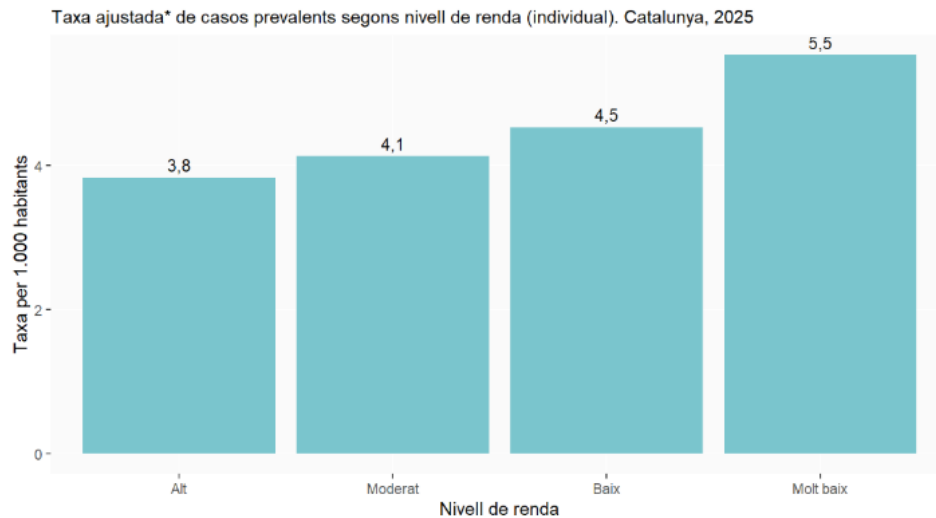
Gràfic 3. Taxa de prevalença de la MP per grup d'edat i sexe a Catalunya (2025)



Font: Registre de morbiditat i utilització de serveis sanitaris de Catalunya (MUSSCAT) (2025)

Pla d'atenció a les persones afectades de malaltia de Parkinson i parkinsonismes atípics de Catalunya

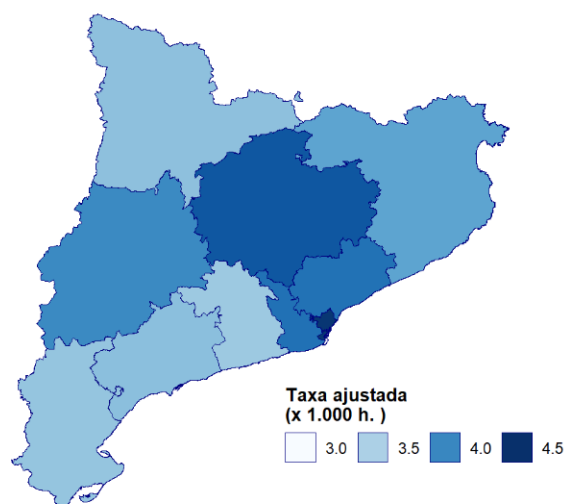
Gràfic 4. Taxa ajustada de casos prevalents de la MP segons el nivell socioeconòmic a Catalunya (2025)



Font: *Registre de morbiditat i utilització de serveis sanitaris de Catalunya (MUSSCAT) (2025)*

La distribució territorial de les taxes de prevalença de la MP mostra una distribució heterogènia per regió sanitària (RS). La RS Barcelona Ciutat i la RS Catalunya Central tenen les taxes més altes, mentre que la regió de Terres de l'Ebre, Alt Pirineu i Aran, i Penedès presenten les més baixes.

Mapa 1. Taxa ajustada de casos prevalents de la MP per regions sanitàries a Catalunya (2025)

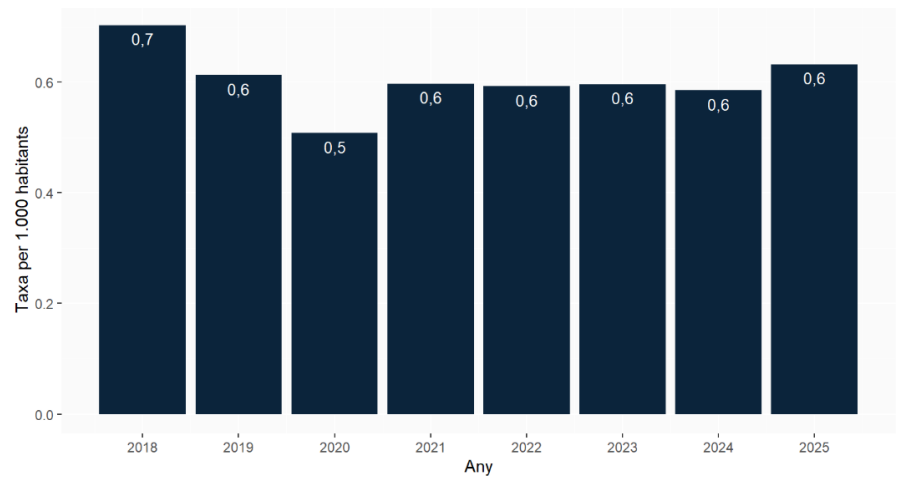


Font: *Registre de morbiditat i utilització de serveis sanitaris de Catalunya (MUSSCAT) (2025)*

Pla d'atenció a les persones afectades de malaltia de Parkinson i parkinsonismes atípics de Catalunya

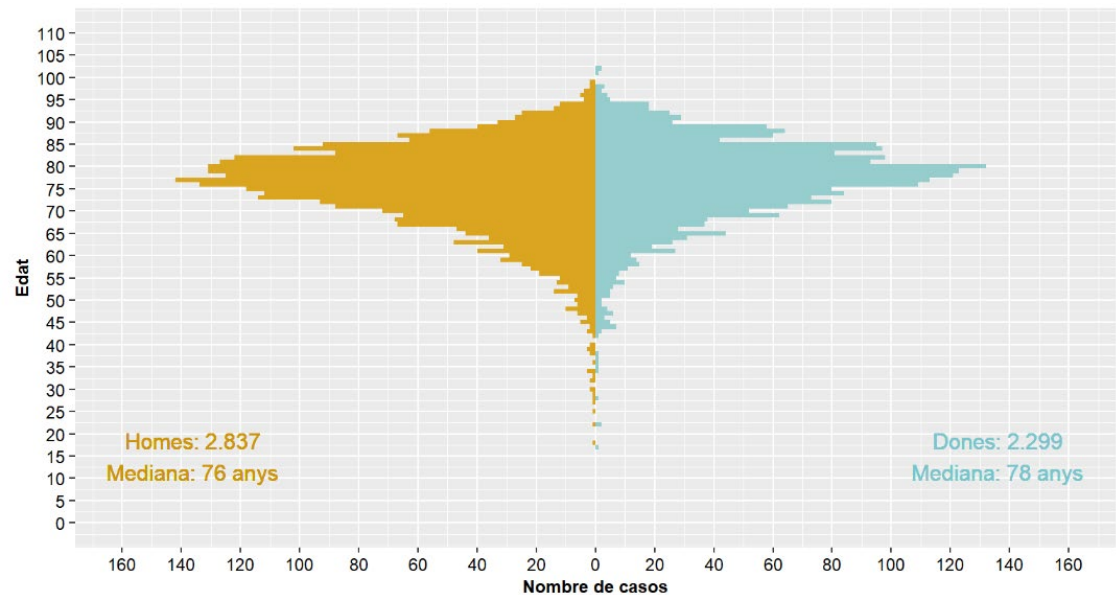
La taxa d'incidència de la MP durant l'any 2025 és de 0,6 per cada 1.000 habitants. Aquesta taxa suposa un petit descens respecte dels anys anteriors. En ambdós sexes s'observa la taxa d'incidència més elevada al grup de 85 a 89 anys.

Gràfic 5. Evolució de la taxa d'incidència de la MP per cada 1.000 habitants. Catalunya (2018-2025)



Font: Registre de morbiditat i utilització de serveis sanitaris de Catalunya (MUSSCAT) (2025)

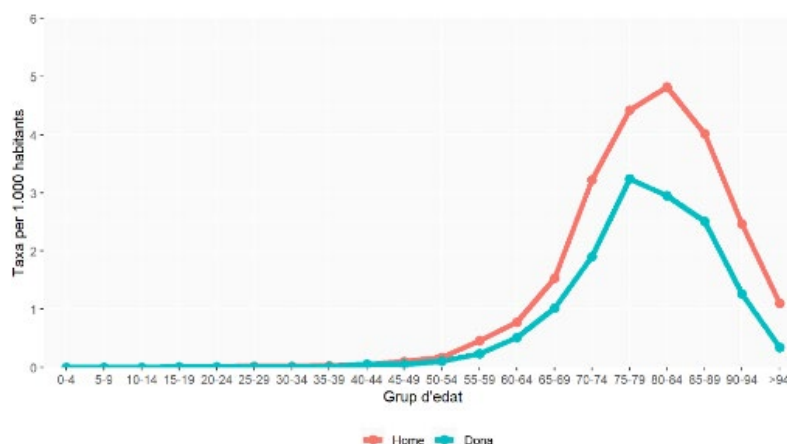
Gràfic 6. Distribució per edat i sexe dels casos incidents de la MP. Catalunya (2025)



Font: Registre de morbiditat i utilització de serveis sanitaris de Catalunya (MUSSCAT) (2025)

Pla d'atenció a les persones afectades de malaltia de Parkinson i parkinsonismes atípics de Catalunya

Gràfic 7. Taxa d'incidència per grup d'edat i sexe a Catalunya (2025)

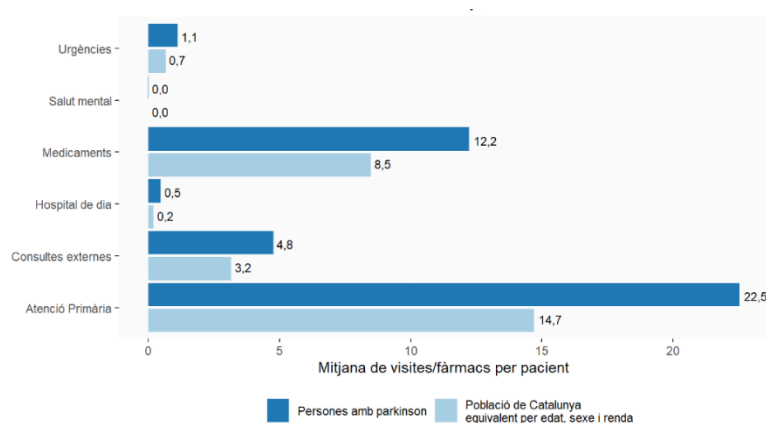


Font: Registre de morbiditat i utilització de serveis sanitaris de Catalunya (MUSSCAT) (2025)

El pronòstic del Parkinson varia en funció de les característiques clíniques i demogràfiques, la genètica i els determinants ambientals als quals s'ha vist exposada la persona afectada (Bloem et al., 2021).

Les persones amb MP fan un ús més elevat dels serveis sanitaris i consumeixen més medicaments que la població equivalent per edat, sexe i nivell de renda ([vegeu el gràfic 9](#)).

Gràfic 8. Utilització dels recursos sanitaris ambulatoris de les persones amb MP i la població equivalent. Catalunya (2025)

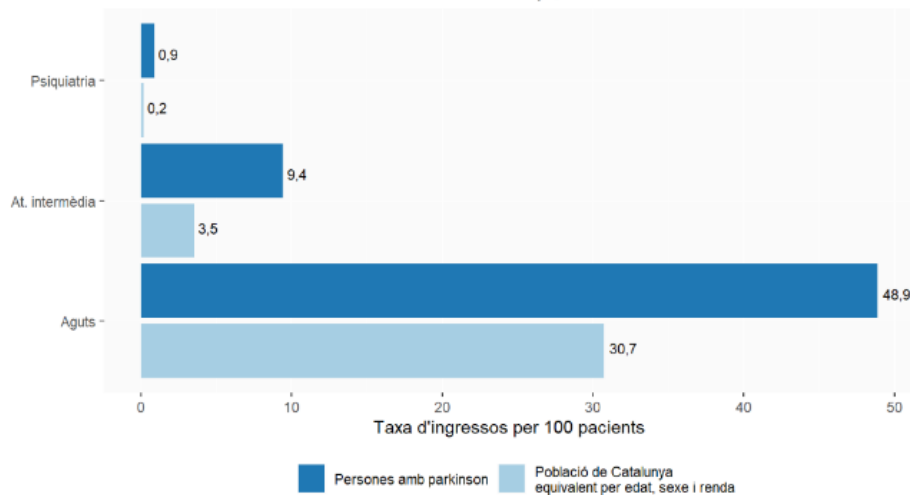


Font: Registre de morbiditat i utilització de serveis sanitaris de Catalunya (MUSSCAT) (2025)

Les persones amb MP presenten una taxa d'ingressos més elevada tant en centres d'atenció intermèdia com en hospitals d'aguts que la població equivalent.

Pla d'atenció a les persones afectades de malaltia de Parkinson i parkinsonismes atípics de Catalunya

Gràfic 9. Utilització dels recursos sanitaris d'internament de les persones amb MP i la població equivalent. Catalunya (2025)

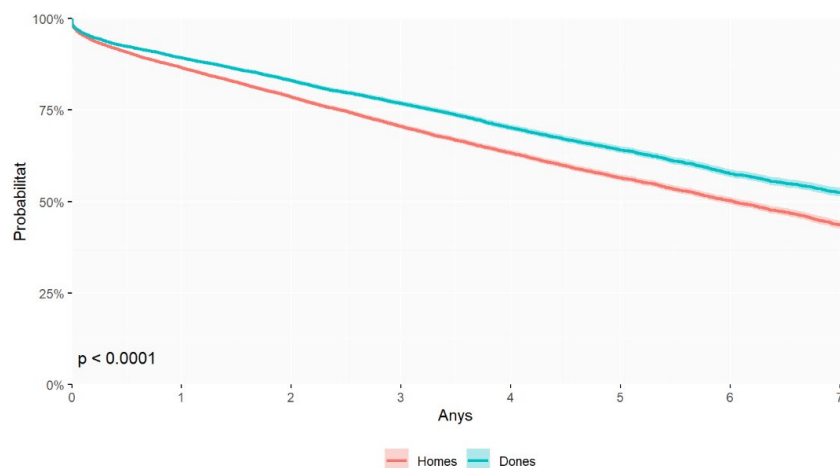


Font: Registre de morbiditat i utilització de serveis sanitaris de Catalunya (MUSSCAT) (2025)

Les persones amb MP tenen una taxa de mortalitat més elevada que la població equivalent per edat, sexe i nivell de renda. La mortalitat l'any 2025 en persones amb MP és del 9,97.

La supervivència dels homes amb MP és més baixa que la de les dones. La supervivència als set anys és del 43 % en els homes i del 52 % en les dones.

Gràfic 10. Supervivència a llarg termini dels nous casos de la MP segons el sexe, a Catalunya (2018-2025)



Font: Registre de morbiditat i utilització de serveis sanitaris de Catalunya (MUSSCAT) (2025)

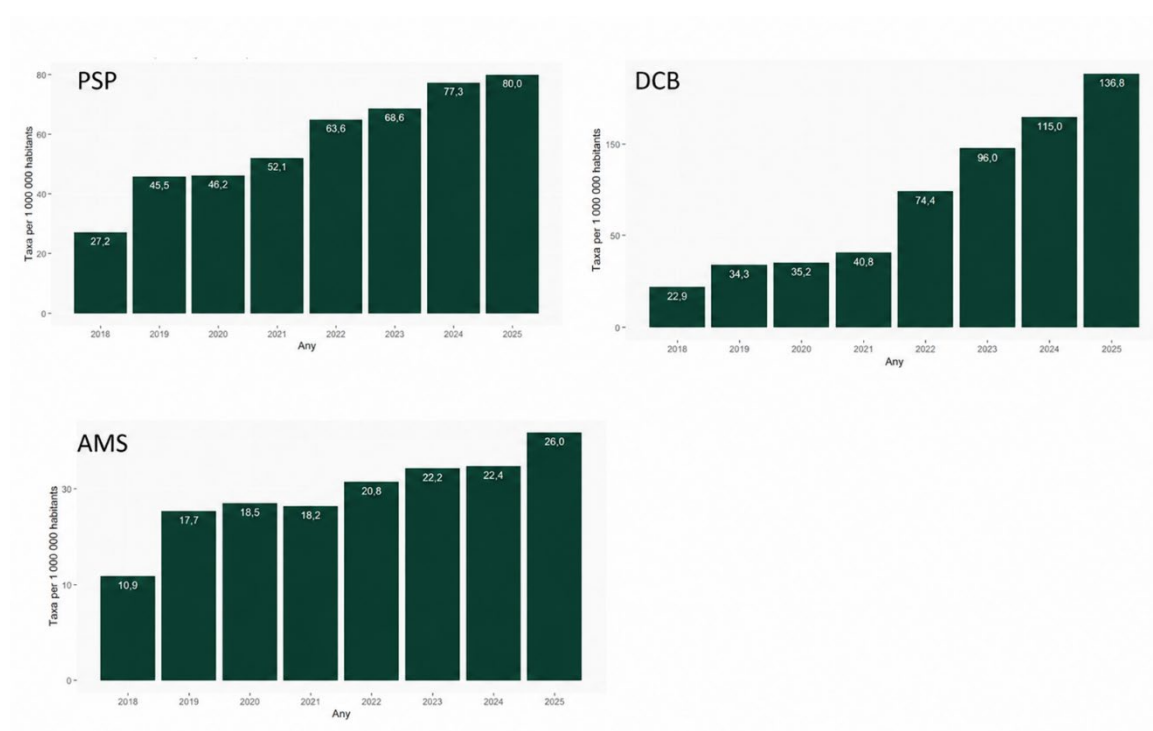
4.2 Els parkinsonismes atípics a Catalunya

Els parkinsonismes atípics (PA) són malalties minoritàries. A Catalunya, la DCB és el parkinsonisme atípic amb més prevalença el 2025 (138,8 casos per milió d'habitants), seguida de la PSP (80 casos per milió) i de l'AMS, que és el PA menys prevalent (26 casos per milió). La prevalença de PA en dones se situa lleugerament per sobre de la dels homes. El nombre de casos incidents de la DCB el 2025 va ser de 233 homes i 208 dones; de 121 homes i 79 dones en la PSP, i de 31 homes i 22 dones en l'AMS.

L'edat mediana dels homes amb DCB és de 76 anys, mentre que en dones és de 81. En el cas de la PSP, l'edat mediana en homes és de 74 i de 77 en dones. Pel que fa a l'AMS, l'edat mediana en homes és 68 i de 73 en dones. La prevalença de PA és més elevada en els grups de 75 a 84 anys.

Només la prevalença de la DCB segueix un gradient socioeconòmic, amb més prevalença en el grup de menys renda.

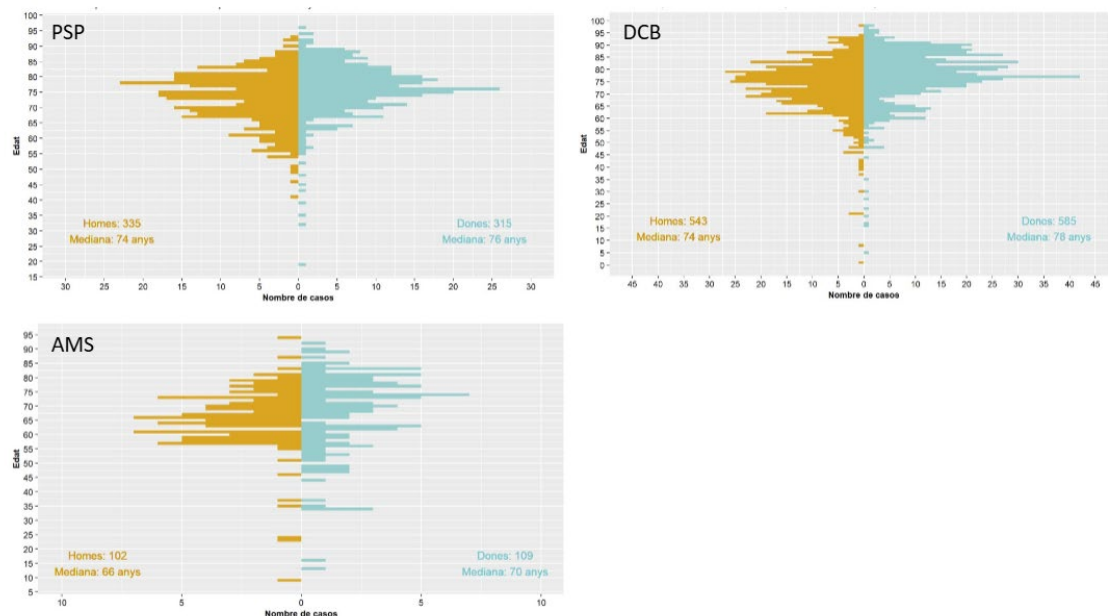
Gràfic 11. Evolució de les taxes de prevalença dels PA per cada 1.000.000 habitants. Catalunya (2018-2025)



Font: Registre de morbiditat i utilització de serveis sanitaris de Catalunya (MUSSCAT) (2025)

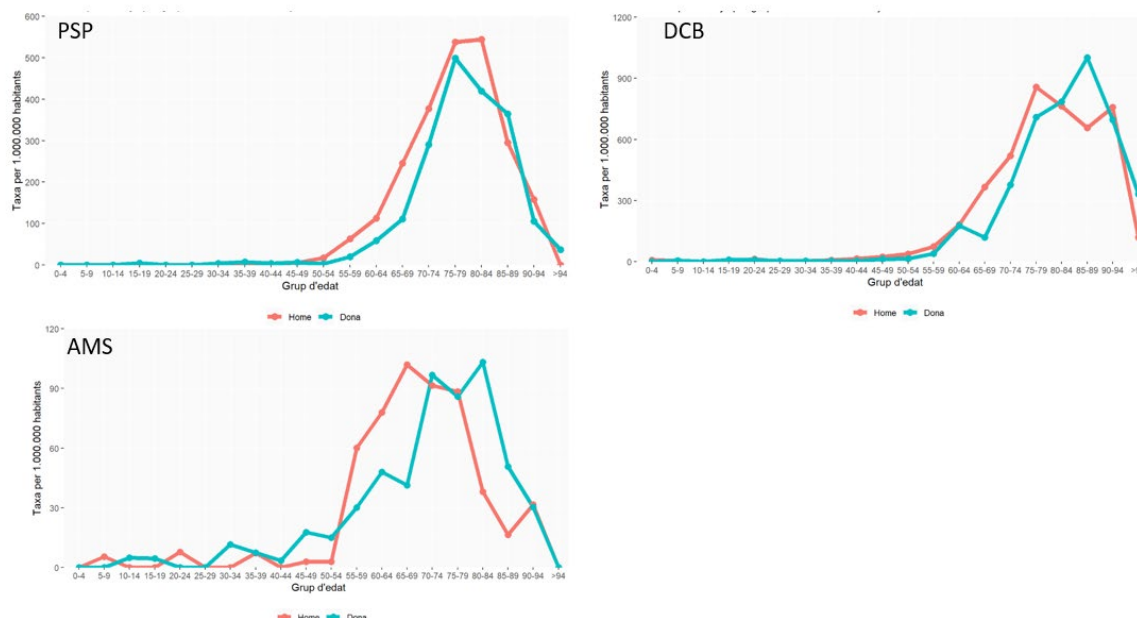
Pla d'atenció a les persones afectades de malaltia de Parkinson i parkinsonismes atípics de Catalunya

Gràfic 12. Distribució per edat i sexe dels casos prevalents de PA a Catalunya (2025)



Font: Registre de morbiditat i utilització de serveis sanitaris de Catalunya (MUSSCAT) (2025)

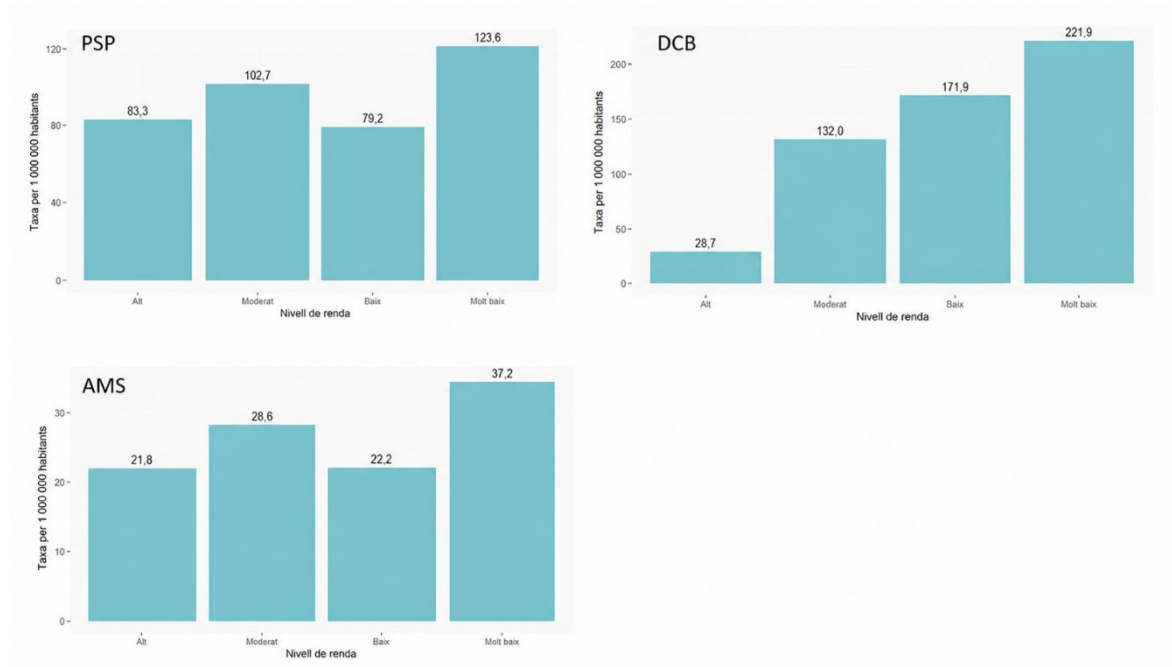
Gràfic 13. Taxa de prevalença de PA per grup d'edat i sexe a Catalunya (2025)



Font: Registre de morbiditat i utilització de serveis sanitaris de Catalunya (MUSSCAT) (2025)

Pla d'atenció a les persones afectades de malaltia de Parkinson i parkinsonismes atípics de Catalunya

Gràfic 14. Taxa de casos prevalents de PA segons el nivell socioeconòmic a Catalunya (2025)

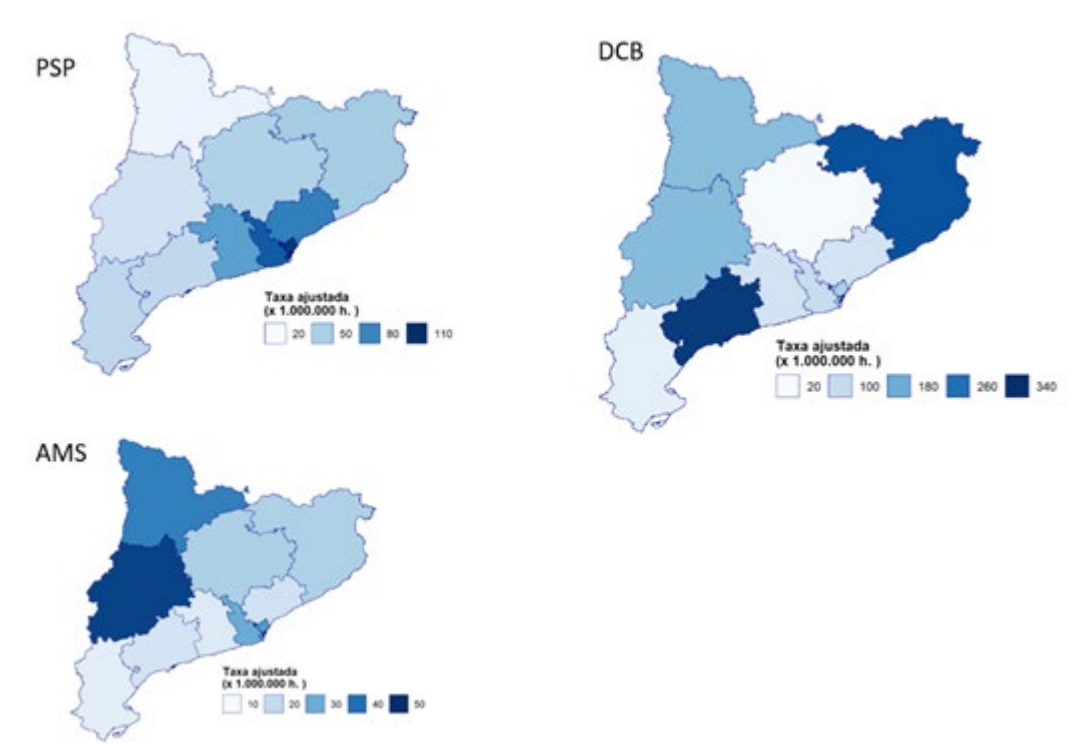


Font: Registre de morbiditat i utilització de serveis sanitaris de Catalunya (MUSSCAT) (2025)

La prevalença dels PA mostra una distribució heterogènia entre les diferents regions sanitàries (RS). En el cas de la PSP, les taxes més elevades s'observen en les RS de Barcelona; en el cas de l'AMS, a la RS de Lleida i Alt Pirineu i Aran, i la degeneració corticobasal, a Girona.

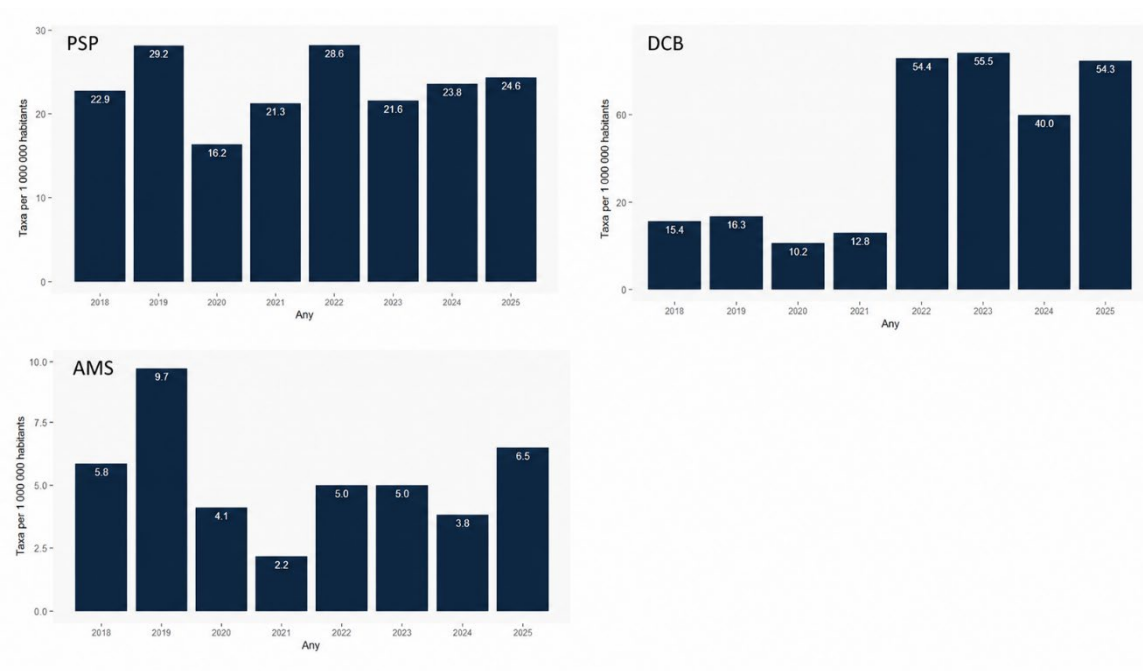
Pla d'atenció a les persones afectades de malaltia de Parkinson i parkinsonismes atípics de Catalunya

Mapa 2. Taxa ajustada de casos prevalents de PA per RS a Catalunya (2025)



Font: Registre de morbiditat i utilització de serveis sanitaris de Catalunya (MUSSCAT) (2025)

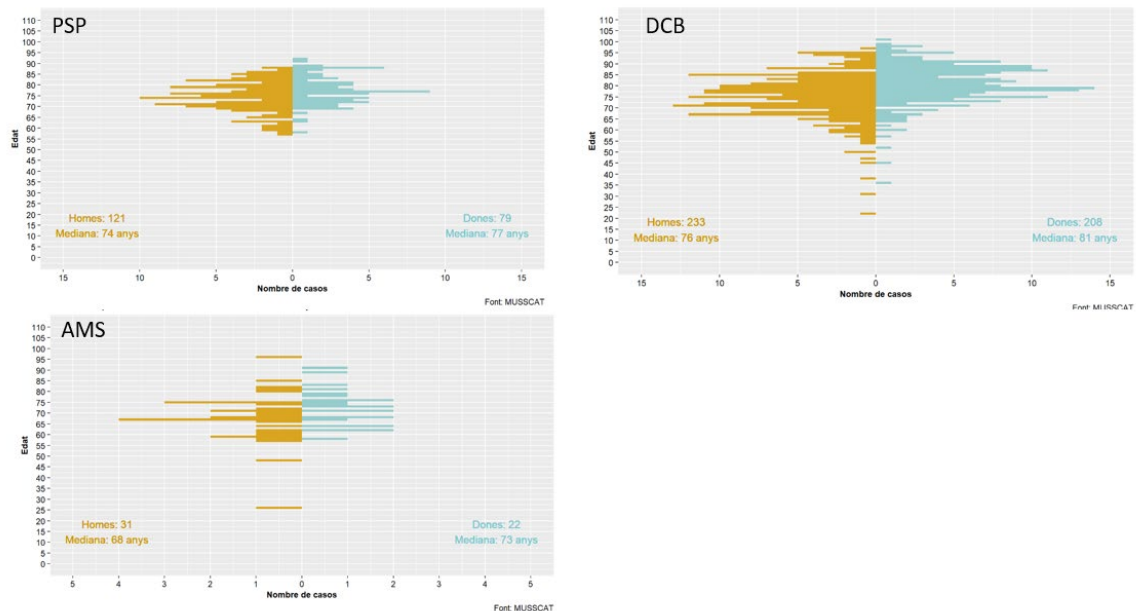
Gràfic 15. Evolució de la taxa d'incidència dels PA per cada 1.000.000 habitants. Catalunya (2018-2025)



Font: Registre de morbiditat i utilització de serveis sanitaris de Catalunya (MUSSCAT) (2025)

Pla d'atenció a les persones afectades de malaltia de Parkinson i parkinsonismes atípics de Catalunya

Gràfic 16. Distribució per edat i sexe dels casos incidents de PA a Catalunya (2025)

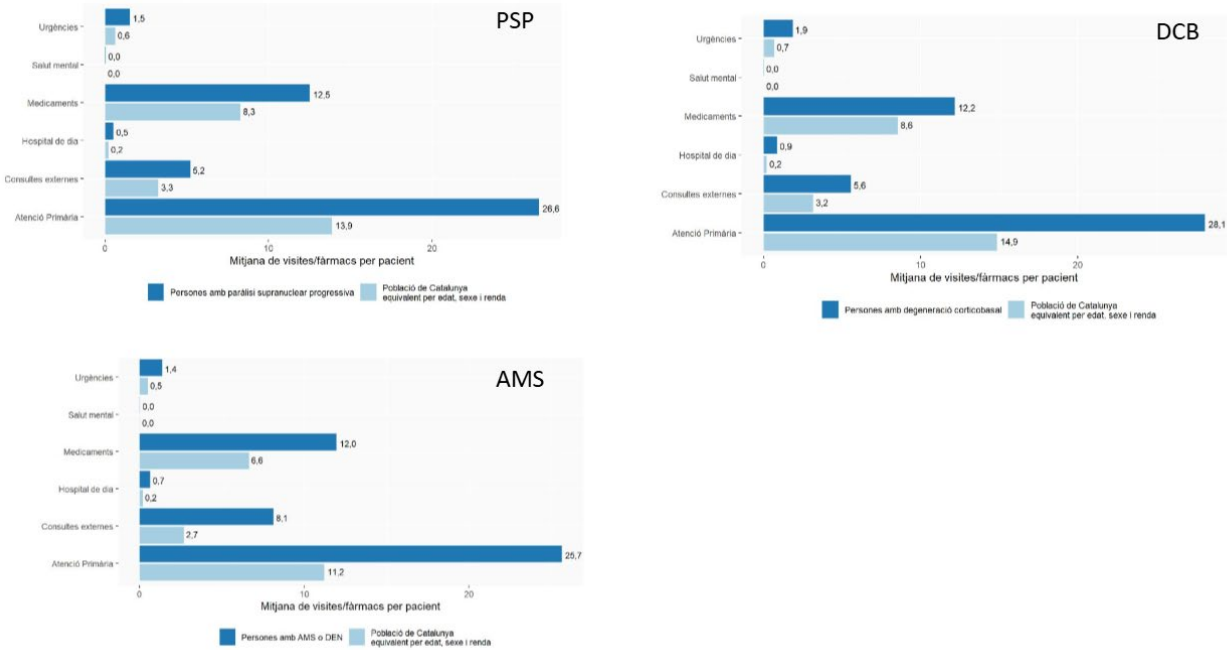


Font: Registre de morbiditat i utilització de serveis sanitaris de Catalunya (MUSSCAT) (2025)

Les persones amb PA presenten un ús més elevat dels recursos ambulatoris i d'atenció intermèdia que la població equivalent per edat, sexe i nivell de renda. L'ús dels serveis sanitaris de les persones amb PA és més elevat que el de les persones amb MP.

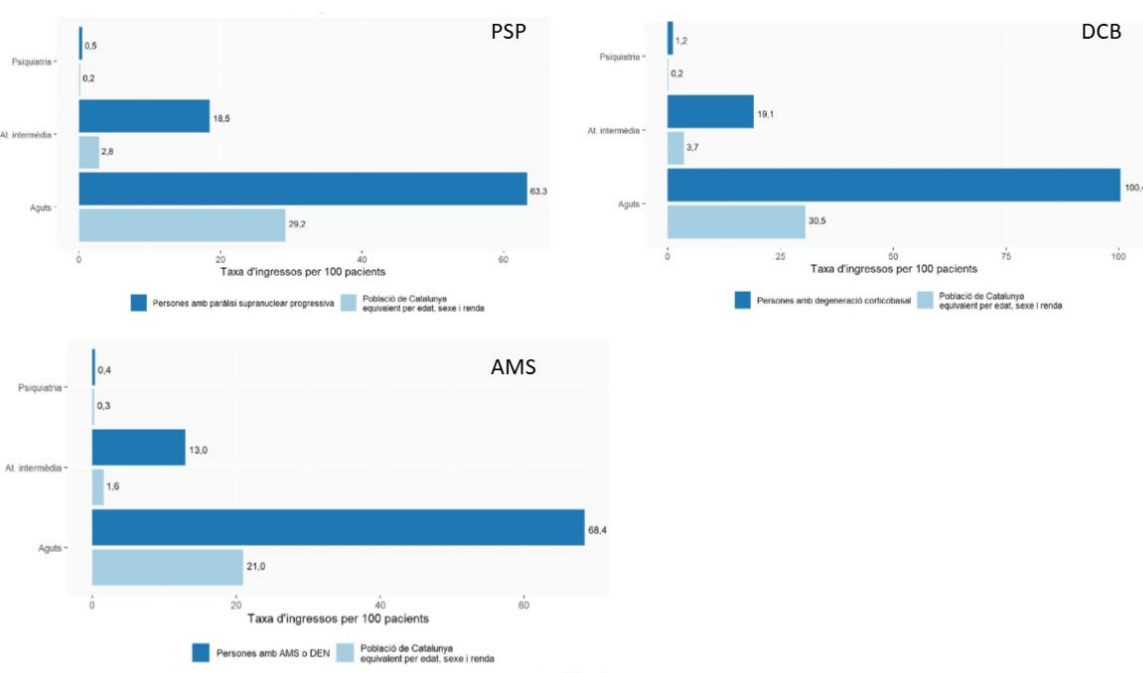
Pla d'atenció a les persones afectades de malaltia de Parkinson i parkinsonismes atípics de Catalunya

Gràfic 17. Utilització dels recursos sanitaris ambulatoris de les persones amb PA i la població equivalent. Catalunya (2025)



Font: Registre de morbiditat i utilització de serveis sanitaris de Catalunya (MUSSCAT) (2025)

Gràfic 18. Utilització dels recursos sanitaris d'internament de les persones amb PA i la població equivalent. Catalunya (2025)



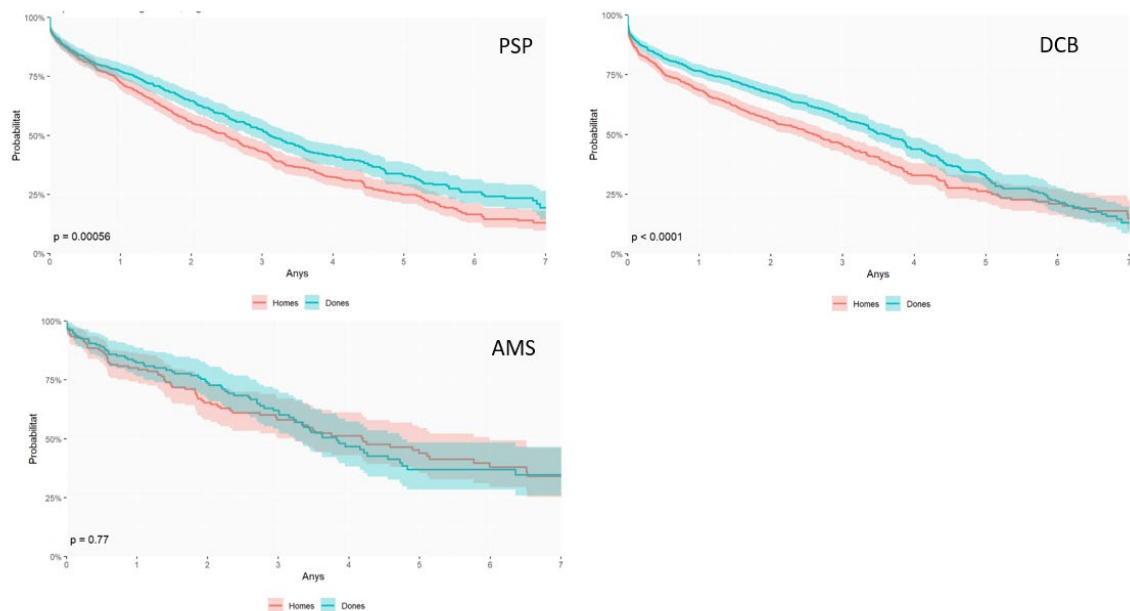
Font: Registre de morbiditat i utilització de serveis sanitaris de Catalunya (MUSSCAT) (2025)

Pla d'atenció a les persones afectades de malaltia de Parkinson i parkinsonismes atípics de Catalunya

La proporció de defuncions de persones amb PA el 2024 és del 15,8 % en persones amb DCB, del 15,7 % en persones amb PSP, i del 13,9 % en persones amb AMS, valors superiors als de les persones amb MP.

No s'observen diferències estadísticament significatives entre homes i dones en la supervivència d'AMS. En persones amb PSP i DCB, la supervivència de les dones es troba per sobre de la dels homes. En comparació amb les persones amb MP, els PA tenen una supervivència més baixa.

Gràfic 19. Supervivència a llarg termini dels nous casos de PA, segons el sexe, a Catalunya (2018-2025)



Font: Registre de morbiditat i utilització de serveis sanitaris de Catalunya (MUSSCAT) (2025)

5. Principis que defineixen el model d'atenció

Els principis que fonamenten el model d'atenció a les persones amb MP i PA són els següents:

- 1) Atenció centrada en la persona i promoció de l'autonomia —tenint en compte les seves necessitats, valors i preferències, les de la seva família i les de les persones que en tenen cura.
- 2) Presa de decisions compartida amb les persones i el seu entorn de cura.
- 3) Atenció continuada amb equips multidisciplinaris, en totes les etapes i fins al procés de final de la vida, i amb integració de recursos sanitaris, socials i comunitaris.
- 4) Atenció integral i de proximitat de les necessitats de la persona i del seu entorn de cura.
- 5) Equitat tant en termes d'accés als serveis com de resultats en salut i experiència de la persona, amb perspectiva de gènere interseccional.
- 6) Eficàcia i eficiència de les intervencions, basades en l'evidència científica, orientades a l'assoliment de resultats, la qualitat i la millora contínua.
- 7) Compartició de dades per a l'avaluació i recerca.
- 8) Participació ciutadana en la definició dels eixos estratègics del pla.

6. El procés d'atenció de les persones afectades per la MP i els PA

6.1 Diagnòstic de la MP i dels PA

El diagnòstic de la MP i els PA és clínic, es basa en la identificació dels signes i símptomes associats a la malaltia. La bradicinèsia és el símptoma principal i el tremolor és habitual. Tanmateix, a l'inici apareixen símptomes prodròmics inespecífics, com ara alteracions motores subtils, hipòsmia, trastorns del son, apatia, depressió o dolor escapular (Gironell et al., 2016).

Els professionals sanitaris dels equips d'atenció primària (EAP) i de traumatologia, reumatologia, psiquiatria, rehabilitació, otorrinolaringologia, urgències i geriatria, així com els de les unitats de la son, sovint són els que identifiquen els símptomes prodròmics i fan la derivació als serveis de neurologia. Els professionals de neurologia són els responsables de fer la confirmació diagnòstica de la malaltia.

Es recomana que el temps d'espera per a la primera visita a neurologia sigui, com a màxim, de dos mesos des de la derivació Rodríguez Escobar et al. (2022).

Els factors següents faciliten el diagnòstic precoç de la MP i els PA:

- La sospita diagnòstica precoç a partir de la identificació dels signes i símptomes prodròmics de la MP i dels PA per part dels EAP i resta de professionals implicats.
- El seguiment de les guies de pràctica clínica i l'establiment de protocols per derivar oportunament als serveis de neurologia.
- L'accés a equips multidisciplinaris de referència especialitzats en trastorns del moviment, particularment pel que fa als PA i persones amb MP primerenca (de menys de 50 anys).
- La coordinació territorial amb circuits de derivació i seguiment.

6.1.1 Identificació precoç dels signes i símptomes de la MP i els PA

A la [taula 1](#) es mostren els signes i símptomes de sospita de la MP o els PA (Rodríguez Escobar et al., 2022).

Taula 1. Signes i símptomes de la MP i PA

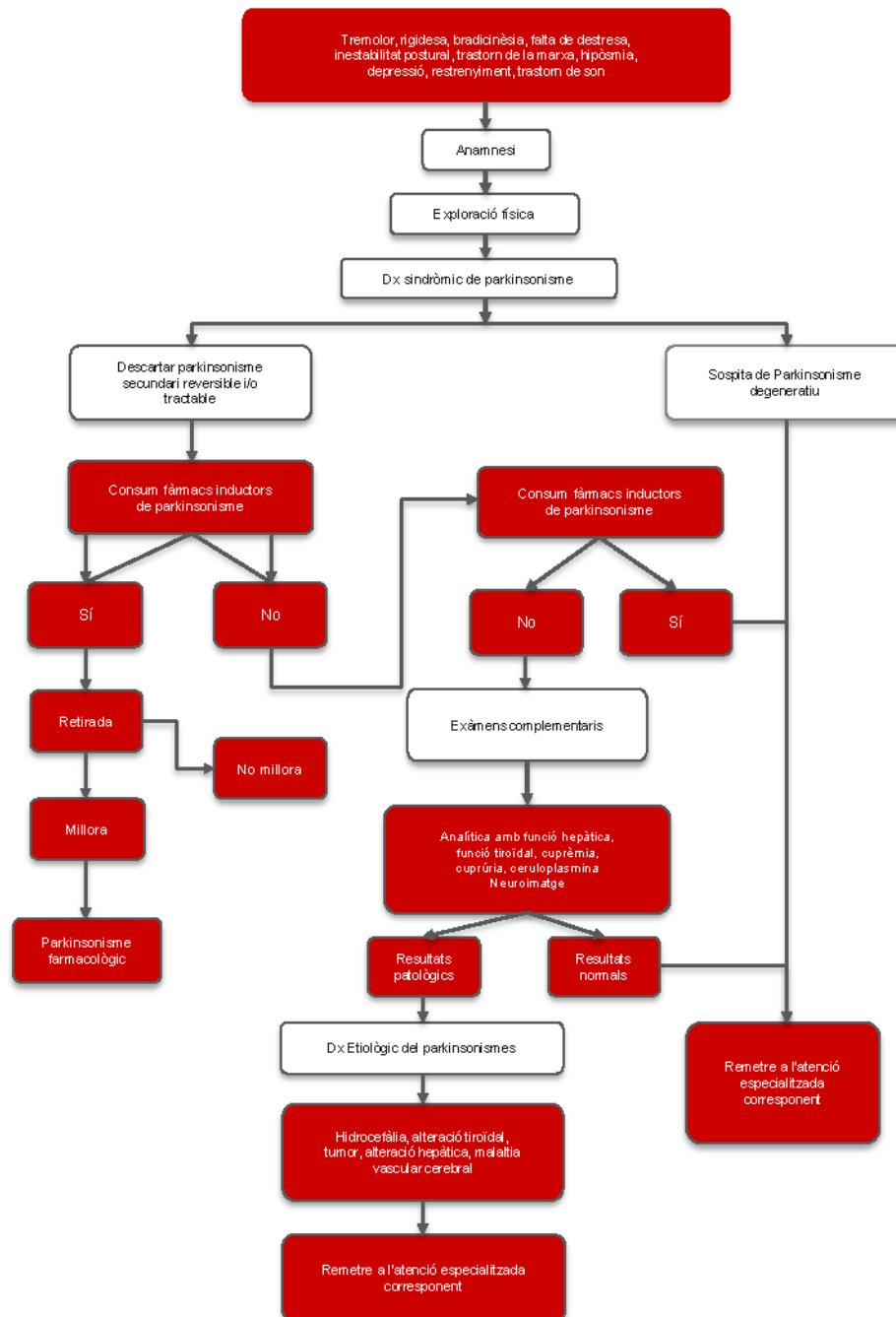
Malaltia	Signes i símptomes
Malaltia de Parkinson	Rigidesa, bradicinèsia, tremolor, falta de destresa, inestabilitat postural, trastorn de la marxa, hipòsmia, depressió, restrenyiment, apatia, trastorns del son REM (<i>Rapid Eye Movement</i>).
Atròfia multisistèmica	▪ Atròfia multisistèmica - parkinsonisme (AMS-P): hipocinèsia i rigidesa, tremolor, estridor laringi, inestabilitat de la marxa i caigudes. ▪ Atròfia multisistèmica - cerebel·losa (AMS-C): atàxia de la marxa i de les extremitats, disàrtria escandida i alteracions oculomotores. ▪ Ambdues variants requereixen la presència de disautonomia.
Paràlisi supranuclear progressiva	Parkinsonisme rígid-acinètic de predomini axial, alteracions posturals i caigudes, paràlisi de la mirada vertical, blefaroespasme, distonia, paràlisis pseudobulbars i alteracions cognitives de característiques frontosubcorticals.
Degeneració corticobasal	Quadre asimètric amb elements subcorticals (parkinsonisme, distonia) i corticals (apràxia, afàsia, negligència, membre aliè).

Font: (Rodríguez Escobar et al., 2022)

Davant de la sospita, s'ha de realitzar l'anamnesi i l'exploració física específiques, així com un diagnòstic diferencial per descartar altres causes. Si cal, se sol·liciten proves de laboratori i d'imatge; a més, cal fer una revisió farmacològica per descartar casos de parkinsonisme farmacològic o de parkinsonisme degeneratiu agreujat per fàrmacs.

6.1.2 Consideracions en el procediment diagnòstic

Algoritme 1. Procés del diagnòstic de la MP i els PA



Font: elaboració pròpia a partir de la (Gironell et al., 2016)

- En la valoració de parkinsonisme induït per psicofàrmacs, cal fer una consulta al **servei de psiquiatria de referència** per valorar la conveniència de retirar o substituir el fàrmac. Si el parkinsonisme millora amb la retirada del fàrmac, es confirma l'etiologia farmacològica del parkinsonisme.
- Són exploracions complementàries l'**anàlítica de sang** (hemograma, perfil renal, hepàtic, tiroïdal, coure i ceruloplasmina, perfil fèrric, vitamina B12, àcid fòlic, serologies per *T. pallidum* i VIH) i les **proves d'imatge** (TAC i ressonància magnètica).
- Si hi ha sospita de MP o PA, cal derivar la persona afectada al servei de neurologia.
- En el cas de persones d'edat avançada amb fragilitat elevada, cal valorar l'assessorament per part del servei de geriatria.
- En el cas de persones amb símptomes afectius resistents i apatia i signes característics de la fase premotora de les malalties, cal valorar l'assessorament per part de psiquiatria.

Si després de l'anamnesi i les exploracions necessàries es confirma la sospita diagnòstica de MP o PA, cal derivar la persona al servei de neurologia de referència.

Els EAP, atesa la seva proximitat i coneixement de la persona i el seu entorn de cura, tenen un paper molt rellevant en la identificació precoç de la MP i dels PA. No obstant això, en el procés de diagnòstic de la MP i dels PA, hi poden intervenir diverses especialitats més enllà de neurologia, atesa la diversitat i inespecificitat dels signes i símptomes de la MP i els PA a l'inici de la malaltia. Es recomana que les especialitats i serveis següents tinguin en compte la possibilitat de la MP i els PA davant de les situacions descrites a continuació.

Taula 2. Signes i símptomes característics de la MP i els PA i especialitats i/o serveis

Especialitats o serveis	Signes i símptomes de la MP i els PA relacionats amb l'especialitat
Traumatologia	Dolor secundari a rigidesa unilateral, dificultats de coordinació, moviments lents, alteracions de la postura i de la marxa, tendinitis escapular, entre d'altres.
Reumatologia	Dolor articular, debilitat, dificultats de moviment, tendinitis escapular, entre d'altres.
Medicina física i rehabilitació	Dolor musculoesquelètic, rigidesa, falta d'equilibri, empitjorament de la marxa o alteració de la coordinació motora.
Psiquiatria	Depressió i apatia sense anhedonia, al·lucinacions visuals o altres símptomes neuropsiquiàtrics. Parkinsonisme farmacològic.
Otorrinolaringologia	Hipòsmia.
Unitats de la son	Trastorn de la conducta associat amb el son REM (TCSR).
Urgències	Tremolor i caigudes.
Geriatría	Dificultats de moviment, de postura, marxa i caigudes de repetició.

Font: elaboració pròpia

6.2 Confirmació diagnòstica en els serveis especialitzats en neurologia

Els especialistes en neurologia —tant de medicina com d'infermeria— fan la confirmació diagnòstica de la MP i els PA. El **criteri de diagnòstic clínic de la MP es basa en** els criteris diagnòstics de la *Movement Disorder Society Clinical Diagnostic Criteria for Parkinson's disease (MDS-PD criteria)* (vegeu l'[annex 1](#)) i els **criteris de diagnòstic clínic dels PA** (vegeu els annexos [2](#), [3](#) i [4](#)) es basen en els criteris (Levin et al., 2016).

6.2.1 Confirmació del diagnòstic

El procediment de confirmació diagnòstica segueix l'algorisme de l'[annex 5](#) i té en compte especialment el següent:

- 1) L'**anamnesi i l'exploració física** han d'incloure l'impacte dels signes i símptomes en les activitats de la vida diària (AVD).
- 2) El diagnòstic diferencial de la MP i els PA ha d'incloure la presència de símptomes i signes de parkinsonisme (és a dir, bradicinèsia, tremolor, rigidesa i inestabilitat postural).
Cal excloure els casos de tremolor essencial i altres malalties neurodegeneratives diferents de la MP idiopàtica com ara: manera rígida de malaltia de Huntington, demència frontotemporal amb parkinsonisme, atròfia dentatorubropalidoluisiana, atàxies espinocerebel·loses), així com altres trastorns que poden causar parkinsonisme secundari. En el cas de la demència amb cossos de Lewy cal dir que comparteix clínica i patologia amb la MP i son part d'un mateix espectre.
No hi ha d'haver signes incompatibles amb el diagnòstic de la MP i PA, com ara haver pres medicaments amb efecte parkinsonitzant, haver patit intoxicacions (organofosforats), tenir antecedents d'encefalitis o crisis oculogires, inici sobtat dels símptomes i signes o evolució no progressiva d'aquests, o evidències de malaltia cerebrovascular (Gironell et al., 2016).
- 3) En el cas dels PA, és important fixar-se en els signes i símptomes específics d'aquest conjunt de malalties (vegeu la [taula 1](#)). A diferència de la MP, els PA no solen millorar de manera significativa amb la levodopa. A més, les proves d'imatge poden mostrar alteracions característiques que poden ser d'utilitat en el procés diagnòstic dels PA (vegeu la [taula 3](#)).

Taula 3. Proves d'imatge i signes específics dels PA

Biomarcadors d'imatge	MP	AMS	PSP	DCB
Ressonància magnètica	RM convencional normal	Ribet putaminal o el signe de la creu (Wenning et al., 2022)	Atròfia del mesencèfal i lòbul frontal (no es donen sempre i l'absència no descarta el diagnòstic)	
DAT SPECT/FP-CIT-SPECT	Denervació presinàptica			
FDG-PET			Hipometabolisme a les regions frontal i el mesencèfal (Höglinger et al., 2017)	Atròfia parietal asimètrica i hipometabolisme
IBZM-SPECT			Degeneració estriatal postsinàptica	Degeneració nigrostriatal postsinàptica
SAA/Rt-QuIC d'alfa sinucleïna positiu	Positiu	Negatiu a la majoria de protocols	Negatiu, excepte si copatologia	
Biomarcadors Alzheimer (Abeta, t-tau, p-tau)	Positiu en part dels casos amb demència (sobretot Abeta)	Pot ser positiva l'Abeta però en general la p-tau és normal		Si positiu, descarta DCB i confirma Alzheimer
Neurofilaments	Normal	Elevat	Elevat	Elevat

Font: elaboració pròpia

- 4) **Cal fer estudis genètics** en persones amb MP primerenca (de menys de 50 anys) o amb antecedents familiars.
- 5) **L'estadi de la MP** s'estableix segons la classificació de Hoehn & Yahr (Hoehn & Yahr, 1967) (vegeu l'[annex 6](#), a la pàgina 75).

- 6) Cal fer un **diagnòstic social** i identificar factors de risc, com ara viure sol, suport limitat de l'entorn de cura, manca de serveis de suport, problemes econòmics, d'habitatge, i sospita de maltractaments, entre d'altres.

Es recomana que tot el procediment diagnòstic es completi en un màxim de **tres mesos** (Rodríguez Escobar et al., 2022).

6.2.2 Visita d'informació del diagnòstic

Després de confirmar el diagnòstic, cal fer la visita d'informació per comunicar el diagnòstic a la persona afectada i, amb el seu consentiment, als seus familiars i cuidadors. En aquesta visita és fonamental:

- Respectar el dret de la persona a ser informat en la mesura que ho desitgi i recollir les seves preferències.
- Demanar quines persones del seu entorn desitgen estar informades del procés.
- Informar del nom de la malaltia, l'estadi en què es troba, del pronòstic i les opcions terapèutiques disponibles, sempre que ho vulgui saber.

Cal informar de manera prudent i no alarmista, individualitzada, comprensible, respectuosa, empàtica, senzilla, sense crear falses expectatives i facilitant l'intercanvi de preguntes, respostes i la presa de decisions. Cal disposar d'un entorn adequat pel que fa a les condicions d'intimitat i comoditat.

6.3 Atenció inicial a les persones amb la MP o les PA

1. Cal fer una **valoració inicial integral** que tingui en compte, bàsicament, el diagnòstic, la identificació de signes i símptomes de la malaltia i de possibles processos concomitants, la repercussió funcional i emocional, les expectatives, el grau de coneixement de la malaltia, les necessitats percebudes per la persona i el seu entorn, i l'eficàcia i els efectes adversos del tractament farmacològic i no farmacològic.

Es recomana fer servir les eines següents (vegeu l'[annex 6](#)).

Taula 4. Eines de valoració de persones amb MP o PA

Eines	Definició	Enllaç
Escala de Hoehn & Yahr (Hoehn & Yahr, 1967)	Determinació de l'estadi de la MP en relació amb els símptomes motors.	Escala Hoehn & Yahr
Escala de Schwab & England (Schwab et al., 1969)	Valoració de la discapacitat en AVD.	Índex Schwab & England
Índex de Barthel (Cid-Ruzafa et al., 1997)	Activitats de la vida diària.	Índex de Barthel
Qüestionari CEPA (Luquin et al., 2017)	Valoració de la MP avançada. La simptomatologia a valorar inclou la inestabilitat postural, el trastorn de la marxa, la disfàgia, les caigudes, les deformitats axials, la demència i els símptomes psicòtics.	Annex 8
Escala de Lawton i Brody (Lawton & Brody, 1969)	Activitats instrumentals de la vida diària.	Índex Lawton i Brody

Font: elaboració pròpia

2. Cal elaborar un **pla terapèutic individualitzat** (PTI) de manera consensuada amb la persona i el seu entorn, que ha d'incloure (Rodríguez Escobar et al., 2022):

- Diagnòstic, valoracions i pla terapèutic farmacològic i no farmacològic.
- Diagnòstics infermers i pla de cures infermeres ([annex 7](#)).
- Pautes de rehabilitació, teràpia ocupacional, logopèdia, nutrició i psicologia.
- Recursos i prestacions adequades en funció de les necessitats socials, psicosocials i ambientals detectades.

La revisió i, si escau, l'actualització del PTI s'ha de dur a terme quan hi ha canvis clínics en l'evolució de la malaltia. Les eines per fer aquesta revisió s'indiquen als annexos [6](#), [8](#) i [9](#).

3. Cal informar la persona i el seu entorn de cura de:

- Qui són els seus professionals de referència, la periodicitat de les visites de seguiment i a quins recursos s'ha d'adreçar en cas de descompensacions, dubtes i situacions de crisi que poden aparèixer al llarg de la malaltia.

- Les **entitats de pacients**, que els poden oferir informació i educació sobre la malaltia, els símptomes i els tractaments, suport psicològic, fisioteràpia i logopèdia, i grups de suport mutu de persones afectades i l'entorn familiar i de cura.
- El procés de **planificació de decisions anticipades (PDA)** i de l'elaboració del document de **voluntats anticipades (DVA)**. El DVA és un document en què la persona detalla les preferències i instruccions per al seu tractament mèdic en cas que no pugui comunicar-les per si mateixa. La PDA és un procés dinàmic que fomenta que la persona participi activament en la presa de decisions sobre el seu procés d'atenció i que permet establir acords entre la persona afectada, el seu entorn i l'equip assistencial, que es poden reavaluar i modificar al llarg del procés.
- Els recursos d'assessorament legal pel que fa a prestacions socials i de cura social.
- Si escau, com accedir a tractaments de cirurgia o de segona línia.
- Les condicions per sol·licitar una segona opinió mèdica.
- Les condicions per ser valorades en unitats especialitzades en trastorns del moviment.

6.4 Tractament integral de la MP i dels PA

6.4.1 Activitats de promoció de la salut i de prevenció bàsiques

Les mesures de promoció de la salut i de prevenció bàsiques s'adrecen a millorar el benestar i la qualitat de vida de la persona afectada i dels seus familiars. De manera específica cerquen:

- Preservar i millorar l'autoestima de la persona.
- Afavorir la comunicació amb l'entorn i les relacions socials.
- Conservar l'autonomia personal mitjançant, entre d'altres, l'activitat física i el reentrenament en les AVD.
- Informar sobre aspectes legals relacionats amb el procés de pèrdua de capacitats com ara conduir o treballar, entre d'altres.
- Informar dels dispositius de suport i les adaptacions de la llar per preservar la seguretat i la màxima autonomia al domicili.

A més, la promoció d'un estil de vida saludable, mitjançant la pràctica d'activitat física, una alimentació equilibrada, mesures d'higiene, educació en la prevenció d'infeccions urinàries i respiratòries i suport emocional, són clau per prevenir les complicacions associades a l'evolució de la MP i els PA.

6.4.2 Tractament farmacològic

Habitualment, són els facultatius especialistes en neurologia els que fan la prescripció inicial dels fàrmacs específics per a la MP i els PA.

En els casos de diagnòstic recent i amb simptomatologia lleu, es pot utilitzar la **teràpia farmacològica modificadora de la malaltia, com la selegilina i rasagilina, que han demostrat tenir un efecte subtil per** retardar o aturar la progressió de la MP. No obstant això, fins al moment, la MP i els PA no tenen curació; tanmateix, hi ha tractaments que controlen i alleugen els símptomes i milloren la qualitat de vida.

Els tractaments simptomàtics són de dos tipus (Gironell et al., 2016): símptomes motors (vegeu els annexos [10](#), [11](#), [12](#), [13](#) i [14](#)) i símptomes no motors, com ara la depressió, l'apatia, l'ansietat i la psicosi (vegeu l'[annex 15](#)). En els PA, el tractament simptomàtic, en general, és molt menys eficaç que en la MP.

Consideracions en la prescripció farmacològica:

- Cal fer una bona conciliació terapèutica, gestionar la polimedicació i les interaccions entre fàrmacs amb el suport de farmacèutics i farmacòlegs d'APiC i hospital; especialment durant les transicions a domicili o a un centre residencial.
- En persones d'edat avançada i en les persones identificades com a PCC o MACA, cal prestar especial atenció a la medicació amb efecte sedant o perfil anticolinèrgic, ja que pot afectar la funció cognitiva i incrementar el risc de caigudes.
- El tractament pot deixar de ser eficaç. En aquests casos, la decisió de retirar-los ha d'estar consensuada entre els professionals i la persona i/o el representant legal. Cal fer la retirada de manera gradual; si en reduir la dosi la persona empitjora, cal mantenir el tractament i revalorar l'estratègia de retirada.
- Cal explorar la voluntat de la persona afectada de participar en assajos clínics.

Quan les teràpies de primera línia no són suficients per a un bon control de la simptomatologia, l'alternativa terapèutica és l'ús de teràpies de segona línia, que inclouen la perfusió subcutània continua d'apomorfina, la perfusió intestinal contínua de levodopa/carbidopa, la infusió subcutània de levodopa i l'estimulació cerebral profunda. Aquests tractaments poden estar contraindicats en situacions de demència, psicosi greu, símptomes motors refractaris o afectació axial greu, entre d'altres. Tampoc es recomanen com a tractament pal·liatiu.

6.4.3 Tractament no farmacològic

Les recomanacions en relació amb el tractament no farmacològic de la MP i els PA són les següents (Rodríguez Escobar et al., 2022):

- **Rehabilitació** per millorar o mantenir la capacitat funcional, prevenir la pèrdua de mobilitat i reduir el risc de caigudes. El **Pla de rehabilitació de Catalunya** recull el procés rehabilitador recomanat per a persones afectades de MP i PA (vegeu l'[annex 16](#)) (Pla de rehabilitació de Catalunya: abordatge integral del funcionament i la discapacitat, 2022). Els programes estructurats intensius de rehabilitació són especialment importants en els PA, on la progressió és més ràpida i l'impacte funcional més precoç.
- **Logopèdia** per prevenir i tractar alteracions de la veu, de la comunicació i de les funcions orofacials i deglutòries.
- **Teràpia ocupacional**, per entrenar les activitats bàsiques de la vida diària (ABVD) i les activitats instrumentals de la vida diària (AIVD), adaptar l'entorn per aconseguir la màxima independència i qualitat de vida, i assessorar en ajudes tècniques.
- **Psicologia** per abordar aspectes emocionals, cognitius i conductuals, amb l'objectiu de garantir el benestar afectiu i emocional de la persona i el seu entorn i mantenir les capacitats cognitives.
- **Nutrició i dietètica** per prevenir la malnutrició que es pot derivar de la disfàgia (vegeu l'[annex 17](#)).
- **Prescripció social** d'activitats per millorar la qualitat de vida, gestionar les emocions i mantenir una xarxa social activa.

En fases inicials de la malaltia, les activitats grupals són més efectives, mentre que a mesura que la malaltia progressa, les necessitats de la persona requereixen intervencions més individualitzades i adaptades a les seves necessitats.

6.5 Seguiment de les persones amb MP o PA

El seguiment inclou, entre d'altres, monitorar els canvis clínics de la malaltia, detectar i tractar signes d'alarma, i avaluar l'eficàcia i els efectes adversos dels tractaments. Cal garantir la continuïtat assistencial en totes les fases de la malaltia. En el cas dels PA cal derivar-los a centres experts per tal de garantir una atenció més especialitzada.

6.5.1 Abordatge de les complicacions de la MP i dels PA

a) Complicacions motores en la MP

Les complicacions motores —bàsicament fluctuacions i discinèsies (vegeu l'[annex 4](#))— es deuen fonamentalment a la degeneració nigroestriada i a la teràpia dopaminèrgica. Per abordar-les es compta amb fàrmacs com la levodopa, inhibidors de la catecol-O-metiltransferasa (ICOMT), inhibidors de la monoamina-oxidasa-B (IMAO-B), agonistes dopaminèrgics, amantadina, així com amb tractaments no farmacològics, com ara la teràpia ocupacional, la fisioteràpia i la logopèdia.

b) Complicacions no motores en la MP

El context de la MP són complicacions no motores comunes:

- Els trastorns del son, com la somnolència diürna, l'insomni i el TCSR.
- Els trastorns afectius, com la depressió, l'apatia i l'ansietat.
- Les conductes impulsives i compulsives, com ara la ludopatia, la ingesta impulsiva, la compra compulsiva, la hipersexualitat, la piromania i la cleptomania.
- Les al·lucinacions i la psicosi.
- Els símptomes disautonòmics, com la sialorrea, la hipotensió ortostàtica, la disfunció vesical i sexual, el restrenyiment, la hiperhidrosi, els vòmits i les nàusees.
- El dèficit nutricional i la disfàgia.
- Els trastorns sensitius, com ara la fatiga, el dolor o la cinestèsia.
- Els trastorns de la parla i la comunicació.
- El deteriorament cognitiu i la demència.
- Els episodis aguts deguts a la descompensació provocada per un desencadenament metabòlic, una suspensió brusca, els errors en la medicació, la hipotensió, etc.

Segons la complicació no motora, poden intervenir altres especialitats, com ara la psiquiatria, la urologia, la logopèdia i la nutrició, entre d'altres. Des de la

perspectiva d'infermeria, hi ha una guia digital del maneig de les complicacions de la MP (Cámara et al., 2023).

c) Complicacions motores i no motores dels PA

Les complicacions associades als PA coincideixen en part amb les de la MP avançada, tot i que solen manifestar-se de manera més ràpida. Aquestes complicacions inclouen, entre d'altres:

- Disfàgia: risc de malnutrició, infeccions respiratòries per aspiració.
- Caigudes: risc de fractures, hematoma subdural.
- Immobilitat: embòlia pulmonar.
- Incontinència: infeccions urinàries, sèpsia.
- Disautonomia: pseudooclusió intestinal, hipotensió ortostàtica greu.

6.5.2 Malaltia avançada i final de vida

En la fase avançada de MP i PA, els símptomes són més complexos i difícils de controlar. L'objectiu del PTI en aquesta fase és mantenir i garantir la funcionalitat, el benestar i la qualitat de vida de la persona i del seu entorn familiar i de cura. Cal adoptar mesures per facilitar l'autonomia, com ara la prescripció d'ortesis, ajudes per a la marxa (p. ex. cadires de rodes), i valorar la consulta al servei de nutrició.

El Qüestionari CEPA serveix per identificar les persones amb MP avançada. La inestabilitat postural, el trastorn de la marxa, la disfàgia, les caigudes, les deformitats axials, la demència i els símptomes psicòtics són alguns dels que s'associen a la MP en fase avançada (Luquin et al., 2017).

Cal fer la valoració integral multidimensional i un **diagnòstic situacional**. Per determinar la fragilitat en la població geriàtrica es recomana l'**índex VIG-Frail**.

- **Les persones amb MP o PA avançada** tenen una malaltia amb una necessitat d'atenció sanitària elevada, i una fragilitat i dependència creixents. Per tant, es poden definir com a pacient crònic complex (**PCC**) o bé com a persones amb malaltia crònica avançada (**MACA**) (Amblàs et al., 2020).
- Cal fer el **Pla d'intervenció individualitzat compartit (PIIC)** de manera multidisciplinària i posar-lo a disposició dels diversos professionals del sistema a través de l'HC3 (Amblàs et al., 2020).
- En aquesta fase, cal vetllar per l'actualització de la PDA i del DVA, si escau.
- Si a través de l'escala NECPAL la persona és identificada com a MACA, es recomana avaluar la complexitat del cas amb l'**instrument HexCom-Red** (Busquet Duran et al., 2021).

- En aquestes fases, cal revisar els tractaments —especialment els preventius o els que poden comportar un benefici a llarg termini— d'acord amb els objectius i valorar-ne la continuació segons el balanç entre benefici, risc, càrrega terapèutica, adherència i possible iatrogènia (Beckers et al., 2025).

En la fase final de la malaltia, els objectius de l'atenció s'han d'orientar progressivament cap al confort, el control de símptomes i la reducció de la càrrega terapèutica. Si es retira la medicació dopaminèrgica oral, especialment la levodopa, es recomana no suspendre-la bruscament perquè pot provocar un empitjorament greu dels símptomes. Es recomana no fer una retirada sobtada dels agonistes dopaminèrgics perquè pot aparèixer la síndrome d'abstinència.

Els criteris que suggereixen la necessitat de cures pal·liatives són:

- a) Manca de resposta al tractament.
- b) Dependència per dur a terme les AVD.
- c) Períodes *off* poc controlables i predictibles.
- d) Intensificació dels símptomes (discinèsia, disfàgia, motors, entre d'altres) i de l'impacte emocional en la persona afectada i el seu entorn familiar i de cura.

Els equips d'APIC són els referents en l'abordatge pal·liatiu i, en funció de la complexitat del cas, cal considerar la intervenció dels equips especialitzats en cures pal·liatives (PADES).

6.6 Suport a l'entorn familiar i de cura

La pèrdua d'autonomia i l'evolució de la MP i els PA augmenten les necessitats de suport i cura de la persona i la càrrega física, emocional, social i econòmica de l'entorn familiar i de cura. El PTI ha d'incorporar l'atenció a les necessitats de l'entorn familiar i de cura des de l'inici. Cal fer una avaluació sociofamiliar, mitjançant l'Escala de valoració sociofamiliar TSO (Giménez-Bertomeu et al., 2020), que inclogui:

- Característiques estructurals de la família: distribució de rols, estabilitat de l'entorn, relacions, funcionament social i familiar i percepció sociofamiliar de la situació.
- Situació econòmica, entorn geogràfic, condicions del domicili, equipaments disponibles, hàbits i situació laboral de la persona afectada i del seu entorn familiar i de cura.
- Identificació del cuidador principal o referent, avaluació de la sobrecàrrega de la persona cuidadora (vegeu l'[annex 18](#)) i exploració de l'impacte que té el pronòstic de la malaltia en la persona cuidadora.
- Assessorament i informació en recursos i/o prestacions, afavorint la utilització dels recursos adients a la persona. Reforçar/reactivar els

recursos propis de la persona, la seva família i la seva xarxa de suport social i familiar. Treballar les expectatives de l'esfera social (socio sanitària) de la persona i entorn.

- Capacitació per l'adquisició de competències personals que millori la qualitat de vida de la persona i facilitar la vinculació i la relació de la persona amb el seu entorn familiar evitant la soledat no volguda. Promoure l'autonomia en el domicili.
- Prevenir i atendre les situacions psicosocials derivades de la sobrecàrrega i la claudicació.
- Fomentar la capacitat: cura i autocura.
- Prevenir situacions de risc social, vetllant pels drets de la persona.
- Assegurar la gestió social integrada en la coordinació amb els recursos i serveis sanitaris, socials i comunitaris pertinents, per dur a terme el pla d'intervenció social planificat.

L'atenció a les necessitats de l'entorn familiar i de cura ha d'estar alineada amb les preferències de la persona afectada i consisteix a:

- Proporcionar acompanyament, suport emocional i eines d'autocura.
- Oferir informació i educació sanitària accessible en la MP i els PA, especialment pel que fa a la gestió de la persona i les activitats que pot desenvolupar.
- Assessorar en recursos i prestacions, incloent-hi les entitats i associacions de pacients.
- Garantir una comunicació fluida amb l'EAP i la unitat de referència hospitalària corresponent.

El seguiment sociofamiliar ha de ser periòdic i individualitzat segons les necessitats de la persona.

7. Recursos i integració assistencial

L'atenció a les persones amb MP o PA requereix un enfocament multidisciplinari i integrat, que garanteixi l'accessibilitat adequada als serveis i la continuïtat de l'atenció al llarg de tota la malaltia.

7.1 Equips d'atenció primària i comunitària

Les funcions principals de l'APiC en l'atenció a les persones amb la MP o els PA són:

- Diagnòstic sindròmic i detecció precoç de la MP i PA, seguiment i abordatge de les complicacions.

- Elaboració i actualització del PTI.
- Identificació de pacient PCC/MACA.
- Realització del DVA i PDA.
- Avaluació i suport a l'entorn familiar i de cura.
- Informació, assessorament i educació sanitària a la persona i l'entorn familiar i de cura.
- Coordinació amb els serveis socials comunitaris.
- Derivació i coordinació amb el servei de neurologia i altres serveis implicats en l'atenció integral.
- Atenció domiciliària, també a residències de gent gran.
- Atenció al final de la vida.

7.2 Serveis hospitalaris de neurologia

Els serveis de neurologia són els responsables de la confirmació diagnòstica de la MP i PA. Compten, com a mínim, amb un professional de neurologia i d'infermeria. Alhora, els hospitals disposen de professionals de farmàcia, que també intervenen en l'adequació de la teràpia farmacològica als pacients amb MP i PA. Les funcions principals dels serveis de neurologia amb relació a l'atenció a les persones amb MP i PA són:

- Diagnòstic i seguiment de la malaltia i de les seves complicacions.
- Elaboració i actualització del PTI.
- Assessorament per realitzar el DVA i la PDA.
- Derivació i coordinació amb les unitats de referència de trastorns del moviment en casos d'especial complexitat.
- Informació, assessorament i educació sanitària a la persona i l'entorn familiar i de cura.
- Gestió social del cas en coordinació amb l'APiC.
- Coordinació amb els diferents àmbits assistencials que intervenen en l'atenció a les persones amb MP o PA.
- Suggestiu d'identificació de pacient PCC/MACA.

Alguns serveis hospitalaris de neurologia estan més especialitzats en l'abordatge d'aquestes malalties. Reben denominacions diverses; en alguns casos, unitats de trastorns del moviment i, en d'altres, unitats especialitzades en MP i PA. Per la seva expertesa, fan diagnòstics d'especial dificultat utilitzant tècniques com ara punció lumbar i proves d'imatge, així com abordatges més complexos, que inclouen teràpies de segona línia.

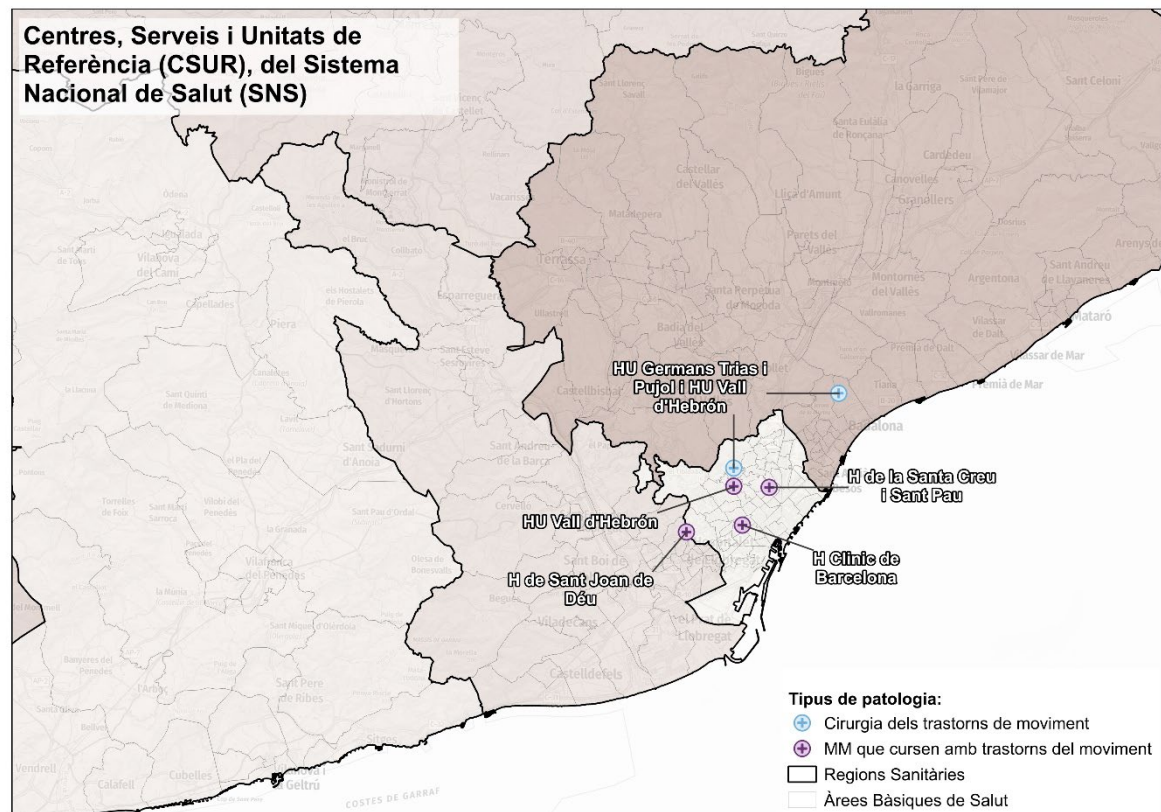
Els perfils professionals que habitualment participen en el procés d'atenció als casos complexos són els de neurologia, infermeria amb expertesa en trastorns del moviment, neuropsicologia, treball social, medicina física i rehabilitació, fisioteràpia, teràpia ocupacional, logopèdia, nutrició, geriatria, psiquiatria, psicologia i farmàcia.

7.3 Centres, serveis i unitats de referència (CSUR) en l'àmbit de la MP i PA

El Ministeri de Sanitat acredita centres, serveis i unitats de referència (CSUR) per oferir serveis d'alt nivell d'especialització per a l'atenció de patologies de baixa prevalença i procediments d'alta complexitat. En l'àmbit de la MP i PA, els CSUR s'ocupen de:

- Administrar teràpies avançades i d'última generació, fer cirurgia i gestionar situacions d'especial complexitat.
- Donar suport i assessorar els serveis de neurologia de referència.
- Aplicar noves evidències científiques en el diagnòstic, el tractament i el seguiment d'aquestes malalties.
- Participar en assajos clínics i altres estudis per millorar la gestió d'aquestes malalties.
- Desenvolupar nous abordatges diagnòstics i terapèutics.
- Formar i capacitar els professionals sanitaris implicats en l'atenció de la MP i dels PA en relació amb l'abordatge integral d'aquestes patologies.

Mapa 3. CSUR del SNS segons la RS a Catalunya (2025)



Font: elaboració pròpia

7.4. Recursos d'atenció intermèdia

Hospitals de dia d'atenció intermèdia (HdDAI): ofereixen atenció ambulatoria diürna durant diverses hores al dia, la qual cosa facilita l'observació directa de la persona en condicions reals i l'avaluació funcional multidisciplinària continuada. Ofereixen tractaments farmacològics i no farmacològics. Les prestacions són, principalment:

- Avaluar la funcionalitat de la persona i la capacitat de resposta de l'entorn familiar i de cura al llarg del procés de la malaltia.
- Aplicar i actualitzar el PTI.
- Realitzar sessions de fisioteràpia, logopèdia, teràpia ocupacional i neuropsicologia, entre d'altres, grupals o individuals.

Equips de cures pal·liatives: tant unitats de cures pal·liatives d'internament com PADES. Atenen les persones en una fase avançada de la malaltia o en el tram final de la vida. Les seves funcions són, principalment:

- Avaluació i control dels símptomes de la malaltia en la fase avançada (físics, psicològics, emocionals i espirituals).

- Suport emocional i espiritual a la persona i al seu entorn familiar i de cura.
- Promoció de la realització i actualització de la PDA.
- Valoració de la situació sociofamiliar per identificar el risc i situacions de claudicació.

7.5 Altres recursos que poden intervenir

- Els **serveis de rehabilitació**, tant hospitalaris com comunitaris, intervenen en el seguiment de la persona afectada. [Enllaç al Pla de rehabilitació de Catalunya](#).
- Els **hospitals de dia** dels hospitals d'aguts tenen un paper rellevant en:
 - L'ajustament de tractaments complexos en fases més avançades de la MP.
 - L'Inici i titulació de teràpies avançades, com les infusions de levodopa intestinal o d'apomorfina.
 - El seguiment i ajust de pacients candidats a estimulació cerebral profunda.
- Els **serveis hospitalaris de geriatria** participen en l'atenció de persones amb MP o PA d'edat avançada, amb pluripatologia i polimedicació. Es recomana que l'APiC i els serveis de neurologia sol·licitin una valoració per part de geriatria si la persona presenta síndromes geriàtriques, dependència funcional greu o deteriorament cognitiu, principalment.
- Els **centres de dia** són un [servei social](#) d'atenció diürna per a persones grans o amb dependència lleu o moderada, entre els quals hi ha les persones amb MP i PA. Ofereixen suport personal, social i terapèutic durant el dia, inclouen activitats de manteniment físic i cognitiu, àpats i supervisió, i la persona torna al seu domicili cada tarda. Aquest servei contribueix a mantenir l'autonomia de la persona i dona suport a l'entorn familiar i de cura.
- Les **farmàcies comunitàries** poden detectar possibles casos de MP o PA i orientar-los cap als professionals de l'APiC. A més, col·laboren en la identificació de reaccions adverses i interaccions farmacològiques, entre d'altres, i informen sobre l'ús segur i adequat de la medicació (Prieto Matos et al., 2019).
- Les **entitats de persones afectades** són associacions sense ànim de lucre formades per persones afectades, famílies i cuidadors. Informen,

acompanyen i defensen els drets de les persones amb aquestes malalties. També ofereixen suport emocional, orientació social i teràpies no farmacològiques (fisioteràpia, logopèdia, estimulació cognitiva). Fomenten la sensibilització social i la recerca, i actuen com a pont entre pacients, professionals i l'Administració.

7.6 Integració assistencial

En el procés assistencial d'atenció a la MP i els PA intervenen diferents agents i serveis. Per tal de garantir que tots proporcionin una atenció de qualitat, cal que treballin en xarxa i de manera col·laborativa i coordinada. Segons en quina fase es troba la persona, necessita rebre l'atenció en un àmbit o un altre —l'hospitalari, l'APiC o el comunitari—, que disposen d'eines i serveis propis i s'adrecen a assolir objectius específics diferents.

Al llarg de la malaltia, els serveis han d'actuar de manera integrada: amb continuïtat, amb transicions de qualitat i amb una cartera d'actuacions completa i adaptada a les necessitats de la persona i del seu entorn de cura. La coordinació requereix intercanvi d'informació rellevant entre professionals del mateix equip i també dels diferents entorns d'atenció, amb canals que permetin el diàleg i l'abordatge compartit. Les reunions multidisciplinàries sistemàtiques de compartició de casos són una eina per a la gestió integrada. La figura d'infermeria d'enllaç o experta en trastorns del moviment poden ser de referència en la coordinació.

Informació que cal compartir en les derivacions:

- Orientació diagnòstica (CIM-10) de la patologia.
- Situació funcional actual: afectació de la disfunció i la discapacitat, amb signes, símptomes i exploració física.
- Exploracions complementàries relacionades (imatge, analítica o d'altres), amb data.
- Temps d'evolució de l'afectació.
- Tractaments (farmacològics, rehabilitadors, quirúrgics o d'altres), amb data d'inici i resposta obtinguda.
- Repercussió en les activitats de la vida diària i, si escau, en l'activitat laboral.
- Factors socials i psicosocials rellevants que puguin condicionar el tractament i l'adherència.

Informació que cal compartir en les transicions i altes:

- Situació de funcionament i discapacitat.
- Objectius del tractament establerts, intervencions realitzades i resultats assolits.
- Recomanacions de continuïtat: pautes d'autocura i de manteniment/rehabilitació per a la persona i el seu entorn de cura, incloent-hi indicacions per a l'àmbit comunitari.
- Suports indicats a domicili i/o adaptacions de l'entorn.
- Criteris de nova derivació o retorn als serveis corresponents.
- Factors socials i psicosocials rellevants que puguin condicionar el seguiment.

8. Registre de la informació i seguiment de la MP i dels PA de Catalunya

Per a la planificació, el seguiment i l'avaluació de l'atenció a les persones amb MP i PA, cal disposar d'informació fiable, actualitzada i homogènia sobre la situació d'aquestes malalties a Catalunya.

En l'actualitat, el conjunt mínim bàsic de dades (CMBD) és una font d'informació molt útil de gestió sanitària. Tot i així, les dades de què disposa amb relació a la MP i els PA són limitades i a vegades poc específiques, per la qual cosa no permet conèixer amb prou detall la situació completa de les persones. Una altra font d'informació rellevant en aquest context és la història clínica que es recull a l'estació clínica d'atenció primària. Actualment, no hi ha un únic quadern de comandament que integri les dades dels sistemes d'informació dels diversos àmbits d'atenció implicats.

L'Estratègia en malalties neurodegeneratives del Sistema Nacional de Salut recomana impulsar registres autonòmics acreditats de malalties neurodegeneratives, atesa la inexistència d'un registre estatal únic. Els PA tenen consideració de malalties minoritàries, motiu pel qual el seu registre és d'especial interès per conèixer el nombre de persones afectades i la distribució territorial i visibilitzar-les.

Cal establir un procediment estandarditzat de registre amb una codificació comuna en la història clínica compartida, que permeti recollir la informació de manera homogènia en els diversos àmbits d'atenció, la qual cosa ha de permetre analitzar la informació amb perspectiva territorial, al llarg de tot el procés d'atenció i durant totes les fases d'aquestes malalties.

Els professionals sanitaris són els encarregats de registrar les variables clíniques i assistencials rellevants, que inclouen escales de valoració, plans terapèutics

individualitzats, estadis de la malaltia, tractaments, situacions funcionals o necessitats psicosocials, entre d'altres.

A més, és necessària la creació d'un quadern de comandament específic de MP i PA a Catalunya, amb informació sobre la incidència, la prevalença, la distribució territorial, les característiques clíniques i les necessitats d'atenció d'aquestes persones. La recollida de variables relatives a símptomes prodròmics, els estadis de la malaltia, tipus de tractaments —inclosa la cirurgia—, entre d'altres, pot ser d'especial interès per millorar l'atenció a aquestes persones, planificar recursos i avançar en la recerca en aquest àmbit.

9. Formació i promoció del coneixement de la MP i dels PA

La informació i la formació són claus per millorar l'atenció a les persones amb MP i PA i fomentar l'autonomia. La formació cal que s'adrexi tant a la població general com a la persona afectada, al seu entorn familiar i de cura, així com als professionals.

Actualment, el coneixement social sobre la MP i els PA és limitat, especialment pel que fa als símptomes no motors i a les fases inicials o prodròmiques. La informació i la formació adreçades a la **població general** afavoreix el reconeixement precoç dels símptomes, facilita l'accés als serveis, fomenta la comprensió, ajuda a reduir l'estigma associat a la malaltia, fomenta l'autocura i promou el suport per part de la comunitat. Per aquests motius, és essencial reforçar les activitats de divulgació, sensibilització i educació en salut adreçades a la ciutadania, entre les quals destaca la realització de cursos i seminaris a través de [l'Escola de Salut Catalana](#).

En segon lloc, la **informació i formació a la persona amb MP o PA i a l'entorn familiar i de cura són particularment necessàries** després del diagnòstic. Cal proporcionar informació sobre l'evolució de la malaltia, les possibles complicacions, les afectacions psicosocials i les opcions per a l'abordatge. Les associacions de persones afectades tenen un paper fonamental en la difusió de la informació sobre la malaltia.

La formació adreçada a les persones afectades i al seu entorn familiar i de cura ha de prioritzar àmbits com l'activitat física, l'alimentació, la salut emocional, l'autocura, la seguretat en les activitats de la vida diària i el coneixement dels recursos disponibles. Així mateix, es considera rellevant impulsar programes comunitaris orientats a promoure l'autonomia, la corresponsabilitat i el suport mutu, incloent-hi figures com la persona pacient experta i la persona cuidadora experta. Aquestes iniciatives poden contribuir a millorar l'autonomia, l'autocura i la qualitat de vida de les persones afectades i del seu entorn.

Pel que fa als professionals, es remarca la necessitat de disposar d'una formació continuada, transversal i actualitzada, adreçada tant a professionals especialistes com a no especialistes. Aquesta formació ha de facilitar la detecció precoç de la MP i dels PA, l'abordatge de les complicacions motores i no motores, la coordinació entre àmbits assistencials i l'acompanyament de la persona i del seu

entorn al llarg de l'evolució de la malaltia. També es detecta la necessitat de reforçar la presència de la MP i dels PA en la formació acadèmica i pràctica dels diferents perfils professionals implicats.

El Departament de Salut impulsa i col·labora en l'elaboració de diverses activitats formatives i divulgatives relacionades amb l'atenció a les persones amb MP i PA, les complicacions associades i la promoció de la seva autonomia, tant a través de l'Escola Catalana de Salut com d'altres entitats de formació. Aquestes formacions s'adrecen tant a la ciutadania com als professionals. Entre aquestes iniciatives destaquen la formació sobre disfàgia orofaríngia i desnutrició, cronicitat i complexitat, formació bàsica en delírium en el pacient hospitalitzat, formació sobre el document de voluntats anticipades i sobre malalties neurodegeneratives, que inclou Parkinson i altres parkinsonismes, i eines per a l'acompanyament de les persones afectades i el seu entorn.

Cal consolidar i ampliar una oferta formativa continuada, transversal i adaptada als diferents àmbits assistencials implicats en l'atenció a les persones amb MP i PA, i a les necessitats de la ciutadania. Aquesta formació ha d'incloure, com a mínim, la detecció precoç i el diagnòstic diferencial, l'abordatge de les complicacions motores i no motores, la prevenció i el maneig de les complicacions d'aquestes malalties.

10. Recerca bàsica i aplicada

A Catalunya hi ha diversos equips de recerca en hospitals, centres especialitzats, instituts de recerca i universitats que treballen en l'àmbit de la MP i dels PA, amb participació en projectes nacionals i internacionals.

Per avançar en aquest àmbit, es considera necessari fomentar la col·laboració i la coordinació entre centres, donar suport metodològic, tècnic i de gestió, reforçar les xarxes de recerca, afavorir el coneixement compartit dels assaigs clínics actius, la participació de persones de diferents territoris i l'ús compartit de dades i mostres biològiques.

Finalment, cal garantir la qualitat de la recerca, que tingui en compte la perspectiva de gènere i la interseccionalitat, que sigui multidisciplinària i multidimensional, tot tenint en compte aspectes bàsics, clínics (inclou la investigació *post mortem*), ètics, socials i de gestió.

Per tal d'abordar la complexitat de la MP i dels PA i el seu impacte personal, familiar, social i econòmic, cal involucrar en la recerca actors més enllà de l'àmbit clínic, com ara universitats, empreses, altres sectors i administracions.

11. Línies estratègiques del Pla

El Pla d'atenció a les persones afectades de MP i PA de Catalunya ([figura 1](#)) s'estructura en 9 línies estratègiques ([figura 2](#)), 23 projectes i 77 actuacions.

Figura 1. Estructura del Pla d'atenció sanitària a les persones afectades de MP i PA de Catalunya



Font: elaboració pròpia

Figura 2. Línies estratègiques del Pla d'atenció sanitària a les persones afectades de MP i PA de Catalunya

Línia estratègica 1.	Diagnòstic precoç de la MP i dels PA
Línia estratègica 2.	Tractament integral de la MP i dels PA
Línia estratègica 3.	Atenció continuada centrada en la persona amb MP o PA
Línia estratègica 4.	Atenció en la fase avançada de la malaltia o en situació de final de vida
Línia estratègica 5.	Suport a l'entorn familiar o de cura
Línia estratègica 6.	Formació i promoció del coneixement de la MP i dels PA
Línia estratègica 7.	Àmbits assistencials
Línia estratègica 8.	Registre de la MP i dels PA de Catalunya
Línia estratègica 9.	Foment de la recerca bàsica i aplicada

Línia estratègica 1. Diagnòstic precoç de la MP i dels PA

Projecte 1. Millora de la detecció precoç i diferencial de la MP i dels PA i l'activació efectiva del seu estudi

Actuació 1. Definir criteris d'interconsulta i derivació de casos de sospita de MP o PA per garantir una identificació i un accés ràpid i equitatiu als serveis de neurologia de referència.

Actuació 2. Definir i donar a conèixer els criteris de derivació a les unitats altament especialitzades de referència de cada territori.

Actuació 3. Establir un protocol de detecció, diagnòstic (que inclogui criteris per a la realització d'estudis genètics, biomarcadors genètics i no genètics) i seguiment de la MP i dels PA adaptat al Pla d'atenció a Catalunya.

Línia estratègica 2. Tractament integral de la MP i dels PA

Projecte 1. Tractament farmacològic centrat en la persona

Actuació 4. Protocol·litzar i aplicar la prescripció farmacològica centrada en la persona amb revisions periòdiques segons l'estadi i la situació clínica, especialment en persones PCC/MACA.

Actuació 5. Revisar les alertes existents per a persones amb codis diagnòstics CIE-10 de MP i de PA en l'aplicació SIRE (Sistema Integrat de Recepta Electrònica) i divulgar aquesta eina entre els professionals.

Projecte 2. Tractament no farmacològic centrat en la persona

Actuació 6. Protocol·litzar i aplicar la prescripció no farmacològica centrada en la persona al llarg de la malaltia (criteris d'accés, intervencions i professionals implicats) i en tots els recursos.

Actuació 7. Oferir el tractament no farmacològic des dels recursos de proximitat de manera accessible arreu de Catalunya.

Actuació 8. Promoure l'oferta de tractament no farmacològic de la MP i els PA a través de les tecnologies de la informació i la comunicació (p. ex. jocs interactius).

Projecte 3. Accés equitatiu al tractament integral

Actuació 9. Adequar els criteris d'accés al transport sanitari als hospitals de dia per garantir l'equitat territorial en la resposta a les necessitats de les persones amb MP i PA.

Actuació 10. Facilitar l'accés a teràpies complexes i a assaigs clínics amb criteris d'equitat territorial.

Línia estratègica 3. Atenció continuada centrada en la persona amb MP o PA

Projecte 1. Prevenció i atenció a les complicacions derivades de la MP i PA

Actuació 11. Adequar la cartera de serveis i prestacions a les necessitats derivades de les complicacions de la MP i els PA (per exemple, disfàgia, trastorns del son, trastorns afectius, demència, etc.).

Actuació 12. Establir un protocol de prevenció, detecció i gestió dels símptomes i complicacions principals de la MP i els PA.

Actuació 13. Impulsar l'elaboració d'un protocol d'abordatge nutricional i de prevenció de la disfàgia en persones amb MP o PA.

Actuació 14. Protocol·litzar l'atenció als símptomes de salut mental associats a la MP i els PA amb coordinació interdisciplinària.

Actuació 15. Facilitar canals de contacte àgils amb els professionals de referència per resoldre dubtes i evitar visites innecessàries.

Actuació 16. Oferir sessions d'educació sanitària adaptades a les necessitats de les persones amb MP o PA en el seu entorn habitual d'atenció.

Projecte 2. Seguiment integral, sistemàtic i multidisciplinari de les persones amb MP o PA

Actuació 17. Definir un model de Pla terapèutic individualitzat compartit amb la persona i l'entorn cuidador amb participació interdisciplinària.

Actuació 18. Actualitzar els protocols de seguiment de les persones amb MP o PA ingressades en residències de gent gran, en col·laboració amb l'Agència d'Atenció Integrada Social i Sanitària (AISS).

Actuació 19. Protocol·litzar la derivació cap a centres i serveis de referència segons els escenaris clínics.

Actuació 20. Protocol·litzar la derivació als CSUR en els casos de més complexitat.

Actuació 21. Elaborar un pla integral d'educació sanitària i comunicació entre professionals i l'entorn familiar i de cura.

Actuació 22. Definir rutes assistencials territorials integrades per a l'atenció de les persones amb MP i PA.

Actuació 23. Promoure la indicació de la targeta Cuida'm a persones afectades de MP i PA que compleixen els requisits establerts.

Actuació 24. Informar i oferir suport per a l'elaboració del DVA des de fases inicials de la malaltia.

Projecte 3. Atenció integral i integrada a persones amb MP o PA d'inici primerenc

Actuació 25. Analitzar l'oferta de prestacions i recursos adaptats a persones amb MP primerenc (de menys de 50 anys) i PA de manera conjunta amb el Departament de Drets Socials i Inclusió.

Actuació 26. Oferir mesures per facilitar el procés d'atenció sense impactar negativament en la vida laboral.

Actuació 27. Abordar les necessitats derivades de l'evolució de la malaltia en l'àmbit laboral de manera conjunta amb el Departament d'Empresa i Treball.

Projecte 4. Avaluació i millora de l'entorn domiciliari

Actuació 28. Avaluar les condicions del domicili de manera sistemàtica i oferir solucions per millorar la seguretat i el confort, com ara adaptacions de la llar o productes de suport.

Actuació 29. Promoure el coneixement i l'accés a tecnologies de suport mitjançant l'assessorament i el suport en la tramitació.

Projecte 5. Atenció integrada social i sanitària

Actuació 30. Crear una línia de treball sanitària i social integrada per donar resposta coordinada a persones amb MP o PA, amb la participació de l'AISS i el Departament de Drets Socials i Inclusió.

Actuació 31. Reordenar rols i processos per millorar el reconeixement de la discapacitat, la dependència i l'accés a prestacions, de manera conjunta amb el Departament de Drets Socials i Inclusió.

Línia estratègica 4. Atenció en la fase avançada de la malaltia o en situació de final de vida

Projecte 1. Atenció personalitzada integral en fase avançada o final de vida

Actuació 32. Definir criteris d'identificació precoç de persones en fase avançada per adequar l'atenció.

Actuació 33. Impulsar la realització precoç de la PDA en l'atenció a la MP i PA.

Actuació 34. Definir els criteris d'accés als diversos recursos d'atenció pal·liativa, d'acord amb criteris de complexitat.

Actuació 35. Proporcionar informació i suport a les persones que sol·licitin la prestació d'ajuda per morir.

Línia estratègica 5. Suport a l'entorn familiar o de cura

Projecte 1. Resposta integral a les necessitats de l'entorn familiar o de cura

Actuació 36. Incorporar als protocols assistencials l'avaluació de les necessitats i càrregues de les persones cuidadores i les estratègies d'acompanyament oportunes.

Actuació 37. Sistematitzar entrevistes semiestructurades amb la persona i el seu entorn familiar i de cura per informar sobre l'evolució de la malaltia.

Actuació 38. Desenvolupar programes d'assessorament individualitzat o grupal adaptats a persones que tenen cura de la MP i PA.

Actuació 39. Potenciar la col·laboració amb associacions de pacients i familiars com a elements clau de suport.

Projecte 2. Acompanyament psicosocial a l'entorn familiar o de cura

Actuació 40. Oferir suport emocional i psicològic a familiars mitjançant grups d'ajuda mútua i teràpia familiar.

Línia estratègica 6. Formació i promoció del coneixement de la MP i PA

Projecte 1. Sensibilització de la població general

Actuació 41. Promoure activitats divulgatives per millorar el coneixement social de la MP i els PA i els avenços científics.

Actuació 42. Impulsar campanyes de sensibilització sobre barreres arquitectòniques i urbanístiques que afecten la qualitat de vida i l'autonomia de les persones amb MP i PA.

Projecte 2. Adequació dels plans formatius dels professionals

Actuació 43. Promoure la revisió dels plans formatius universitaris en aquest àmbit.

Actuació 44. Facilitar la rotació dels professionals que atenen la MP i els PA per unitats de referència.

Actuació 45. Capacitar els professionals en l'ús de l'eina de prescripció centrada en la persona.

Actuació 46. Formar els professionals en les alternatives de tractament no farmacològic dirigides a persones amb MP o PA.

Actuació 47. Impulsar l'elaboració d'un pla de formació específic per millorar la detecció i derivació precoç de la MP i els PA, adreçat als perfils professionals implicats.

Actuació 48. Formar en DVA i PDA els professionals implicats en l'atenció a pacients amb MP i PA.

Actuació 49. Fomentar la capacitació continuada dels serveis de neurologia en trastorns del moviment.

Actuació 50. Impulsar la formació dels professionals implicats en l'atenció a pacients amb MP i PA en l'atenció a persones fràgils, PCC i MACA.

Actuació 51. Impulsar el desenvolupament de formacions adreçades a professionals de residències i de serveis d'atenció domiciliària, amb la col·laboració del Departament de Drets Socials i Inclusió.

Projecte 3. Educació en salut per a persones amb MP i PA i l'entorn familiar i de cura

Actuació 52. Implementar un programa estandarditzat d'educació sanitària en els serveis de neurologia adreçat a les persones amb MP o PA i al seu entorn familiar i de cura.

Actuació 53. Desenvolupar programes comunitaris adreçats a empoderar les persones afectades, tant pacients com cuidadors.

Actuació 54. Crear materials educatius accessibles per a persones cuidadores mitjançant eines digitals.

Línia estratègica 7. Àmbits assistencials

Projecte 1. Coordinació entre àmbits

Actuació 55. Impulsar la coordinació sistemàtica entre serveis de neurologia i l'APiC a través de sessions conjuntes, espais de trobada i de treball compartit, entre d'altres, per tal de facilitar la formació continuada i l'abordatge de persones amb MP i PA.

Projecte 2. Diagnòstic i atenció amb equitat territorial

Actuació 56. Elaborar i implementar rutes assistencials de la MP i els PA arreu del territori.

Actuació 57. Impulsar una xarxa d'expertesa en l'àmbit de les malalties neurodegeneratives minoritàries accessible per a totes les persones amb PA.

Projecte 3. L'atenció als hospitals de dia

Actuació 58. Vetllar per l'adequació de la dotació i composició dels professionals dels hospitals de dia per a l'abordatge de persones amb MP i PA.

Actuació 59. Definir criteris comuns d'inclusió i alta dels hospitals de dia i la seva cartera de serveis.

Projecte 4. L'atenció als hospitals d'aguts

Actuació 60. Formar professionals d'urgències en les necessitats específiques de persones amb MP o PA.

Actuació 61. Implementar protocols a urgències per millorar la detecció precoç i l'atenció.

Actuació 62. Garantir la continuïtat assistencial durant els ingressos i les transicions.

Actuació 63. Potenciar la telemedicina sempre que les condicions de la persona amb MP o PA ho permetin.

Projecte 5. Coordinació entre àmbits assistencials

Actuació 64. Designar referents de coordinació en MP i PA a cada àmbit assistencial.

Actuació 65. Facilitar la comunicació entre els professionals implicats, tant per via presencial com telemàtica.

Actuació 66. Organitzar jornades interprofessionals per fomentar l'intercanvi de coneixements i bones pràctiques.

Actuació 67. Protocol·litzar la coordinació entre dispositius assistencials i residències de gent gran.

Actuació 68. Articular la coordinació de geriatria amb la resta de professionals implicats en l'abordatge de l'atenció a persones amb MP o PA d'edat avançada, múltiples patologies i polimedicació.

Actuació 69. Implementar el programa PREALT per al seguiment postalta a través de la notificació electrònica.

Actuació 70. Elaborar un mapa de recursos sanitaris en MP i PA de tot el territori.

Línia estratègica 8. Registre de la MP i dels PA de Catalunya

Projecte 1. Sistema de registre

Actuació 71. Estandarditzar el registre clínic i organitzatiu del procés d'atenció a les persones amb MP i PA.

Actuació 72. Definir un quadern de comandament de la MP i PA, amb diferents nivells d'anàlisi.

Línia estratègica 9. Foment de la recerca bàsica i aplicada

Projecte 1. Promoció de la recerca en MP i PA

Actuació 73. Desenvolupar programes de recerca multidisciplinària en biomarcadors i noves teràpies, amb la participació de diferents àmbits assistencials.

Actuació 74. Potenciar els bancs de teixits neurològics i la donació de cervell a través del DVA, entre d'altres.

Actuació 75. Afavorir la difusió dels resultats de la recerca científica.

Actuació 76. Promoure la coordinació entre unitats per promoure l'accés a assajos clínics de les persones amb MP i PA.

Projecte 2. Impuls de la dedicació dels professionals a la recerca

Actuació 77. Promoure convocatòries específiques de recerca en MP i PA i d'estades formatives o de perfeccionament en centres de referència.

12. Avaluació del Pla

L'avaluació del desplegament del Pla és clau com a suport en la presa de decisions per a la planificació, l'organització i la gestió. Amb aquesta finalitat, s'han definit un conjunt d'indicadors vinculats a les diferents línies estratègiques del Pla. La unitat territorial, així com el període de temps, s'ha de definir en funció de cadascun dels indicadors.

Línia 1. Diagnòstic precoç de la MP i dels PA

- Protocols disponibles de gestió integral de persones amb MP i PA que incloguin la detecció precoç (Sí/No).
- Temps d'espera entre la derivació de l'APiC i l'atenció per part del servei de neurologia de referència per al diagnòstic de la MP i dels PA.

- Existència de criteris i circuits de relació entre dispositius, serveis i àmbits assistencials (Sí/No).

Línia 2. Tractament integral de la MP i dels PA

- Protocol d'indicació del tractament no farmacològic en persones amb MP i PA disponible (Sí/No).
- Percentatge de persones amb MP o PA amb revisió de la prescripció farmacològica durant els últims sis mesos.
- Proporció de persones amb MP o PA en teràpies complexes.
- Proporció de persones amb MP o PA que no empitjoren en escales de funcionament i qualitat de vida en un període de temps definit.

Línia 3. Atenció continuada centrada en la persona amb MP o PA

- Model comú de PTI per a pacients amb MP o PA disponible (Sí/No).
- Guia clínica per a l'abordatge de les complicacions associades a la MP i als PA disponible a cada territori (Sí/No).
- Protocols de seguiment de persones amb MP o PA en centres residencials disponibles a cada territori (Sí/No).
- Protocol d'atenció a les persones amb MP o PA disponible que inclogui criteris de derivació entre àmbits assistencials (Sí/No).
- Proporció de persones amb MP o PA a les quals se'ls han prescrit recursos comunitaris.
- Proporció de persones amb MP o PA i el DVA elaborat.
- Proporció de persones amb MP o PA identificades com a PCC.
- Proporció de persones amb MP o PA identificades com a MACA.
- Proporció de persones amb MP o PA amb prescripció de la targeta Cuida'm.
- Proporció de persones amb MP o PA satisfetes amb l'atenció rebuda.
- Proporció de persones amb MP o PA ateses per treball social.
- Proporció de persones amb MP o PA que van a urgències.
- Proporció de persones amb MP o PA que ingressen.
- Proporció de persones amb MP o PA amb dependència reconeguda.
- Dies passats a casa de les persones amb MP i PA.
- Proporció de persones de l'entorn familiar i de cura satisfetes amb l'atenció rebuda.

Línia 4. Atenció a la persona amb MP o PA avançats en situació de final de vida

- Eina d'identificació de persones amb MP o de PA en fase avançada disponible a la història clínica (Sí/No).
- Proporció de persones amb MP o PA i PDA elaborada.
- Proporció de persones amb MP o PA amb accés a cures pal·liatives des del diagnòstic.
- Proporció de persones amb MP o PA que moren al domicili.

- Proporció de persones amb MP o PA que sol·liciten la prestació d'ajuda a morir (PRAM).
- Proporció de persones amb MP o PA que reben la PRAM.

Línia 5. Suport a l'entorn familiar o de cura

- Programa de cuidador expert en MP i PA disponible (Sí/No).
- Proporció de persones amb MP o PA amb l'escala de sobrecàrrega del cuidador realitzada.
- Proporció de persones amb MP o PA amb sobrecàrrega del cuidador.

Línia 6. Formació i promoció del coneixement de la MP i dels PA

- Nombre de professionals que participen en activitats de formació en la MP i PA, per àmbit assistencial i perfil professional.
- Nombre de professionals sanitaris que han fet rotacions en equips o unitats de referència de trastorns del moviment, per perfil professional.
- Nombre d'activitats divulgatives i de conscienciació sobre la MP i els PA adreçades a la ciutadania.
- Programa d'educació sanitària per a la MP i els PA accessible (Sí/No).
- Proporció de centres que disposen de programes d'educació sanitària adreçats a persones amb MP o PA.
- Proporció de centres que disposen de programes d'educació sanitària adreçats a persones cuidadores de persones amb MP o PA.

Línia 7. Àmbits assistencials

- Nombre de jornades interprofessionals organitzades sobre la MP i els PA, amb la participació d'experts de diversos àmbits assistencials.
- Xarxa d'expertesa de malalties neurodegeneratives creada, amb composició i distribució dels equips multidisciplinaris (Sí/No).
- Definició dels criteris d'accés als hospitals de dia disponible (Sí/No).
- Mapa de recursos d'atenció a la MP i als PA accessible per a la ciutadania (Sí/No).

Línia 8. Registre de la MP i dels PA de Catalunya

- Quadern de comandament sobre la MP i els PA disponible (Sí/No).
- Incidència de la MP i els PA per edat, sexe i distribució territorial.
- Prevalença de la MP i els PA per edat, sexe i distribució territorial.
- Temps mitjà entre l'aparició dels primers símptomes i el diagnòstic de la MP i els PA.
- Proporció de persones amb MP i PA amb escales de valoració funcional, experiència i qualitat de vida realitzades.
- Temps mitjà de supervivència de la MP i els PA per edat, sexe i distribució territorial.

Línia 9. Foment de la recerca bàsica i aplicada

- Nombre de persones amb MP o PA participants en assaigs clínics.
- Nombre d'assajos clínics actius.
- Nombre de projectes de recerca específics sobre MP i PA en curs.
- Nombre de centres sanitaris que participen en estudis clínics o translacionals sobre la MP i PA.
- Nombre de publicacions científiques sobre la MP i els PA generades per centres catalans.
- Nombre de col·laboracions entre centres sanitaris, socials i acadèmics en recerca sobre MP i PA.
- Nombre de donacions de cervell.

13. Escenaris de futur

Els escenaris futurs següents poden influir en la implementació del Pla d'atenció:

- **Envelliment de la població catalana:** l'edat avançada és un factor de risc de desenvolupar MP o PA, per la qual cosa s'espera un increment de la incidència i la prevalença de la MP i els PA en els propers anys.
- **Generació i aplicació de nous coneixements i medicina personalitzada:** la incorporació de nous coneixements genètics, biomarcadors diagnòstics i/o pronòstics i opcions terapèutiques innovadores permetrà personalitzar millor l'atenció integral de la MP i dels PA en cada persona i el seu entorn cuidador. Els nous coneixements obren la possibilitat d'identificar individus amb un risc elevat de desenvolupar MP o PA. Aquest fet comportaria que les persones puguin exercir la seva autonomia, prendre decisions fonamentals sobre la seva atenció futura, aspectes jurídics, últimes voluntats, salut, vida social i tractaments. Tot plegat no només té implicacions pel que fa a l'abordatge, sinó que també comporta reptes ètics nous.
- **Desenvolupament i aplicació de tecnologies basades en la intel·ligència artificial i la robòtica social,** que tenen un gran potencial a l'hora de millorar la qualitat de l'abordatge i garantir la del sistema.

14. Bibliografia

- Amblàs, J., Amil, P., Bocanegra, I., Bullich, Í., Contel, J. C., Gil, E., Giráldez, G., González, A., Melendo, E. M., Mir, V., Ruiz, R., & Santa Eugènia, S. (2020). *Bases conceptuais i model d'atenció per a les persones fràgils, amb cronicitat complexa (PCC) o avançada (MACA)*. <https://hdl.handle.net/11351/7007>
- Amblàs-Novellas, J., Martori, J. C., Molist Brunet, N., Oller, R., Gómez-Batiste, X., & Espauella Panicot, J. (2017). Índice frágil-VIG: diseño y evaluación de un índice de fragilidad basado en la Valoración Integral Geriátrica. *Revista Española de Geriatria y Gerontología*, 52(3), 119-127. <https://doi.org/10.1016/j.regg.2016.09.003>
- Armstrong, M. J., Litvan, I., Lang, A. E., Bak, T. H., Bhatia, K. P., Borroni, B., Boxer, A. L., Dickson, D. W., Grossman, M., Hallett, M., Josephs, K. A., Kertesz, A., Lee, S. E., Miller, B. L., Reich, S. G., Riley, D. E., Tolosa, E., Tröster, A. I., Vidailhet, M., & Weiner, W. J. (2013). Criteria for the diagnosis of corticobasal degeneration. *Neurology*, 80(5), 496-503. <https://doi.org/10.1212/WNL.0b013e31827f0fd1>
- Beckers, M., Hommel, D., Lennaerts, H., Stuijt, C., Smit, P., & Bloem, B. R. (2025). Discontinuation or acute unplanned cessation of oral dopaminergic medications in persons with Parkinson's disease: A practice review. *Journal of Parkinson's Disease*, 15(6), 1062-1077. <https://doi.org/10.1177/1877718X251356896>
- Bloem, B. R., Okun, M. S., & Klein, C. (2021). Parkinson's disease. *The Lancet*, 397(10291), 2284-2303. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(21\)00218-X](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)00218-X)
- Brodsky, H., Pond, D., Kemp, N. M., Luscombe, G., Harding, L., Berman, K., & Huppert, F. A. (2002). The GPCOG: A New Screening Test for Dementia Designed for General Practice. *Journal of the American Geriatrics Society*, 50(3), 530-534. <https://doi.org/10.1046/j.1532-5415.2002.50122.x>
- Browne, W., & Nair, B. (Kichu) R. (2019). The Timed Up and Go test. *Medical Journal of Australia*, 210(1), 13. <https://doi.org/10.5694/mja2.12045>
- Burgos, R., Bretón, I., Cereda, E., Desport, J. C., Dziewas, R., Genton, L., Gomes, F., Jesús, P., Leischker, A., Muscaritoli, M., Pouliu, K.-A., Preiser, J. C., Van der Marck, M., Wirth, R., Singer, P., & Bischoff, S. C. (2018). ESPEN guideline clinical nutrition in neurology. *Clinical Nutrition*, 37(1), 354-396. <https://doi.org/10.1016/j.clnu.2017.09.003>
- Burgos, R., Sarto, B., Seguro, H., Romagosa, A., Puiggrós, C., Vázquez, C., Cárdenas, G., Barcons, N., Araujo, K., & Pérez-Portabella, C. (2012). [Translation and validation of the Spanish version of the EAT-10 (Eating Assessment Tool-10) for the screening of dysphagia]. *Nutrición hospitalaria*, 27(6), 2048-2054. <https://doi.org/10.3305/nh.2012.27.6.6100>
- Buschke, H., Kuslansky, G., Katz, M., Stewart, W. F., Sliwinski, M. J., Eckholdt, H. M., & Lipton, R. B. (1999). Screening for dementia with the Memory Impairment Screen. *Neurology*, 52(2), 231-231. <https://doi.org/10.1212/WNL.52.2.231>
- Busquet Duran, X., Esteban Pérez, M., Jiménez Zafra, E. M., Tura Poma, M., Bosch de la Rosa, O., Moragas Roca, A., Martín Moreno, S., Martínez Losada, E., Crespo Ramírez, S., Llobera Estrany, J., Lestón Lado, L., Salamero Tura, N., Salvago

Pla d'atenció a les persones afectades de malaltia de Parkinson i parkinsonismes atípics de Catalunya

- Leiracha, A., & López García, A. I. (2021). *Instrument per a la valoració del nivell de complexitat d'atenció de persones amb cronicitat avançada i necessitats pal·liatives (MACA): HexCom-Red*. <https://hdl.handle.net/11351/7001>
- Cámara, A., Campolongo, A., & González, B. (2023). *Guía digital de la Enfermedad del Parkinson para profesional de enfermería*.
- Cid-Ruzafa, J., & Damián-Moreno, J. (1995). Valoración de la discapacidad física: el índice de Barthel. *Revista Española de Salud Pública*, 71(2), 127-137. https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1135-57271997000200004&lng=es&nrm=iso&tlng=es
- Descripció de les persones amb malaltia de Parkinson i parkinsonismes atípic. Registre de morbiditat i utilització de serveis sanitaris de Catalunya (MUSSCAT). (2025).
- Ferrero López, M. I., Castellano Vela, E., & Navarro Sanz, R. (2009). Utilidad de implantar un programa de atención a la disfagia en un Hospital de Media y Larga Estancia. *Nutrición Hospitalaria*, 24(5), 588-595. https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0212-16112009000500011&lng=es&nrm=iso&tlng=es
- Ferrer-Peña, R., Gil-Martínez, A., Pardo-Montero, J., Jiménez-Penick, V., Gallego-Izquierdo, T., & La Touche, R. (2016). Adaptación y validación de la Escala de gradación del dolor crónico al español. *Reumatología Clínica*, 12(3), 130-138. <https://doi.org/10.1016/j.reuma.2015.07.004>
- García González, J. V, Díaz Palacios, E., Salamea García, A., Cabrera González, D., Menéndez Caicoya, A., Fernández Sánchez, A., & Acebal García, V. (1999). Evaluación de la fiabilidad y validez de una Escala de valoración social en el anciano. *Atencion primaria*, 23(7), 434-440.
- Giménez-Bertomeu, V. M., Guinovart-Garriga, C., Rovira-Soler, E., & Viñas-Segalés, N. (2020). *Escala de Valoración Sociofamiliar TSO: Fundamentos descripción, validación e instrucciones de uso*. <https://hdl.handle.net/10045/110282>
- Gironell, A., Fàbregues, O., Compta, Y., & Pastor, P. (2016). *Protocol de diagnòstic i tractament de la malaltia de Parkinson*. https://www.scneurologia.cat/wp-content/uploads/2019/02/Guia-M%C3%A8dica-de-Parkinson-de-la-Societat-Catalana-de-Neurologia_Actualitzaci%C3%B3_2016-segona-edici%C3%B3_def.pdf
- Herdman, M., Gudex, C., Lloyd, A., Janssen, MF., Kind, P., Parkin, D., Bonsel, G., & Badia, X. (2011). Development and preliminary testing of the new five-level version of EQ-5D (EQ-5D-5L). *Quality of Life Research*, 20(10), 1727-1736. <https://doi.org/10.1007/s11136-011-9903-x>
- Hoehn, M. M., & Yahr, M. D. (1967). Parkinsonism: onset, progression and mortality. *Neurology*, 17(5), 427. <https://doi.org/10.1212/WNL.17.5.427>
- Höglinger, G. U., Respondek, G., Stamelou, M., Kurz, C., Josephs, K. A., Lang, A. E., Mollenhauer, B., Müller, U., Nilsson, C., Whitwell, J. L., Arzberger, T., Englund, E., Gelpi, E., Giese, A., Irwin, D. J., Meissner, W. G., Pantelyat, A., Rajput, A., van Swieten, J. C., ... Litvan, I. (2017). Clinical diagnosis of progressive supranuclear

Pla d'atenció a les persones afectades de malaltia de Parkinson i parkinsonismes atípics de Catalunya

- palsy: The movement disorder society criteria. *Movement Disorders*, 32(6), 853-864. <https://doi.org/https://doi.org/10.1002/mds.26987>
- Lawton, M. P., & Brody, E. M. (1969). Assessment of older people: self-maintaining and instrumental activities of daily living. *The Gerontologist*, 9(3), 179-186.
- Levin, J., Kurz, A., Arzberger, T., Giese, A., & Höglinger, G. U. (2016). The Differential Diagnosis and Treatment of Atypical Parkinsonism. *Deutsches Arzteblatt international*, 113(5), 61-69. <https://doi.org/10.3238/arztebl.2016.0061>
- Luquin, M.-R., Kulisevsky, J., Martinez-Martin, P., Mir, P., & Tolosa, E. S. (2017). Consensus on the Definition of Advanced Parkinson's Disease: A Neurologists-Based Delphi Study (CEPA Study). *Parkinson's Disease*, 2017, 1-8. <https://doi.org/10.1155/2017/4047392>
- Park, J., Jeong, E., & Seomun, G. (2018). The clock drawing test: A systematic review and meta-analysis of diagnostic accuracy. *Journal of Advanced Nursing*, 74(12), 2742-2754. <https://doi.org/10.1111/jan.13810>
- Pla de rehabilitació de Catalunya: abordatge integral del funcionament i la discapacitat. (2022). <https://hdl.handle.net/11351/9485>
- Postuma, R. B., Berg, D., Stern, M., Poewe, W., Olanow, C. W., Oertel, W., Obeso, J., Marek, K., Litvan, I., Lang, A. E., Halliday, G., Goetz, C. G., Gasser, T., Dubois, B., Chan, P., Bloem, B. R., Adler, C. H., & Deuschl, G. (2015). MDS clinical diagnostic criteria for Parkinson's disease. *Movement Disorders*, 30(12), 1591-1601. <https://doi.org/https://doi.org/10.1002/mds.26424>
- Prieto Matos, J., Alcalde Ibáñez, M. T., López Manzanares, L., Pérez Librero, P., Martín Gutiérrez, L., & Fernández Moriano, C. (2019). *Guía de actuación sobre la enfermedad de Parkinson para profesionales de Medicina de Atención Primaria y Farmacia Comunitaria*. Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. <https://www.farmaceuticos.com/wp-content/uploads/2021/03/2019-guia-parkinson.pdf>
- Rodríguez Escobar, J., Prieto Santos, N., Fernández González, R., García-Ramos García, R., Matías-Guiu Guía, J., Gómez Pastor, I., Martín Acero, T., & Carrasco Marín, L. (2022). *Abordaje del Parkinson y parkinsonismos*. https://www.sanidad.gob.es/areas/calidadAsistencial/estrategias/enfermedadesNeurodegenerativas/docs/ABORDAJE_PARKINSON_Accesible.pdf
- Sánchez Ferro, Á., Gómez Esteban, J. C., Jesús Maestre, S., Hernández González Monje, M., & et al. (2024). *Manual de práctica clínica en la enfermedad de Parkinson. Recomendaciones diagnóstico-terapéuticas de la SEN 2024*. <https://www.sen.es/pdf/2025/GuiaParkinson2024.pdf>
- Santos García, D., Alonso Losada, M. G., Cimas Hernando, I., Cabo López, I., Yáñez Baña, R., Alonso Redondo, R., Paz González, J. M., Cores Bartolomé, C., Feal Paineiras, M. J., Íñiguez Alvarado, M. C., Labandeira, C., & García Díaz, I. (2022). Vortioxetine Improves Depressive Symptoms and Cognition in Parkinson's Disease Patients with Major Depression: An Open-Label Prospective Study. *Brain Sciences*, 12(11), 1466. <https://doi.org/10.3390/brainsci12111466>

- Vellas, B., Guigoz, Y., Garry, P. J., Nourhashemi, F., Bennahum, D., Lauque, S., & Albarede, J.-L. (1999). The mini nutritional assessment (MNA) and its use in grading the nutritional state of elderly patients. *Nutrition*, 15(2), 116-122. [https://doi.org/10.1016/S0899-9007\(98\)00171-3](https://doi.org/10.1016/S0899-9007(98)00171-3)
- Vismara, M., Benatti, B., Nicolini, G., Cova, I., Monfrini, E., Di Fonzo, A., Fetoni, V., Viganò, C. A., Priori, A., & Dell'Osso, B. (2022). Clinical uses of Bupropion in patients with Parkinson's disease and comorbid depressive or neuropsychiatric symptoms: a scoping review. *BMC Neurology*, 22(1), 169. <https://doi.org/10.1186/s12883-022-02668-4>
- Wang, Z., Tian, J., Dai, W., Zhang, N., Wang, J., & Li, Z. (2024). The Effectiveness and Safety Analysis of Duloxetine in Treating Comorbid Depression in Parkinson's Disease: A Retrospective Study. *Actas Españolas de Psiquiatría*, 52(5), 607-615. <https://doi.org/10.62641/aep.v52i5.1634>
- Wenning, G. K., Stankovic, I., Vignatelli, L., Fanciulli, A., Calandra-Buonaura, G., Seppi, K., Palma, J.-A., Meissner, W. G., Krismer, F., Berg, D., Cortelli, P., Freeman, R., Halliday, G., Höglinger, G., Lang, A., Ling, H., Litvan, I., Low, P., Miki, Y., ... Kaufmann, H. (2022). The Movement Disorder Society Criteria for the Diagnosis of Multiple System Atrophy. *Movement Disorders*, 37(6), 1131-1148. <https://doi.org/https://doi.org/10.1002/mds.29005>
- Ye, Z., Altena, E., Nombela, C., Housden, C. R., Maxwell, H., Rittman, T., Huddleston, C., Rae, C. L., Regenthal, R., Sahakian, B. J., Barker, R. A., Robbins, T. W., & Rowe, J. B. (2014). Selective serotonin reuptake inhibition modulates response inhibition in Parkinson's disease. *Brain*, 137(4), 1145-1155. <https://doi.org/10.1093/brain/awu032>
- Zarit, S. H., Reever, K. E., & Bach-Peterson, J. (1980). Relatives of the Impaired Elderly: Correlates of Feelings of Burden. *The Gerontologist*, 20(6), 649-655. <https://doi.org/10.1093/geront/20.6.649>
- Zazpe, I., Sanchez-Tainta, A., Estruch, R., Lamuela-Raventos, R. M., Schröder, H., Salas-Salvado, J., Corella, D., Fiol, M., Gomez-Gracia, E., Aros, F., Ros, E., Ruíz-Gutierrez, V., Iglesias, P., Conde-Herrera, M., & Martinez-Gonzalez, M. A. (2008). A Large Randomized Individual and Group Intervention Conducted by Registered Dietitians Increased Adherence to Mediterranean-Type Diets: The PREDIMED Study. *Journal of the American Dietetic Association*, 108(7), 1134-1144. <https://doi.org/10.1016/j.jada.2008.04.011>
- Zigmond, A. S., & Snaith, R. P. (1983). The Hospital Anxiety and Depression Scale. *Acta Psychiatrica Scandinavica*, 67(6), 361-370. <https://doi.org/10.1111/j.1600-0447.1983.tb09716.x>

15. Annexos

Annex 1. Criteris de diagnòstic clínic de la MDS per a la MP

El primer criteri essencial és el parkinsonisme, que es defineix com a bradicinèsia, en combinació amb almenys un de tremolor de repòs o rigidesa. L'examen de totes les manifestacions cardinals s'ha de dur a terme com es descriu en la MDS-UPDRS (*Movement Disorder Society - Unified Parkinson's Disease Rating Scale*) (Postuma et al., 2015). Una vegada diagnosticat el parkinsonisme:

- El diagnòstic de la MP clínicament establert requereix:
 1. Absència de criteris d'exclusió absoluts.
 2. Almenys dos criteris de suport.
 3. Absència de banderes vermelles.
- El diagnòstic de MP clínicament probable requereix:
 1. Absència de criteris d'exclusió absoluts.
 2. Presència de banderes vermelles contrarestades per criteris de suport.
 - Si hi ha una bandera vermella, també ha d'haver-hi almenys un criteri de suport.
 - Si hi ha dues banderes vermelles, es necessiten almenys dos criteris de suport.
 - No es permeten més de dues banderes vermelles per a aquesta categoria.

A continuació, s'indiquen els criteris diagnòstics clínics de la MDS per a la MP (Postuma et al., 2015):

- **Criteris de suport:**
 1. Resposta beneficiosa a la teràpia dopaminèrgica. Durant el tractament inicial, el pacient torna al nivell de funció normal o gairebé normal. L'absència de documentació clara de la resposta es pot valorar mitjançant:
 - La millora marcada amb l'augment de la dosi o l'empitjorament amb la disminució de la dosi. Els canvis lleus no es qualifiquen. Aquesta resposta s'ha de documentar objectivament (> 30 % a l'UPDRS III amb canvi de tractament) o subjectivament (història clarament documentada de canvis marcats d'un pacient o cuidador fiable).
 - Les fluctuacions inequívokes i marcades d'encesa/apagada, que han de tenir en algun moment, incloent-hi el desgast previsible al final de la dosi.
 2. Presència de la discinèsia induïda per levodopa.
 3. Tremolor de repòs d'una extremitat, documentat en l'examen clínic (en el passat o en l'examen actual).
 4. La presència de pèrdua olfactiva o denervació cardíaca simpàtica en la gammagrafia amb metaiodobencilguanidina (MIBG).

- **Criteris d'exclusió (la presència de qualsevol d'aquestes característiques descarta la MP):**

1. Anormalitats cerebel·losoes demostrades de manera inequívoca a l'exploració (marxa cerebel·losa, dismetries, alteracions oculomotores cerebel·losoes, etc.).
2. Paràlisi supranuclear de la mirada vertical cap avall o alentiment selectiu de moviments verticals cap avall.
3. Diagnòstic probable de demència frontotemporal en la variant conductual o afàsia progressiva primària definides d'acord amb els criteris de consens dins dels primers cinc anys de la malaltia.
4. Signes parkinsonians limitats a extremitats inferiors durant més de tres anys.
5. Tractament amb antagonistes de receptors dopaminèrgics o agents esgotadors de dopamina utilitzats a una dosi i curs temporal consistents amb un parkinsonisme induït per fàrmacs.
6. Absència de resposta observable a la levodopa d'alta dosi malgrat almenys una gravetat moderada de la malaltia.
7. Pèrdua sensorial cortical no equívoca (és a dir, agorafestèsia, estereognòsia amb modalitats sensorials primàries intactes), apràxia ideomotora clara de les extremitats o afàsia progressiva.
8. Neuroimatge funcional normal del sistema dopaminèrgic presinàptic.
9. Documentació d'una condició alternativa coneguda per produir parkinsonisme i relacionada plausiblement amb els símptomes del pacient, o bé, el professional sanitari, basant-se en l'avaluació diagnòstica completa, considera que una síndrome alternativa és més probable que la MP.

- **Signes i símptomes d'alerta (banderes vermelles)**

1. Progressió ràpida del deteriorament de la marxa que requereix l'ús regular de la cadira de rodes a menys de cinc anys d'inici.
2. Absència completa de progressió de signes o símptomes motors de cinc anys o més.
3. Disfunció bulbar primerenca: disfonia greu o disàrtria (parla inintel·ligible bona part del temps) o disfàgia greu (requereix menjar suau, tub nasogàstric o alimentació de gastrostomia) dins dels primers cinc anys.
4. Disfunció respiratòria inspiratòria: estridor inspiratori diürn o nocturn o sospir inspiratori freqüent.
5. Insuficiència autònoma greu en els primers cinc anys de malaltia. Això pot incloure:
 - Hipotensió ortostàtica: decreixement ortostàtic de la pressió arterial en 3 min dret per almenys 30 mm Hg sistòlic o 15 mm Hg diastòlic,

en l'absència de deshidratació, medicació o altres malalties que puguin explicar plausiblement la disfunció autònoma.

- Retenció urinària greu o incontinència urinària en els primers cinc anys de malaltia (queda exclosa la incontinència d'estrès de llarga durada o petita quantitat en dones).

Això no és simplement una incontinència funcional. En els homes, la retenció urinària no ha de ser atribuïble a la malaltia de la pròstata, i ha d'estar associada a la disfunció erèctil.

6. Caigudes recurrents (més d'una a l'any) a conseqüència d'una alteració en l'estabilitat durant els primers tres anys d'evolució.
7. *Anterocollis* desproporcionat (distònic) o contractures de mà o peus dins dels primers 10 anys d'evolució.
8. Absència de qualsevol de les característiques no motores comunes de la malaltia després de cinc anys d'evolució. Aquestes inclouen disfunció del son (insomni del manteniment del son, somnolència diürna excessiva, símptomes del trastorn de comportament del son REM), disfunció autonòmica (constipació, urgència urinària diürna, ortostatisme simptomàtic), hipòsmia o disfunció psiquiàtrica (depressió, ansietat o al·lucinacions).
9. Signes del tracte piramidal sense explicació, definits com a debilitat piramidal o hiperreflexia patològica clara (excloses l'asimetria reflexa lleu i la resposta plantar extensora aïllada).
10. Parkinsonisme simètric bilateral. El pacient o el cuidador informa de l'aparició de símptomes bilaterals sense predomini lateral, que es confirma en l'examen objectiu.

• **Criteris d'aplicació - resposta (Sí/No)**

1. El pacient presenta parkinsonisme, tal com es defineix en els criteris de la MDS? Si «no», no es pot establir el diagnòstic de MP probable ni de MP clínicament establert. Si «sí»:
2. Hi ha criteris absoluts d'exclusió? Si «sí», no es pot diagnosticar la MP probable ni la MP clínicament establert. Si «no»:
3. Nombre de banderes vermelles presents.
4. Nombre de criteris de suport presents.
5. Hi ha almenys dos criteris de suport i cap bandera vermella?
Si «sí», el pacient es troba amb criteris clínicament establerts de la MP. Si «no»:
6. Hi ha més de dues banderes vermelles? Si «sí», no es pot diagnosticar la MP probable. Si «no»:

El nombre de banderes vermelles és igual o inferior al nombre de criteris de suport? Si «sí», el pacient compleix els criteris per a una MP probable.

Annex 2. Criteris de diagnòstic clínic de la MDS per a l'AMS

Els criteris de consens actuals per al diagnòstic de l'AMS són àmpliament utilitzats en la recerca clínica, però tenen una sensibilitat limitada per identificar la malaltia en etapes inicials. Per abordar aquestes limitacions, s'han desenvolupat nous criteris diagnòstics per a la MDS, basats en l'evidència i el consens.

D'aquesta manera, els criteris de la MDS per al diagnòstic de l'AMS defineixen quatre nivells de certesa diagnòstica:

- AMS neuropatològicament establerta, que correspon a la categoria d'AMS definitiva dels criteris de consens.
- AMS clínicament establerta, que prioritza l'especificitat amb una sensibilitat acceptable.
- AMS clínicament probable, que millora la sensibilitat mantenint l'especificitat.
- AMS prodròmica possible, orientada a identificar pacients en etapes molt primerenques, quan hi ha símptomes i signes, però aquests no compleixen el llindar per a una AMS clínicament establerta o probable.

Per al diagnòstic d'AMS clínicament establerta, es requereixen marcadors d'imatge per ressonància magnètica cerebral suggestius d'AMS. És probable que augmenti el nombre de biomarcadors de recerca que donin suport a totes les categories diagnòstiques clíniques. Per a més informació sobre els criteris diagnòstics, podeu consultar la referència bibliogràfica (Wenning et al., 2022).

Annex 3. Criteris de diagnòstic clínic de la MDS per a la PSP

La PSP és una entitat definida neuropatològicament. Els criteris diagnòstics clínics, publicats l'any 1996 per l'Institut Nacional de Trastorns Neurològics i Ictus i la Societat per a la PSP, presenten una especificitat excel·lent, però la seva sensibilitat és limitada per a les síndromes variants de la PSP amb presentacions diferents de la síndrome de Richardson. Per aquest motiu, un grup de professionals va desenvolupar un estudi per proporcionar una revisió dels criteris diagnòstics clínics per a la PSP basada en l'evidència i el consens.

Les troballes clíniques, d'imatge, de laboratori i genètiques definides actuen com a característiques bàsiques obligatòries, criteris d'exclusió obligatoris o criteris d'exclusió dependents del context. S'han identificat quatre dominis funcionals (disfunció motora ocular, inestabilitat postural, acinèsia i disfunció cognitiva) com a predictors clínics de la PSP. Dins de cadascun d'aquests dominis, es proposen tres característiques clíniques que aporten diversos nivells de certesa diagnòstica.

Les combinacions específiques d'aquestes característiques defineixen els criteris diagnòstics, que es classifiquen en tres nivells de certesa diagnòstica (PSP probable, PSP possible i indicativa de PSP). Les pistes clíniques i les troballes d'imatge es consideren característiques de suport. Per a més informació sobre els criteris diagnòstics, podeu consultar la referència bibliogràfica (Höglinger et al., 2017).

Nivells de certesa	Disfunció motora ocular	Inestabilitat postural	Acinèsia	Disfunció cognitiva
Nivell 1	O1: paràlisi supranuclear de la mirada vertical	P1: caigudes repetides no provocades en un termini de tres anys	A1: congelació progressiva de la marxa en un termini de tres anys	C1: trastorn del discurs/llenguatge, com la variant no fluida de l'afàsia progressiva primària o apràxia progressiva de la parla
Nivell 2	O2: velocitat lenta dels moviments sacàdics verticals	P2: tendència a caure en la prova del tiratge en un termini de tres anys	A2: parkinsonisme, acinètic-rígid, predominantment axial i resistent a la levodopa	C2: presentació cognitiva/comportamental frontal
Nivell 3	O3: sacsejades macroquadrades freqüents o apràxia d'obertura de les parpelles	P3: més de dos passos enrere en la prova del tiratge en un termini de tres anys	A3: parkinsonisme, amb tremolor i/o asimètric i/o sensible a la levodopa	C3: síndrome corticobasal

Font: *Clinical diagnosis of progressive supranuclear palsy: The movement disorder society criteria* (Höglinger et al., 2017)

Annex 4. Criteris de diagnòstic clínic de la MDS per a la DCB

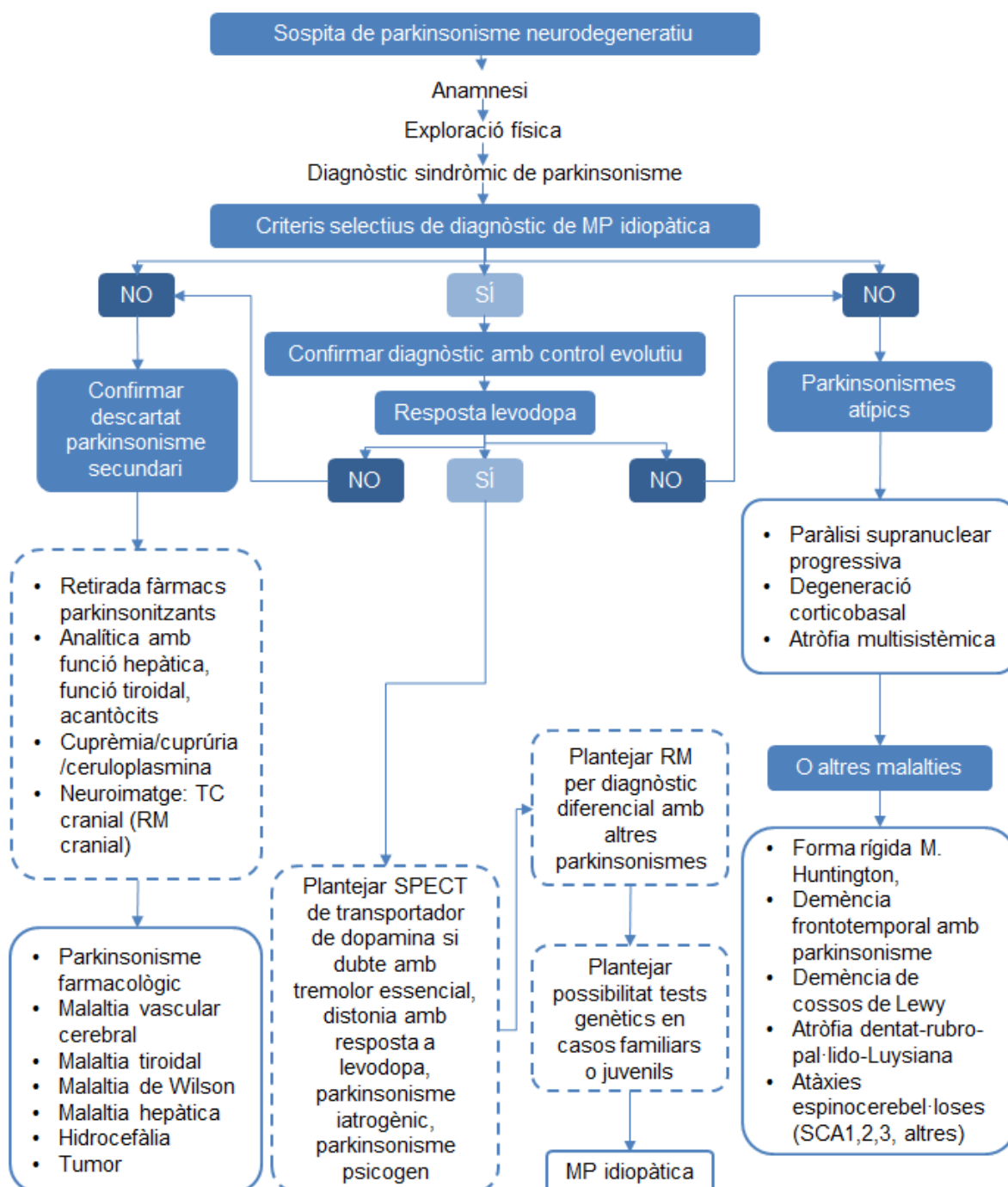
Els criteris actuals per al diagnòstic clínic de la DCB confirmada patològicament ja no reflecteixen la comprensió creixent d'aquesta malaltia i les seves correlacions clinicopatològiques. Un consorci internacional d'especialistes en neurologia del comportament, neuropsicologia i trastorns del moviment va desenvolupar nous criteris basats en consens i una revisió sistemàtica de la literatura.

Es va concloure que els criteris per a la CBD probable requereixen un inici insidiós i una progressió gradual durant almenys un any, amb una edat d'inici igual o superior als 50 anys, sense antecedents familiars similars ni mutacions conegudes de tau, i la presència d'un dels fenotips clínics següents: síndrome corticobasal probable o síndrome frontal de comportament espacial, o bé la variant no fluent/agramàtica de l'afàsia progressiva primària amb almenys una característica de síndrome corticobasal.

La categoria de DCB possible utilitza criteris similars, però no té restriccions d'edat ni antecedents familiars, permet mutacions de tau, admet un compliment

menys rigorós del fenotip i inclou un fenotip de síndrome de paràlisi supranuclear progressiva. Es necessita una validació i un refinament futur dels criteris proposats. Per a més informació sobre els criteris diagnòstics, podeu consultar la referència bibliogràfica (Armstrong et al., 2013).

Annex 5. Procés diagnòstic de la MP i dels PA en l'atenció especialitzada



Pla d'atenció a les persones afectades de malaltia de Parkinson i parkinsonismes atípics de Catalunya

Font: Guies mèdiques de la Societat Catalana de Neurologia, Protocol de diagnòstic i tractament de la malaltia de Parkinson (Gironell et al., 2016)

Annex 6. Eines de valoració de persones amb MP o PA

Escala de Hoehn & Yahr de la MP

És una escala ordinal que indica la situació evolutiva motora de la malaltia en els estadis següents (Hoehn et al., 1967):

- **Estadi 0:** no hi ha signes de malaltia.
- **Estadi 1:** malaltia exclusivament unilateral.
- **Estadi 2:** afectació bilateral sense alteració de l'equilibri.
- **Estadi 3:** afectació bilateral de lleu a moderada; una certa inestabilitat postural, però físicament independent.
- **Estadi 4:** incapacitat greu; encara capaç de caminar o quedar-se dempeus sense ajuda.
- **Estadi 5:** es queda en una cadira de rodes o enllitat si no té ajuda.

Escala de Schwab & England

S'utilitza per fer la valoració de la discapacitat de la persona en AVD (Schwab et al., 1969):

- **100 %:** completament independent. Capaç de fer totes les tasques sense lentitud ni dificultat. Essencialment normal. No conscient de cap dificultat.
- **90 %:** completament independent. Capaç de fer totes les tasques amb cert grau de lentitud i dificultat. Pot trigar el doble del que és normal. Comença a ser conscient de certa incapacitat.
- **80 %:** completament independent en la majoria de les tasques. Triga el doble del que és normal. Consciència de dificultat i alentiment.
- **70 %:** no completament independent. Més dificultats en algunes tasques. Triga tres o quatre vegades més del que és normal per fer-ne algunes. Pot passar la major part del dia en les tasques.
- **60 %:** alguna dependència. Pot fer la majoria de les tasques, però d'una manera excessivament lenta i amb molt d'esforç. Errors i algunes tasques impossibles.
- **50 %:** més dependent. Ajuda en la meitat de les tasques: molt lent. Dificultat en quasi tot.
- **40 %:** molt dependent. Pot ajudar en algunes coses, però en pot fer poques sol.
- **30 %:** amb esforç pot fer algunes tasques o començar-les sol. Necessita molta ajuda.
- **20 %:** no pot fer res sol. Pot ajudar una mica en algunes coses. Invalidesa greu.
- **10 %:** totalment dependent. Completament invàlid.

Pla d'atenció a les persones afectades de malaltia de Parkinson i parkinsonismes atípics de Catalunya

- **0 %**: disfàgia i incontinència esfinteriana. Enllitat.

Escala de Lawton i Brody

S'utilitza per avaluar la capacitat funcional en gent gran a l'hora de fer AIVD (Lawton & Brody, 1969):

- **0-1**: dependència total
- **2-3**: dependència greu
- **4-5**: dependència moderada
- **6-7**: dependència lleugera
- **8**: independència total

Índex de Barthel

S'utilitza per valorar la dependència en la realització de les ABVD. La interpretació de l'índex és (Cid-Ruzafa & Damián-Moreno, 1995)

- **0-20**: dependència total
- **21-60**: dependència greu
- **61-90**: dependència moderada
- **91-99**: dependència escassa
- **100**: independència

Annex 7. Pla de cures estàndard dirigit a la persona afectada de MP a l'APiC

Aquest apartat descriu el Pla de cures específic (PCE) per a la MP, amb les intervencions i les activitats dirigides a donar resposta al judici clínic infermer a partir d'una valoració integral de la persona, del seu entorn i de la persona cuidadora.

Aquesta valoració permet identificar necessitats i problemes de salut en les diferents dimensions (física, emocional, cognitiva i social) i establir un pla de cures individualitzat.

Les intervencions infermeres tenen com a objectiu prevenir complicacions, mantenir la funcionalitat, potenciar l'autonomia i aconseguir el millor estat de salut possible mitjançant la planificació d'activitats adaptades a cada persona.

És convenient individualitzar el PCE per a cada persona en funció de la valoració integral i de l'evolució de la malaltia.

Pla de cures pels estadis I, II i III:

Risc d'afrontament inefectiu: La persona és vulnerable o presenta factors de risc de desenvolupar una resposta d'adaptació a una situació, un conflicte o una crisi, amb activació de funcions cognitives i comportamentals, deteriorament de la capacitat per prendre decisions i dificultats per resoldre problemes o utilitzar els recursos disponibles.

Les intervencions s'orienten a afavorir l'adaptació al diagnòstic, donar suport emocional i capacitar la persona en l'autocura mitjançant:

- Pacte terapèutic amb la persona.
- Informació sobre el document de voluntats anticipades (DVA).
- Ús de l'entrevista motivacional.
- Educació sanitària sobre el procés de la malaltia.
- Cribratge d'ansietat i depressió (HADS).
- Valoració del risc social (TIRS).
- Consell sobre xarxes d'ajuda i recursos comunitaris.

Risc de deteriorament funcional: La persona és vulnerable o presenta factors de risc de desenvolupar un agreujament progressiu i accelerat de la capacitat cognitiva, la mobilitat i el funcionament per a l'autocura, amb pèrdua d'autonomia.

Les intervencions s'orienten a la detecció precoç del deteriorament, la prevenció de la dependència i el manteniment de la funcionalitat mitjançant la planificació de les activitats següents:

- Valoració de l'estat i de l'evolució de la dependència per a les activitats bàsiques i instrumentals de la vida diària (escala de Barthel i escala de Lawton i Brody) (Cid-Ruzafa & Damián-Moreno, 1995; Lawton & Brody, 1969).
- Cribratge del deteriorament cognitiu (GPCOG, MIS, maniobra de distracció i test del rellotge) (Brodaty et al., 2002; Buschke et al., 1999; Park et al., 2018).
- Avaluació del dolor crònic (escala de gradació del dolor crònic) (Ferrer-Peña et al., 2016).
- Valoració de la qualitat de vida percebuda en relació amb la salut (escala EuroQol 5D-5L) (Herdman et al., 2011).
- Valoració de la fragilitat (índex Fràgil-VIG) (Amblàs-Novellas et al., 2017).
- Valoració de l'equilibri, la marxa i la força muscular (test Timed Up and Go) (Browne & Nair, 2019).

- Avaluació del nombre de caigudes i de les circumstàncies que les afavoreixen, i educació sanitària per prevenir-les.
- Adequació de la llar: valoració de l'equipament bàsic que garanteix que la persona pugui assolir unes condicions de vida saludables i dels elements que li poden generar situacions de risc i valoració dels elements que poden generar situacions de risc a la persona.
- Educació sanitària sobre la medicació per tal que la persona sigui responsable del seu maneig, i valoració de l'adherència mitjançant la revisió periòdica de la dosi, l'horari, les condicions de presa, la manera com pren la medicació i la presència d'efectes secundaris.
- Abordatge de la incontinència urinària tenint en compte com afecta la qualitat de vida de la persona i el deteriorament que comporta en l'activitat social, l'autoestima i l'estabilitat emocional.
- Promoció de l'exercici físic per mantenir o millorar la salut i prevenir altres malalties.
- Seguiment de l'estat nutricional (test Mini Nutritional Assessment) (Vellas et al., 1999).
- Cribratge de la disfàgia (escala Eating Assessment Tool-10 [EAT-10]) (Burgos et al., 2012).
- Recomanacions sobre alimentació i valoració de l'adherència a la dieta mediterrània (escala PREDIMED) (Zazpe et al., 2008).
- Promoció d'hàbits saludables tenint en compte els aspectes següents: hàbits higiènics adequats, sexualitat, promoció d'un son saludable, salut emocional, seguretat i prevenció d'accidents, evitació del consum de substàncies tòxiques i vacunació.

Pla de cures pels estadis IV i V:

Risc d'afrontament infecciu: La persona és vulnerable o presenta factors de risc de desenvolupar una resposta d'adaptació a una situació, un conflicte o una crisi, amb activació de funcions cognitives i comportamentals, deteriorament de la capacitat per prendre decisions i dificultats per resoldre problemes o utilitzar els recursos disponibles.

Les intervencions s'orienten a donar suport emocional davant l'evolució de la malaltia i a capacitar la persona en l'autocura mitjançant:

- Escolta activa, acompanyament emocional, planificació de decisions anticipades (PDA) i implicació de l'entorn cuidador.
- Informació sobre el document de voluntats anticipades (DVA).

- Educació sanitària sobre el procés de la malaltia, els signes d'alarma i les actuacions corresponents.
- Cribratge d'ansietat i depressió (HADS) (Zigmond & Snaith, 1983).
- Valoració del risc social (TIRS) (García González et al., 1999).
- Consell sobre xarxes d'ajuda i recursos comunitaris.
- Adaptació de la comunicació a possibles alteracions de la parla, incorporant estratègies verbals i no verbals i recursos alternatius quan calgui.
- Reforç de l'educació sanitària sobre la promoció d'un son saludable.
- Educació sanitària sobre la medicació per tal que la persona sigui responsable del seu maneig, i valoració de l'adherència mitjançant la revisió periòdica de la dosi, l'horari, les condicions de presa, la manera com pren la medicació i la presència d'efectes secundaris.
- Cribratge del deteriorament cognitiu (GPCOG, MIS, maniobra de distracció i test del rellotge) (Brodaty et al., 2002; Buschke et al., 1999; Park et al., 2018).
- Valoració de l'HexCom-RED com a eina facilitadora de l'aplicació del model de cures interdisciplinari i integral, centrat en la persona, la seva família o l'entorn cuidador, per a l'atenció de persones en situació de malaltia avançada o de final de vida (Busquet Duran et al., 2021).
- Valoració de la fragilitat (índex Fràgil-VIG) (Amblàs-Novellas et al., 2017).

Deteriorament neuromuscular crònic: La persona presenta una pèrdua progressiva, generalment irreversible, del funcionament, la força i el to muscular, que limita la mobilitat i l'activitat.

Les intervencions s'orienten a prevenir la dependència, mantenir la funcionalitat i proporcionar mesures de confort en les etapes més avançades mitjançant la planificació de les activitats següents:

- Valoració de l'estat i de l'evolució de la dependència per a les activitats bàsiques i instrumentals de la vida diària (escala de Barthel i escala de Lawton i Brody) (Cid-Ruzafa & Damián-Moreno, 1995; Lawton & Brody, 1969).
- Valoració de la qualitat de vida percebuda en relació amb la salut (escala EuroQol 5D-5L) (Herdman et al., 2011).
- Avaluació del dolor crònic (escala de gradació del dolor crònic) (Ferrer-Peña et al., 2016).
- Recondicionament de les activitats, ja que les cures se centren més intensament en el deteriorament neuromuscular, les mobilitzacions, els

canvis posturals, les mesures de confort, la protecció cutània i la prevenció de nafres.

- Valoració dels hàbits d'higiene i de vestit, ja que la dependència progressiva de la persona afectada per la MP també influirà a l'hora de dur a terme les cures personals d'higiene i de vestit.
- Exploració davant la possibilitat d'incontinència urinària o de restrenyiment.
- Avaluació del nombre de caigudes i de les circumstàncies que les afavoreixen, i educació sanitària per prevenir-les.
- Adequació de la llar: valoració de l'equipament bàsic que garanteix que la persona pugui assolir unes condicions de vida saludables i dels elements que li poden generar situacions de risc.

Risc de desnutrició: La persona és vulnerable o presenta factors de risc d'experimentar una depauperació progressiva de l'organisme a causa d'una aportació diària insuficient de calories, vitamines, glúcids, greixos, proteïnes i minerals necessaris per cobrir la despesa energètica de l'organisme.

Les intervencions s'orienten a prevenir la desnutrició i la broncoaspiració mitjançant la planificació de les activitats següents:

- Seguiment de l'estat nutricional (test Mini Nutritional Assessment) (Vellas et al., 1999).
- Recomanacions sobre alimentació amb l'objectiu d'identificar aspectes clau que, amb petites modificacions, poden millorar de manera important la qualitat i la sostenibilitat de l'alimentació.
- Cribratge de la disfàgia (qüestionari Eating Assessment Tool-10 [EAT-10]) (Burgos et al., 2012).
- Valoració del volum i la viscositat dels àpats (MECV-V) (Ferrero López et al., 2009).
- Educació sanitària per prevenir la broncoaspiració.

Risc de claudicació familiar: La persona cuidadora principal, o un o més membres de la família, és vulnerable o presenta factors de risc d'experimentar una sensació incapacitant d'esgotament físic, emocional, social i espiritual que provoca incapacitat i disminució de la voluntat i de l'energia per continuar proporcionant cures al pacient o a la persona dependent i participant en els processos de presa de decisions relacionats.

Les intervencions s'orienten a prevenir la claudicació de l'entorn cuidador en les etapes de més dependència de la persona amb MP mitjançant la planificació de les activitats següents:

Pla d'atenció a les persones afectades de malaltia de Parkinson i parkinsonismes atípics de Catalunya

- Escolta activa de la família i facilitació de l'expressió i la reconducció de les emocions. S'ofereix suport per afrontar la situació i orientació sobre xarxes d'ajuda i recursos comunitaris.
- Avaluació de la sobrecàrrega de la persona cuidadora (escala de Zarit reduïda).

Annex 8. Criteris del qüestionari CEPA per al diagnòstic de la MP avançada

Nivell de rellevància	Característiques generals	Discapacitat de símptomes motors relacionats amb el tractament	Símptomes motors relacionats amb el tractament	Símptomes motors relacionats amb la malaltia	Símptomes no motors relacionats amb la malaltia	Trastorns neuropsiquiàtrics i cognitius
Símptomes definitius (un sol símptoma és determinant per fer el diagnòstic de MP avançada)		Requeriment d'ajuda per a les AVD	Presenta fluctuacions motores amb un temps de vigília en <i>off</i> del 25 % amb limitació per dur a terme activitats bàsiques, encara que no requereixi ajuda	Disfàgia greu Caigudes recurrents		Demència
Símptomes probables (l'associació de dos símptomes el converteix en definitiu)	Temps d'evolució de la MP de 10 anys o més	Limitació per a activitats bàsiques, encara que no requereixi ajuda	Discapacitat funcional per discinèsia amb un temps de vigília <i>on</i> del 25 %	Disfàgia moderada Bloquejos de la marxa Disàrtria moderada/greu		Al·lucinacions amb falta d' <i>insight</i>

Pla d'atenció a les persones afectades de malaltia de Parkinson i parkinsonismes atípics de Catalunya

Síntomes probables (l'associació de dos símptomes el converteix en probable)				Alteració de reflexos posturals i equilibri	Disautonomia simptomàtica, incloent-hi hipotensió ortostàtica simptomàtica Somnolència diürna excessiva	Apatia moderada/greu Presència crònica d'al·lucinacions amb <i>insight</i> preservat Síntomes psicòtics Deteriorament cognitiu lleu
---	--	--	--	---	--	--

Font: *Consensus on the Definition of Advanced Parkinson's Disease: A Neurologists-Based Delphi Study (CEPA Study)* (Luquin et al., 2017)

Annex 9. Fluctuacions i discinèsies

Síntoma	Característiques
Fluctuacions motores	
▪ Deteriorament de fi de dosi o <i>wearing-off</i> ▪ Absència matinal.	Habitualment predictibles i generalment relacionats amb els nivells plasmàtics de levodopa.
▪ <i>Off</i> sobtat impredecible.	No relacionat amb la presa de levodopa. Aparició aguda de símptomes parkinsonians.
▪ Fallada de dosi (<i>delayed on, partial on, dose failure</i>). ▪ Empitjorament d'inici de dosi o <i>beginning of dose worsening</i>.	Empitjorament de símptomes després de la dosi de levodopa i posterior millora.
▪ Rebot de final de dosi o <i>end of dose rebound</i>.	Rebot de símptomes més intensos al final de dosis.
▪ Fluctuacions <i>on-off/yo-yoing</i>.	Oscil·lacions a l'atzar. Canvis bruscos de símptomes durant el curs d'una dosi de levodopa.
Fluctuacions no motores	
▪ Neuropsiquiàtriques: ○ Síntomes "on": eufòria, agitació, al·lucinacions, psicosi. ○ Síntomes "off": apatia o ànim deprimit. ▪ Autonòmiques ▪ Sensorials	Poden fluctuar en resposta a la levodopa.
Discinèsies de dosis altes de levodopa	
S'expressen en forma de corea, distonia, bal·lisme, mioclònies: ▪ Discinèsies de pic de dosi ▪ Discinèsies en altiplà ▪ Discinèsia ocular ▪ Discinèsia respiratòria ▪ Mioclònia	▪ Es produeixen en l'estat <i>on</i> 1-2 hores després de la dosi de levodopa. ▪ Sol acompanyar les discinèsies de pic de dosi. ▪ Poden ser oculogires o moviment de vaivé. ▪ Ritme respiratori irregular en pics de dosi. ▪ Es pot presentar als 10-20 minuts de la dosi de levodopa.
Discinèsies de dosis altes de levodopa	

▪ Distonia precoç matutina ▪ Blefarospasme ▪ Distonia d'obertura mandibular ▪ Distonia d'extremitats i cervical ▪ Estridor laringi	▪ Es presenten durant el període <i>off</i> coincidint amb nivells plasmàtics de levodopa baixos. ▪ Afecten amb més freqüència cames i peus.
Discinèsies bifàsiques	
	▪ Es produeixen a l'inici o al final del benefici d'una dosi baixa de levodopa. ▪ Afecten principalment les extremitats inferiors.

Font: *Manual de práctica clínica en la enfermedad de Parkinson* (Sánchez Ferro et al., 2024)

Annex 10. Tractaments farmacològics dels símptomes motors de la MP

2Fàrmac	Indicacions	Grau de recomanació Monoteràpia	Grau de recomanació Teràpia adjuvant
Levodopa - Inhibidors de la descarboxilasa (IDC)	Símptomes motors	A	A
Agonistes dopaminèrgics			
Pramipexole	Símptomes motors	A	A
Ropinirole	Símptomes motors	A	A
Rotigotina	Símptomes motors	A	A
IMAO-B			
Selegilina	Símptomes motors	A	U
Rasagilina	Símptomes motors	A	A
ICOMT			
Entacapona	Fluctuacions motores	-	A
Opicapona	Fluctuacions motores	-	A
Tolcapona	Fluctuacions motores	-	A
Anticolinèrgics	Tremolor	U	U

Amantadina	Discinèsies	U	B
Safinamida	Fluctuacions motores	-	A
Blocadors β	Tremolor	U	U
Clozapina	Tremolor	-	C

Font: *Guia mèdica de la Societat Catalana de Neurologia: Diagnòstic i tractament de la malaltia de Parkinson*, 2016. Graus de recomanació definits per la guia mèdica de la Societat Catalana de Neurologia (Gironell et al., 2016)

Annex 11. Tractaments farmacològics dels símptomes motors dels PA

3Fàrmac	Indicacions	Dosi	Grau de recomanació
DCB			
Levodopa	Símptomes acinètic-rígid	3-4 × 100-200 mg	B
Toxina botulínica de tipus A	Distonia focal	-	B
Baclofèn	Distonia	Fins a 40 mg/dia	0
Clonazepam	Mioclònia	2-6 mg/dia	B
Propranolol	Tremolor	80-120 mg/dia, dosi màxima de 320 mg/dia	B
PSP			
Levodopa	Símptomes acinètic-rígid	3-4 × 100-200 mg	B
Amantadina	Símptomes acinètic-rígid	3 × 100-200 mg	0
Amitriptilina	Dèficits oculomotors	1 × 75-150 mg	0
Zolpidem	Trastorn del son	1 × 5-10 mg	0
Coenzim Q10	Símptomes motors i neuropsicològics	2 × dia, $\geq 2,5 \mu\text{g/mL}$ concentració del sèrum	A
Toxina botulínica de tipus A	Distonia focal		0
AMS			
Levodopa	Símptomes acinètic-rígid	3-4 × 100-200 mg	B
Amantadina	Símptomes acinètic-rígid	3 × 100-200 mg	0

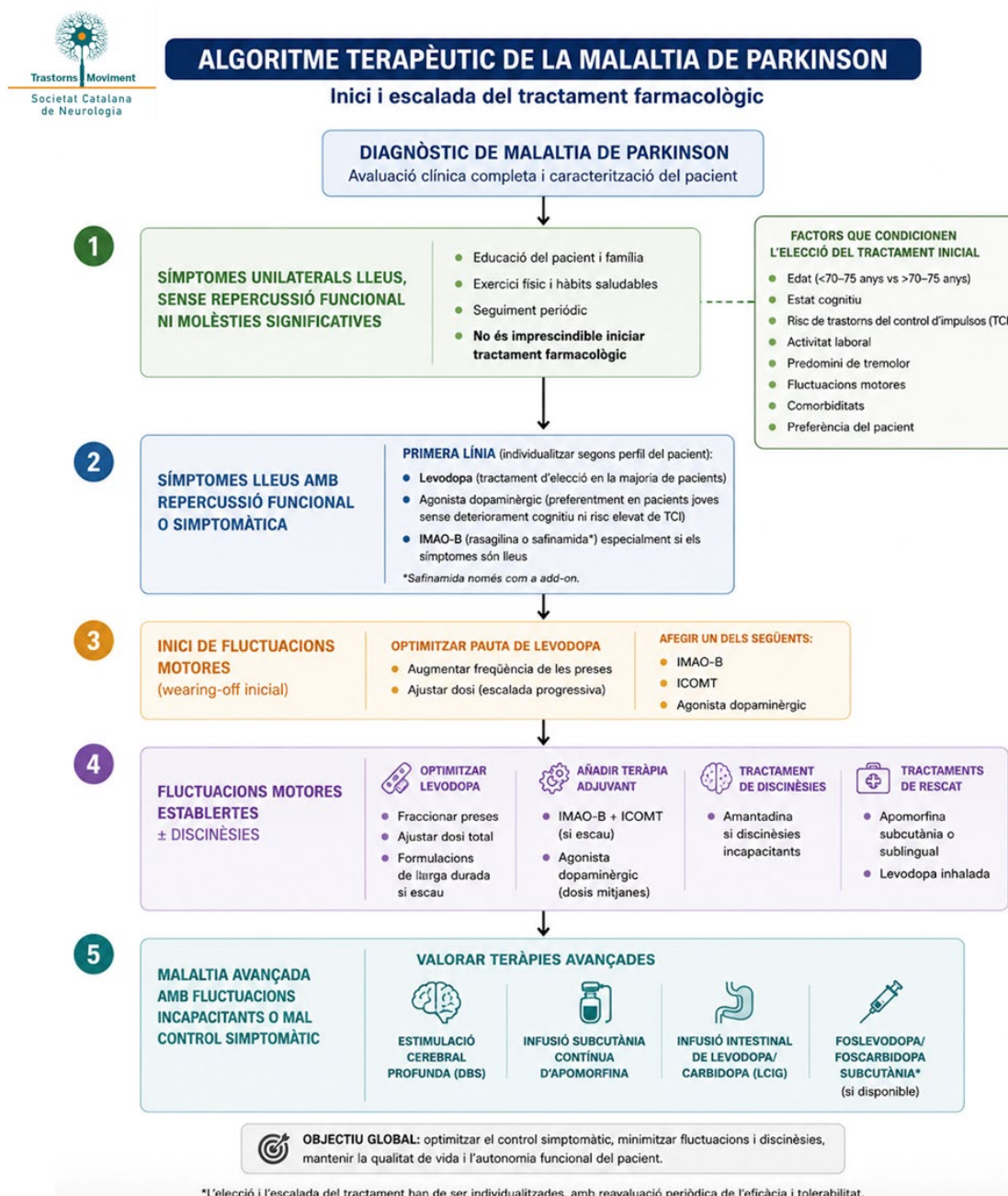
Pla d'atenció a les persones afectades de malaltia de Parkinson i parkinsonismes atípics de Catalunya

Toxina botulínica de tipus A	Distonia focal	-	
Droxidopa	Hipotensió ortostàtica	2 × 200-600 mg	A
Efedrina	Hipotensió ortostàtica	3 x 15-45 mg	0
Midodrina	Hipotensió ortostàtica	3 × 5-10 mg	A
Fludrocortisona	Hipotensió ortostàtica	1-3 × 0,1 mg	0
Octreotida	Hipotensió ortostàtica	25-50 mg 30 minuts abans àpats	0
Desmopressina	Poliúria nocturna	10-40 µg esprai, 100-400 µg comprimits	0
Oxibutinina	Incontinència urinària	2-3 × 2,5-5 mg	0

Grau de recomanació: A (recomanació forta, "s'ha de"), B (recomanació), 0 (recomanació oberta, "es pot").

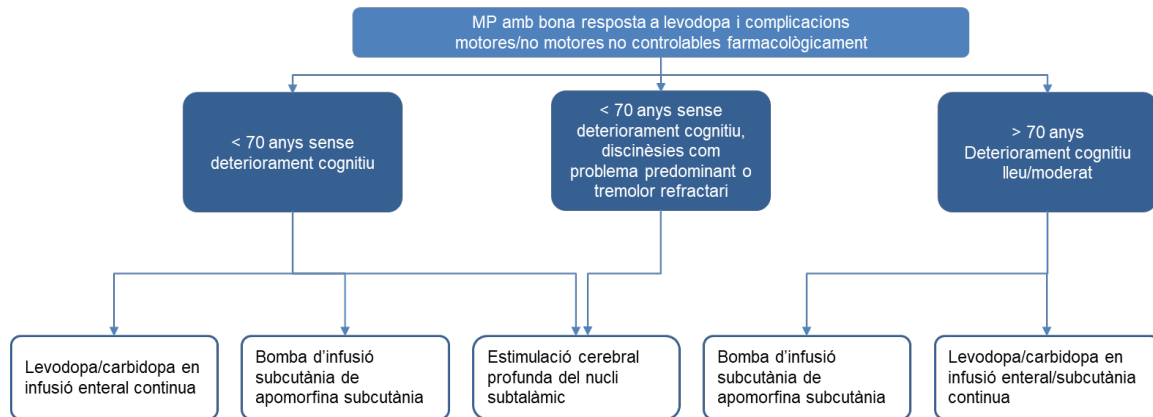
Font: *The differential diagnosis and treatment of atypical parkinsonism* (Levin et al., 2016)

Annex 12. Algorisme terapèutic de la malaltia de Parkinson



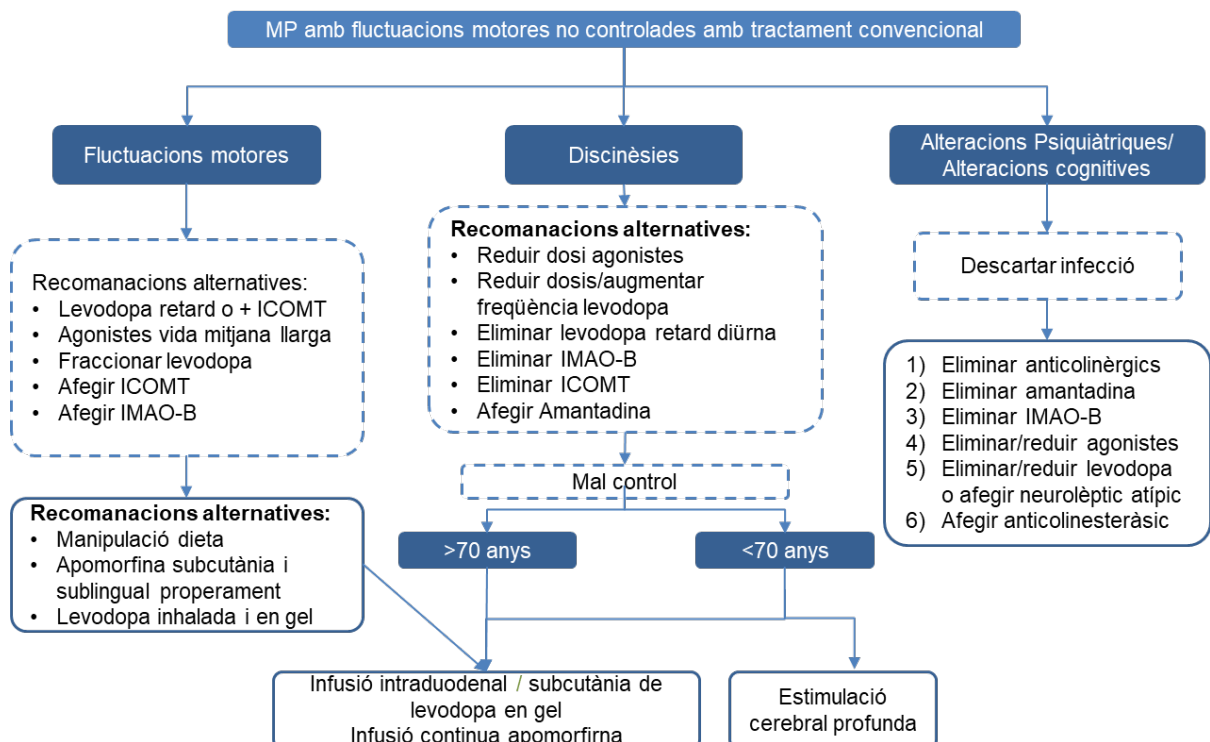
Elaboració per la Societat Catalana de Neurologia (Alexandra Pérez-Soriano i Helena Bejr-Kasem; 2026)

Annex 13. Algoritme per al tractament de la MP en fase moderada: teràpies de segona línia o complexes



Font: *Guies mèdiques de la Societat Catalana de Neurologia, Protocol de diagnòstic i tractament de la malaltia de Parkinson* (Gironell et al., 2016)

Annex 14. Recomanació de tractament segons la presència de complicacions motores en MP



Font: *Guies mèdiques de la Societat Catalana de Neurologia, Protocol de diagnòstic i tractament de la malaltia de Parkinson* (Gironell et al., 2016)

Annex 15. Tractaments farmacològics dels símptomes no motors

Síntoma no motor	Fàrmac	Dosificació	Grau de recomanació
Nàusees	Domperidona	10 mg 1-1-1 màx. 20 mg 1-1-1	C
Trastorn de conducta associat amb el son REM	Clonazepam	0,25-2 mg abans de dormir	U
	Melatonina	3-15 mg abans de dormir	U
Depressió	Fluoxetina	10-50 mg al matí	B
	Paroxetina	20-40 mg al matí	B
	Sertralina	25-200 mg al matí	B
	Venlafaxina	37,5-225 mg al matí	B
	Nortriptilina	25-150 mg/dia dosi única o partida	C
	Pramipexole	0,7 mg 1-1-1	U
Al·lucinacions	Clozapina	25-75 mg/dia Dosi única o partida	B
	Quetiapina	6,25-150 mg Dosi única abans de dormir	C
	Rivastigmina	1,5-6 mg 1-0-1 Pegat 4,5-9,5 mg/dia	C
	Ziprasidona	20-80 mg/dia Dosi única abans de dormir o partida	C
Demència	Rivastigmina	1,5-6 mg 1-0-1 Pegat 4,5-9,5 mg/dia	B
	Donepezil	5-10 mg/dia Dosi única	B
	Galantamina	4-12 mg 1-0-1	U
	Memantina	10-20 mg/dia Dosi única	U

Síntoma no motor	Fàrmac	Dosificació	Grau de recomanació
Hipotensió ortostàtica	Fludrocortisona	0,05-0,1 mg Dosi única o partida	C
	Domperidona	10 mg 1-1-1 màx. 20 mg 1-1-1	C
	Midodrina	2,5-10 mg 1-1-1	U
Sialorrea	Toxina botulínica	Varia segons la formulació	B
	Anticolinèrgics		B

Graus de recomanació definits per l'Acadèmia Americana de Neurologia. A: eficàcia establerta; B: eficàcia probable; C: eficàcia possible; U: dades inadequades o conflictives.

Adicionalment als fàrmacs que es mostren a la referència (Gironell et al., 2016), segons altres evidències, en depressió també s'inclou: citalopram (també útil en conducta impulsiva) (Ye et al., 2014), duloxetine (Wang et al., 2024), bupropió (Vismara et al., 2022), vortioxetina (Santos García et al., 2022).

Font: *Guies mèdiques de la Societat Catalana de Neurologia, Protocol de diagnòstic i tractament de la malaltia de Parkinson* (Gironell et al., 2016)

Annex 16. Les intervencions de rehabilitació en MP i PA

El [Pla de rehabilitació de Catalunya](#) recull les intervencions dels serveis de rehabilitació en la MP i els PA següents:

Estructura i funcions corporals i avaluació	Intervencions
Funcions cognitives superiors, judici, categorització o flexibilitat cognitiva, memòria i atenció <u>Avaluació:</u> ▪ <i>Montreal Cognitive Assessment</i> ▪ <i>Mini-Mental State Examination</i> ▪ Programa integrat d'exploració neuropsicològica, Test Barcelona-2 ▪ Bateria Neuronorma ▪ <i>Memory Impairment Screen (MIS)</i> ▪ Resultat maniobra distracció	▪ En persones sense demència, entrenament en memòria de treball, memòria verbal i funcions executives amb material verbal i visual. ▪ Entrenament cognitiu en atenció, programa <i>Attention Process Training</i> i memòria declarativa amb material verbal i visual. ▪ La pràctica d'exercici físic, tres cops per setmana, en persones amb cognició intacta o deteriorament cognitiu lleu per MP, té un efecte beneficiós en la cognició. ▪ Adaptació de l'entorn. ▪ Tecnologia compensatòria. Presencial o telemàtic. Pot ser en grup.

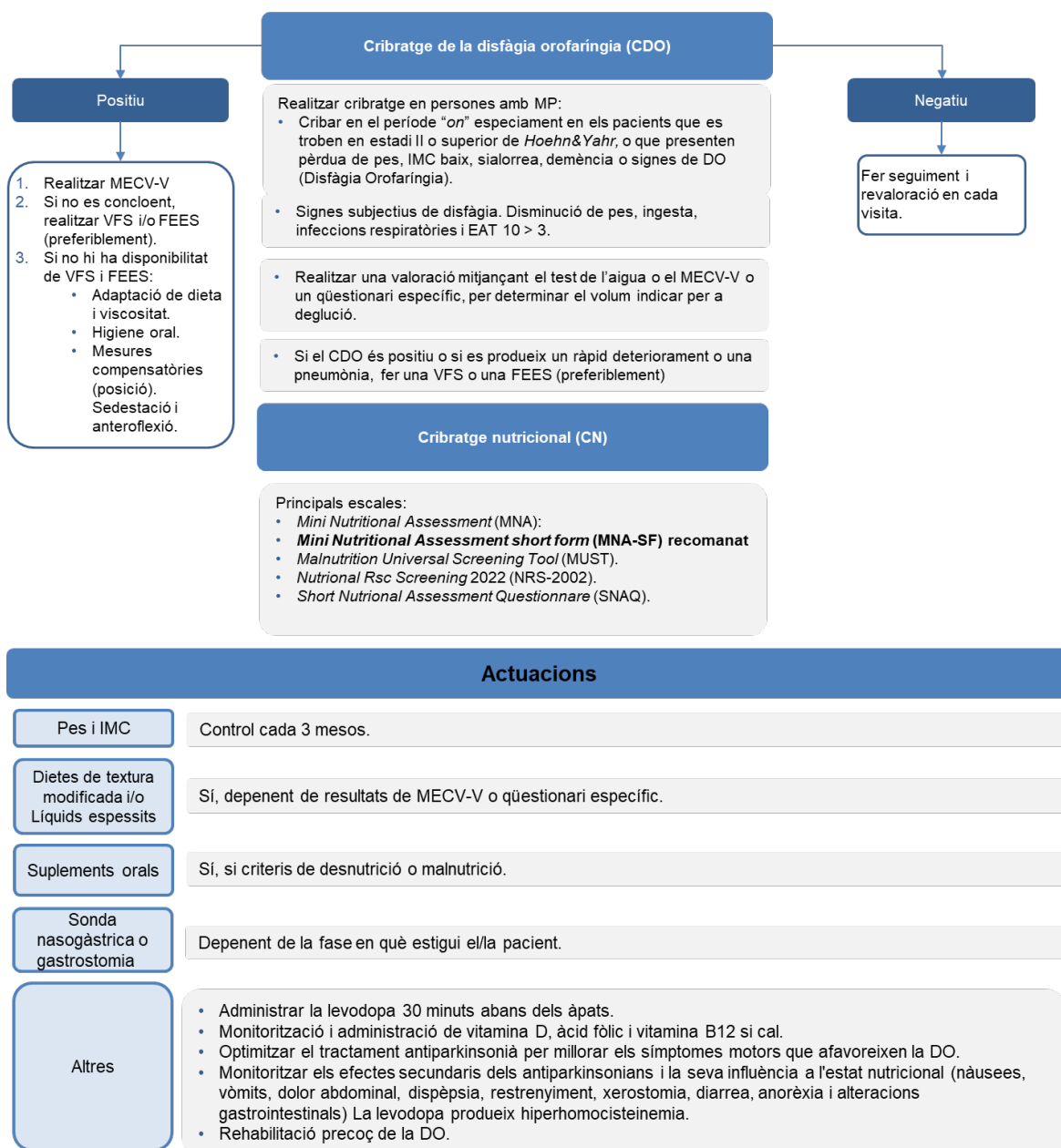
Estructura i funcions corporals i avaluació	Intervencions
▪ <i>General Practitioner Assessment of Cognition</i> ▪ Test del rellotge	
Força i resistència muscular <u>Avaluació:</u> ▪ Escala d'Oxford o Daniels	▪ Reentrenament muscular multicomponent. ▪ Exercici terapèutic que ha d'incloure l'aeròbic, els estiraments de la musculatura flexora, com dels isquiotibials i els bíceps, i les activitats de força —sobretot en la musculatura extensora com el quàdriceps i el tríceps—, les contraccions isomètriques i treball de flexibilitat. S'han de fer en el període <i>on</i>, quan la persona té una bona resposta a la medicació. És possible que l'exercici no alenteixi la progressió de l'acinèsia o la rigidesa, però pot alleujar alguns efectes ortopèdics secundaris com el dolor d'espatlla, maluc i esquena i millorar la funció en algunes tasques motores.
Mobilitat de les articulacions: bradicinèsia, disminució de balanç articular, rigidesa <u>Avaluació:</u> ▪ Rang de mobilitat (goniometria) ▪ Palpació i mobilització passives de les articulacions per avaluar la rigidesa i la mobilitat articular	▪ Prescripció d'ortesis i productes de suport (inclou la cadira de rodes). ▪ Mobilitzacions articulars actives i autoassistides per arribar al màxim de balanç articular. ▪ Facilitació neuromuscular propioceptiva per disminuir la rigidesa. ▪ Mètode Bobath per disminuir el to muscular. ▪ Estímuls vibratoris. ▪ Tècniques de teràpia manual.
Funcions relacionades amb el to muscular i la distonia. Sensacions relacionades amb la rigidesa <u>Avaluació:</u> ▪ Rang de mobilitat (goniometria)	▪ Tractament farmacològic (p. ex. clonazepam, baclofèn). ▪ Injeccions de toxina botulínica. ▪ Estimulació cerebral profunda en casos més greus de distonia o de baixa resposta amb altres tractaments. ▪ Teràpia manual i mobilització articular. ▪ Realització d'estiraments.
Equilibri i altres funcions relacionades amb els reflexos de moviment involuntari <u>Avaluació:</u>	▪ Reeduació de l'equilibri i prevenció de caigudes. ▪ Taitxí. ▪ Reentrenament postural.

Estructura i funcions corporals i avaluació	Intervencions
▪ <i>Berg Balance Scale</i> ▪ <i>Test Up Go</i>	▪ Treball de psicomotricitat. ▪ Dansa. Es poden fer servir tècniques d'entrenament amb realitat virtual (en estadis 0-3).
Funcions de la veu i de la parla <u>Avaluació:</u> ▪ <i>Frenchay Dysarthria Assesment</i> o <i>Robertson Dysarthria Profile</i> ▪ Anàlisi acústica de la fonació, la ressonància i la prosòdia. ▪ <i>Intelligibility rating scale for motor speech disorders.</i> ▪ <i>Assessment of intelligibility of Dysarthric Speech</i>	▪ Programa d'exercicis de fonació i articulació: <i>Lee Silverman voice treatment.</i> ▪ Exercicis de freqüència de moviments alterns i en seqüència. Programa <i>Be Clear.</i> Pot ser en grup.
Funcions relacionades amb la deglució. Disfàgia <u>Avaluació</u> ▪ EAT-10. ▪ Exploració de la musculatura orofacial sense bolus ▪ MECV-V (avaluació amb bolus) ▪ Fibroendoscòpia de la deglució (FEES) o videofluoroscòpia (VFS)	▪ Exercicis de deglució: exercicis de força, to i coordinació muscular principalment, llavis, galtes, llengua. ▪ Maniobres facilitadores de la deglució (amb aliment o sense). Protecció de la via aèria i facilitació del pas d'embolades. Tècniques d'increment sensorial de les estructures relacionades. ▪ Modificacions de l'entorn durant l'acte deglutori. ▪ Adaptació de la textura de la dieta i la viscositat dels líquids. ▪ Adaptació de pròtesis intraorals. ▪ Injeccions de toxina botulínica. ▪ Higiene oral. ▪ Educació sobre disfàgia a la persona, la família i l'entorn cuidador. Intervencions no recomanades per millorar la funció velofaríngia: bufar i xuclar; control del flux d'aire amb boles, palletes i altres.
Alteracions de les funcions emocionals <u>Avaluació:</u> ▪ <i>Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS)</i> ▪ <i>Beck depression inventory</i> ▪ Escala d'ansietat de Hamilton o <i>Neuropsychiatric inventory</i>	▪ Teràpia psicològica.

Estructura i funcions corporals i avaluació	Intervencions
Canvi postural i transferències. Caminar i mobilitat global <u>Avaluació:</u> ▪ <i>Functional Ambulation Classification</i> ▪ <i>Timed up and go test</i> ▪ Índex de Barthel	▪ Entrenament de transferències. ▪ Tècniques de manutenció manual, mecànica o motoritzada. ▪ Educació sanitària adreçada als cuidadors. ▪ Reeducació del patró de la marxa. ▪ Exercicis d'oscil·lacions, translacions, lateral, amb obstacles, pas protector. ▪ Entrenament amb cinta. ▪ Adaptació de l'entorn. ▪ Assessorament en productes de suport i entrenament i seguiment. Pot ser presencial o telemàtic. Pot ser en grup.
Activitats bàsiques i activitats instrumentals de la vida diària <u>Avaluació:</u> ▪ Índex de Barthel (per a les AVD) o EuroQoL-5D ▪ Escala de Lawton i Brody (activitats instrumentals)	▪ Entrenament específic en tasques. ▪ Entrenament de les ABVD i AIVD. ▪ Entrenament d'estratègies segures durant les activitats amb risc. ▪ Entrenament de tècniques compensatòries, canvis de dominància. ▪ Entrenament de la destresa i la manipulació. ▪ Gradació de les activitats. ▪ Assessorament en productes de suport, entrenament i seguiment. ▪ Adaptació de l'entorn. ▪ Educació sanitària i capacitació al cuidador.

Font: Pla de rehabilitació de Catalunya: abordatge integral del funcionament i la discapacitat (2022)

Annex 17. Abordatge de la disfàgia



CDO: cribatge de disfàgia orofaríngia; CN: cribatge nutricional; DO: disfàgia orofaríngia; FEES: fibroendoscòpia de la deglució; IMC: índex de massa corporal; MECV-V: mètode d'exploració clínica volum-viscositat; MNA: *mini nutritional assessment* reduït; VFS: videofluoroscòpia.

Font: *ESPEN guideline clinical nutrition in neurology* (Burgos et al., 2018)

Annex 18. Escala de sobrecàrrega del cuidador

El test de Zarit, també conegut com l'Escala de sobrecàrrega del cuidador*, avalua la salut emocional i física de les persones que tenen cura d'un familiar o ésser estimat amb una malaltia o discapacitat, i permet identificar possibles signes d'estrès i esgotament (Zarit et al., 1980). Consta de 22 preguntes que descriuen situacions i emocions que l'entorn cuidador pot experimentar. La puntuació quantifica el grau de sobrecàrrega:

- 0-46 punts: absència o sobrecàrrega mínima
- 47-55 punts: sobrecàrrega lleu a moderada
- > 56 punts: sobrecàrrega greu

Preguntes	Puntuació: 0-Mai 1-Poques vegades 2-Algunes vegades 3-Bastants vegades 4-Gairebé sempre
1. Penseu que el vostre familiar us demana més ajuda de la que realment necessita?	
2. Penseu que, a causa del temps que dediqueu al vostre familiar, no teniu prou temps per a vós?	
3. Us sentiu agosarat per intentar compatibilitzar la cura del vostre familiar amb altres responsabilitats (feina, família)?	
4. Sentiu vergonya per la conducta del vostre familiar?	
5. Us sentiu enfadat quan sou a prop del vostre familiar?	
6. Penseu que cuidar el vostre familiar afecta negativament la relació que teniu amb altres membres de la família?	
7. Teniu por pel futur del vostre familiar?	
8. Penseu que el vostre familiar depèn de vós?	
9. Us sentiu tens quan sou a prop del vostre familiar?	
10. Penseu que la vostra salut ha empitjorat a causa d'haver de cuidar el vostre familiar?	
11. Penseu que no teniu tanta intimitat com us agradaria a causa de la cura del vostre familiar?	
12. Penseu que la vostra vida social s'ha vist afectada de manera negativa per haver de cuidar el vostre familiar?	
13. Us sentiu incòmode per haver-vos distanciat de les amistats a causa de la cura del vostre familiar?	
14. Penseu que el vostre familiar us considera l'única persona que pot tenir cura d'ell?	

15. Penseu que no teniu prou ingressos econòmics per afrontar les despeses de cuidar el vostre familiar, a més de les altres despeses?	
16. Penseu que no sereu capaç de cuidar el vostre familiar per molt més temps?	
17. Sentiu que heu perdut el control de la vostra vida des que va començar la malaltia del vostre familiar?	
18. Desitjaríeu poder deixar la cura d'un familiar a una altra persona?	
19. Us sentiu indecís sobre què fer amb el vostre familiar?	
20. Penseu que hauríeu de fer més pel vostre familiar?	
21. Penseu que podríeu cuidar millor el vostre familiar?	
22. Globalment, quin grau de «càrrega» experimenteu pel fet de cuidar el vostre familiar?	

Font: *Relatives of the impaired elderly: correlates of feelings of burden* (Zarit et al., 1980)

* Hi ha disponible la versió reduïda de l'escala de sobrecàrrega del cuidador, formada per 7 ítems, emprada per diversos proveïdors del sistema sanitari de Catalunya.

Annex 19. Glossari de sigles i acrònims

ABVD	Activitats bàsiques de la vida diària
AISS	Atenció integrada social i sanitària
AIVD	Activitats instrumentals de la vida diària
AMS	Atròfia multisistèmica
AMS-C	Atròfia multisistèmica – cerebel·losa
AMS-P	Atròfia multisistèmica – parkinsonisme
APiC	Atenció primària i comunitària
ATDOM	Programa d'atenció domiciliària
AVD	Activitats de la vida diària
CEPA	<i>Consenso de Enfermedad de Parkinson Avanzada</i>
CMBD	Conjunt mínim bàsic de dades
CSUR	Centres, serveis i unitats de referència
DCB	Degeneració corticobasal
DVA	Document de voluntats anticipades
EAP	Equip d'atenció primària
EAT-10	<i>Eating-Assessment Tool-10</i>
FEES	Fibroendoscòpia de la deglució
HADS	<i>Hospital Anxiety and Depression Scale</i>
HC3	Història clínica compartida a Catalunya
ICOMT	Inhibidors de la catecol-O-metiltransferasa
IDC	Inhibidors de la decarboxilasa
IMAO-B	Inhibidors de la monoamina-oxidasa-B
IMC	Índex de massa corporal
MACA	Malaltia crònica avançada
MDS-PD	<i>Movement Disorder Society - Parkinson's disease</i>
MECV-V	Mètode d'exploració clínica volum-viscositat
MIBG	Metaiodobencilguanidina
MIS	<i>Memory Impairment Screen</i>
MP	Malaltia de Parkinson
PA	Parkinsonismes atípics
PADES	Programa d'atenció domiciliària i equips de suport

PCC	Pacient crònic complex
PDA	Planificació de decisions anticipades
PET	<i>Positron Emission Tomography</i>
PIIC	Pla d'intervenció individualitzat compartit
PSP	Paràlisi supranuclear progressiva
PTI	Pla terapèutic individualitzat
REM	<i>Rapid Eye Movement</i>
SAA/Rt-QuIC	<i>Seed amplification assay real-time quaking-induced conversion</i>
SPECT	<i>Single-Photon Emission Computed Tomography</i>
TCSR	Trastorn de la conducta associat amb el son REM
TIRS	Taula d'indicadors de risc social
UPDRS	<i>Unified Parkinson's Disease Rating Scale</i>
VFS	Videofluoroscòpia